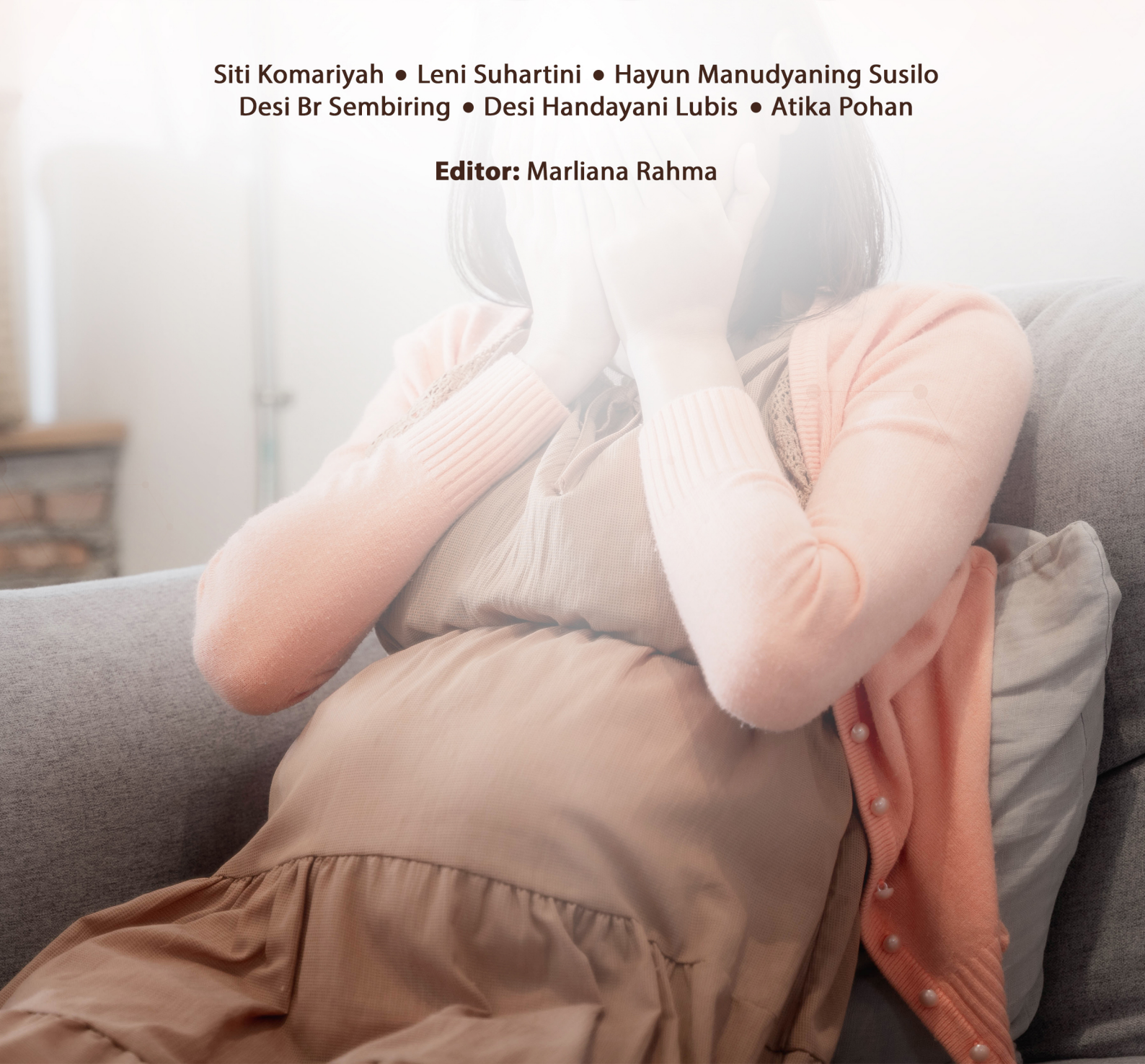


Bunga Rampai

KEHAMILAN RISIKO TINGGI DAN MANAJEMEN KEBIDANAN BERBASIS BUKTI

Siti Komariyah • Leni Suhartini • Hayun Manudyaning Susilo
Desi Br Sembiring • Desi Handayani Lubis • Atika Pohan

Editor: Marliana Rahma



BUNGA RAMPAI KEHAMILAN RISIKO TINGGI DAN MANAJEMEN KEBIDANAN BERBASIS BUKTI

Penulis:

Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.

Bdn. Leni Suhartini, S.ST., M.Kes.

Hayun Manudyaning Susilo, SST., M.Keb.

Bdn. Desi Br Sembiring, SST., M.Tr.Keb.

Bdn. Desi Handayani Lubis, SST., M.Kes.

Bd. Atika Pohan, SST., M.KM.

Editor:

Dr. Bdn. Marlina Rahma, SST., M.Keb.



BUNGA RAMPAI KEHAMILAN RISIKO TINGGI DAN MANAJEMEN KEBIDANAN BERBASIS BUKTI

Penulis: Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.

Bdn. Leni Suhartini, S.ST., M.Kes.

Hayun Manudyaning Susilo, SST., M.Keb.

Bdn. Desi Br Sembiring, SST., M.Tr.Keb.

Bdn. Desi Handayani Lubis, SST., M.Kes.

Bd. Atika Pohan, SST., M.KM.

Editor: Dr. Bdn. Marliana Rahma, SST., M.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7426-13-0

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku Bunga Rampai Kehamilan Risiko Tinggi dan Manajemen Kebidanan Berbasis Bukti dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama para akademisi, praktisi, dan peneliti di bidang kebidanan untuk menghadirkan karya ilmiah yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif serta berlandaskan pada praktik berbasis bukti (evidence-based practice).

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang alamiah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian perempuan akan mengalami kondisi kehamilan dengan risiko tinggi yang berpotensi menimbulkan komplikasi serius. Tingginya angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi masih menjadi perhatian utama dalam sistem kesehatan, baik di tingkat nasional maupun global. Kehamilan risiko tinggi sering kali menjadi faktor penentu terhadap luaran kesehatan maternal dan neonatal, sehingga pemahaman yang komprehensif mengenai deteksi dini, klasifikasi risiko, penanganan tepat, serta manajemen kebidanan yang sistematis mutlak diperlukan.

Hadirnya buku bunga rampai ini dimaksudkan untuk memperkaya literatur kebidanan dengan menyajikan berbagai perspektif yang saling melengkapi. Setiap bab disusun berdasarkan hasil kajian mendalam, analisis terkini, serta integrasi penelitian-penelitian terbaru dalam rentang lima tahun terakhir, sehingga pembaca memperoleh gambaran utuh mengenai tantangan, strategi, serta inovasi dalam asuhan kebidanan pada kehamilan risiko tinggi. Buku ini tidak hanya memberikan landasan teoritis, tetapi juga membekali tenaga kesehatan dengan pengetahuan praktis yang dapat langsung diterapkan dalam pelayanan sehari-hari.

Manajemen kebidanan berbasis bukti menjadi pilar utama dalam buku ini. Setiap intervensi yang disajikan dirancang agar sesuai dengan standar praktik klinis, memperhatikan keselamatan ibu dan janin, serta mendukung pengambilan keputusan yang rasional. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat membantu bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya untuk meningkatkan kualitas asuhan yang diberikan, sekaligus memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi kompleksitas kasus kehamilan risiko tinggi.

Selain itu, buku ini juga diharapkan menjadi rujukan akademik bagi mahasiswa kebidanan, dosen, serta peneliti yang ingin memperdalam pemahaman tentang topik ini. Pendekatan sistematis yang digunakan dalam penyusunan bab-bab di dalamnya diharapkan mampu menumbuhkan pola pikir kritis, keterampilan klinis yang mumpuni,

serta sikap profesional dalam memberikan pelayanan. Dengan mempertemukan konsep ilmiah dan praktik lapangan, buku ini menjadi jembatan antara teori dan aplikasi nyata.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis yang telah berkontribusi dengan karya tulisnya, kepada tim penyusun yang telah bekerja dengan penuh dedikasi, serta kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material dalam penyelesaian buku ini. Tanpa kerjasama dan kolaborasi yang solid, niscaya buku ini tidak akan terwujud.

Akhir kata, besar harapan kami bahwa buku Bunga Rampai Kehamilan Risiko Tinggi dan Manajemen Kebidanan Berbasis Bukti ini dapat memberikan manfaat yang luas, baik dalam ranah akademik maupun praktik profesional. Semoga kehadirannya mampu menjadi sumber inspirasi, referensi terpercaya, dan panduan praktis yang mendukung upaya peningkatan kesehatan ibu dan bayi di Indonesia serta di dunia.

Oktober, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 DEFINISI, KLASIFIKASI, DAN IDENTIFIKASI KEHAMILAN

RISIKO TINGGI.....	1
Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Definisi Kehamilan Risiko Tinggi.....	2
C. Faktor Risiko dalam Kehamilan	4
D. Klasifikasi Kehamilan Risiko Tinggi	6
E. Metode Identifikasi Kehamilan Risiko Tinggi.....	8
F. Tanda dan Gejala Klinis Kehamilan Risiko Tinggi	10
G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Identifikasi Kehamilan Risiko Tinggi.....	12
H. Implikasi dan Dampak Kehamilan Risiko Tinggi	14
I. Pencegahan dan Intervensi Dini	16
J. Simpulan.....	18
K. Referensi.....	19
L. Glosarium	20

CHAPTER 2 MANAJEMEN DIABETES GESTASIONAL DALAM

KEBIDANAN	23
Bdn. Leni Suhartini, S.ST., M.Kes.....	23
A. Pendahuluan/Prolog	23
B. Etiologi	24
C. Patofisiologi	25
D. Riwayat dan pemeriksaan fisik	25
E. Pemeriksaan Glukosa Pada Masa Kehamilan.....	26
F. Pemantauan Glukosa Pada Masa Nifas.....	27
G. Manajemen.....	29
H. Diagnosis diferensial	32
I. Prognosis.....	32
J. Komplikasi.....	32
K. Edukasi pasien	33

L. Contoh Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil Dengan DMG	33
M.Simpulan.....	34
N. Referensi.....	34
O. Glosarium.....	36

CHAPTER 3 PENCEGAHAN KOMPLIKASI PADA PERSALINAN RISIKO

TINGGI.....	37
Hayun Manudyaning Susilo, SST., M.Keb.	37
A. Pendahuluan/Prolog	37
B. Identifikasi Dini Faktor Risiko Persalinan	39
C. Perencanaan Persalinan secara Komprehensif	40
D. Monitoring Ketat Selama Persalinan.....	42
E. Pencegahan Komplikasi Melalui Manajemen Aktif Persalinan	44
F. Penanganan Khusus Komplikasi Umum	45
G. Peran Tim Multidisiplin dalam Pencegahan Komplikasi	47
H. Dukungan Psikososial bagi Ibu dan Keluarga	49
I. Evaluasi dan Monitoring Pasca Persalinan.....	51
J. Simpulan.....	52
K. Referensi.....	54
L. Glosarium.....	54

CHAPTER 4 ASUHAN PADA IBU DENGAN RIWAYAT ABORTUS

BERULANG	57
Bdn. Desi Br Sembiring, SST., M.Tr.Keb.	57
A. Pendahuluan/Prolog	57
B. Etiologi dan Faktor Risiko Abortus Berulang	58
C. Identifikasi dan Diagnosis Dini pada Ibu dengan Abortus Berulang	60
D. Manajemen Klinis pada Ibu dengan Riwayat Abortus Berulang.....	62
E. Peran Bidan dalam Pendampingan dan Edukasi Ibu	64
F. Dukungan Psikososial bagi Ibu dan Pasangan.....	67
G. Monitoring dan Evaluasi Kehamilan Pasca Abortus Berulang	68
H. Strategi Pencegahan Abortus Berulang Jangka Panjang.....	71
I. Simpulan.....	73
J. Referensi.....	74
K. Glosarium	75

CHAPTER 5 MANAJEMEN KEBIDANAN IBU DENGAN PENYAKIT PENYERTA KRONIS	77
Bdn. Desi Handayani Lubis, SST., M.Kes.....	77
A. Pendahuluan/Prolog	77
B. Konsep Dasar Penyakit Kronis pada Kehamilan.....	78
C. Pengkajian Kebidanan pada Ibu dengan Penyakit Kronis.....	79
D. Manajemen Antenatal pada Ibu Hamil dengan Penyakit Kronis	81
E. Manajemen Intranatal untuk Ibu dengan Penyakit Kronis.....	84
F. Manajemen Pascapartum pada Ibu dengan Penyakit Kronis	86
G. Kolaborasi dan Koordinasi dalam Tim Kesehatan.....	88
H. Tantangan dalam Manajemen Kebidanan Penyakit Kronis	90
I. Simpulan.....	92
J. Referensi.....	93
K. Glosarium.....	94
 CHAPTER 6 TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI EVIDENCE- BASED MIDWIFERY DI INDONESIA.....	 97
Bd. Atika Pohan, SST., M.KM.....	97
A. Pendahuluan/Prolog	97
B. Konsep Dasar Evidence-Based Midwifery	99
C. Tantangan Implementasi Evidence-Based Midwifery di Indonesia	101
D. Strategi Implementasi Evidence-Based Midwifery di Indonesia	104
E. Studi Kasus Implementasi Evidence-Based Midwifery di Indonesia.....	107
F. Evaluasi dan Monitoring Implementasi Evidence-Based Midwifery (EBM).....	109
G. Tantangan Masa Depan dan Rekomendasi.....	112
H. Simpulan.....	114
I. Referensi.....	116
J. Glosarium.....	117
 PROFIL PENULIS	 121

CHAPTER 1

DEFINISI, KLASIFIKASI, DAN IDENTIFIKASI KEHAMILAN RISIKO TINGGI

Siti Komariyah, S.SiT., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Memahami konsep kehamilan risiko tinggi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam praktik klinis kebidanan. Istilah "kehamilan risiko tinggi" digunakan untuk menggambarkan kondisi kehamil-an di mana ibu hamil memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan ibu hamil lainnya untuk mengalami berbagai komplikasi yang dapat membahayakan kesehatan ibu maupun janin. Risiko tinggi ini bisa terjadi sebelum kehamilan dimulai atau berkembang selama proses kehamilan dan persalinan. Kondisi ini menuntut perhatian khusus dari tenaga kesehatan seperti bidan, dokter kandungan, dan tenaga medis lainnya agar dapat dilakukan upaya pencegahan, deteksi dini, serta intervensi yang tepat waktu dan efektif.

Dalam konteks kesehatan maternal dan neonatal, kehamilan risiko tinggi merupakan penyumbang terbesar terjadinya berbagai komplikasi serius, seperti preeklamsia berat, perdarahan antepartum dan postpartum, kelahiran prematur, pertumbuhan janin terhambat, hingga kematian ibu dan janin. Oleh karena itu, identifikasi dini terhadap faktor-faktor risiko serta klasifikasi risiko kehamilan yang akurat sangat diperlukan agar komplikasi dapat dicegah atau diminimalisasi dampaknya.

Pentingnya memahami kehamilan risiko tinggi dalam praktik kebidanan tidak hanya terbatas pada aspek klinis atau medis semata, tetapi juga melibatkan dimensi psikologis, sosial, dan edukasi yang integral bagi ibu hamil dan keluarganya. Ketika seorang ibu hamil diidentifikasi memiliki kehamilan berisiko tinggi, ia memerlukan dukungan psikologis tambahan, edukasi kesehatan yang lebih intensif, serta pelayanan kebidanan yang lebih komprehensif dan berkesinambungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa ibu hamil tidak hanya memahami risiko yang dihadapi, tetapi juga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk turut serta dalam upaya pencegahan serta pengelolaan risiko yang mungkin terjadi selama kehamilannya.

Selain itu, pemahaman yang baik tentang kehamilan risiko tinggi memungkinkan tenaga kesehatan kebidanan untuk melakukan perencanaan

intervensi secara lebih tepat sasaran. Dengan mengenali klasifikasi risiko secara dini, tenaga kesehatan dapat menentukan tindakan klinis yang paling sesuai, mulai dari penjadwalan pemeriksaan rutin yang lebih intensif, rujukan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih memadai, hingga tindakan medis preventif yang dapat menekan angka kejadian komplikasi.

Secara global, angka morbiditas dan mortalitas ibu masih tinggi, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sebagian besar penyebab kematian ibu tersebut berhubungan erat dengan faktor risiko tinggi yang tidak teridentifikasi atau terlambat mendapatkan penanganan. Oleh sebab itu, kemampuan tenaga kesehatan untuk mengenali dan mengklasifikasi kehamilan risiko tinggi dengan baik menjadi salah satu strategi kunci dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan janin serta memperbaiki kualitas layanan kesehatan ibu dan anak secara keseluruhan.

B. Definisi Kehamilan Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi merupakan suatu kondisi atau keadaan dalam kehamilan yang disertai berbagai faktor risiko tertentu, baik secara medis maupun non-medis, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi atau masalah kesehatan serius bagi ibu hamil, janin, maupun bayi baru lahir. Secara umum, definisi ini mencakup seluruh kondisi kehamilan di mana ibu, janin, atau keduanya memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan kehamilan yang normal atau fisiologis, yang kemudian memerlukan pemantauan dan intervensi khusus sepanjang periode kehamilan hingga persalinan dan masa nifas.

Berbagai literatur medis dan kebidanan mendefinisikan kehamilan risiko tinggi sebagai kehamilan yang memiliki potensi terjadinya komplikasi signifikan yang dapat membahayakan keselamatan ibu maupun janin. Menurut World Health Organization (WHO), kehamilan risiko tinggi adalah kondisi di mana ibu atau janin memiliki faktor risiko yang secara signifikan meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi atau gangguan dalam kehamilan dan persalinan, seperti preeklamsia, perdarahan, persalinan prematur, pertumbuhan janin terhambat, maupun risiko kematian ibu dan bayi baru lahir.

Definisi serupa juga diungkapkan oleh American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), yang menjelaskan bahwa kehamilan risiko tinggi mencakup kehamilan yang dipengaruhi oleh kondisi medis tertentu seperti hipertensi kronis, diabetes mellitus, penyakit jantung, kelainan imunologis, serta kondisi kehamilan tertentu seperti preeklamsia, kehamilan kembar, kehamilan pada usia ibu yang terlalu muda (di bawah 20 tahun) atau terlalu tua (di atas 35 tahun), serta riwayat komplikasi pada kehamilan sebelumnya.

Dalam literatur kebidanan di Indonesia, Kementerian Kesehatan RI mendefinisikan kehamilan-an risiko tinggi sebagai kehamilan dengan ancaman bahaya yang lebih besar daripada kehamilan fisiologis, baik karena faktor ibu (seperti usia, paritas, dan kondisi kesehatan ibu), faktor janin (seperti janin kembar, kelainan kongenital, pertumbuhan janin terhambat), maupun faktor lingkungan (seperti akses terbatas terhadap layanan kesehatan yang berkualitas). Definisi ini mencakup kondisi yang memerlukan perhatian dan tindakan khusus dari tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang dapat berakibat fatal bagi ibu dan janin.

Secara klinis, kehamilan risiko tinggi didefinisikan melalui serangkaian indikator atau faktor risiko yang dapat dikenali sejak sebelum kehamilan terjadi (faktor preconsepsi), selama masa kehamilan, hingga menjelang persalinan. Beberapa contoh faktor tersebut meliputi riwayat kesehatan ibu sebelumnya, seperti adanya penyakit kronis (hipertensi, diabetes, kelainan ginjal), riwayat kehamilan dengan komplikasi sebelumnya (abortus berulang, preeklamsia, persalinan prematur), faktor usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, paritas tinggi, status gizi yang buruk, kondisi sosial ekonomi yang rendah, serta akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Jika salah satu atau lebih faktor ini teridentifikasi, maka kehamilan tersebut dikategorikan sebagai kehamilan berisiko tinggi yang memerlukan pemantauan ketat serta rujukan yang tepat.

Kehamilan risiko tinggi juga dapat diidentifikasi berdasarkan adanya kelainan atau gangguan selama masa kehamilan yang timbul secara akut, seperti preeklamsia berat, eklamsia, perdarahan antepartum akibat plasenta previa atau solusio plasenta, ketuban pecah dini, infeksi serius, maupun kondisi janin yang mengalami gangguan pertumbuhan atau distress janin yang terdeteksi selama pemeriksaan antenatal. Semua kondisi ini secara langsung mengindikasikan bahwa kehamilan tersebut memerlukan intervensi medis segera guna mengurangi risiko terjadinya komplikasi serius hingga kematian.

Secara umum, definisi kehamilan risiko tinggi tidak hanya bersifat klinis atau medis semata, tetapi juga mencakup berbagai aspek sosial dan psikologis. Kehamilan risiko tinggi sering kali menimbulkan beban psikologis yang besar bagi ibu dan keluarganya, seperti kecemasan yang tinggi, stres, dan ketakutan akan keselamatan diri maupun janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, definisi kehamilan risiko tinggi juga mencakup pentingnya pendekatan holistik dalam memberikan pelayanan kebidanan, termasuk pemberian edukasi yang intensif, dukungan emosional dan psikososial, serta penguatan kapasitas keluarga dalam mendukung ibu menjalani masa kehamilannya dengan aman dan sehat.

Dengan adanya definisi yang jelas dan terstandar dari kehamilan risiko tinggi menurut berbagai referensi medis dan kebidanan, maka tenaga kesehatan

khususnya bidan, dapat mengenali secara dini berbagai faktor risiko tersebut, sehingga intervensi pencegahan maupun pengelolaan risiko dapat dilakukan secara efektif. Pemahaman definisi ini juga penting bagi masyarakat secara luas agar lebih meningkatkan kesadaran dalam mengenali tanda-tanda bahaya selama kehamilan, sehingga akses terhadap layanan kesehatan yang tepat waktu bisa tercapai, serta pada akhirnya mampu menurunkan angka kejadian komplikasi dan kematian ibu serta bayi baru lahir.

C. Faktor Risiko dalam Kehamilan

Dalam memahami kehamilan risiko tinggi, penting untuk mengenali berbagai faktor risiko yang bisa meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Faktor-faktor ini secara garis besar terbagi menjadi dua kategori utama, yakni faktor medis dan non-medis. Kedua kategori ini saling berkaitan dan sama pentingnya dalam menentukan tingkat risiko suatu kehamil-an.

Faktor risiko medis meliputi berbagai kondisi kesehatan ibu yang sudah ada sebelum kehamilan atau yang timbul selama kehamilan berlangsung. Salah satu faktor risiko medis yang umum adalah usia ibu yang ekstrem, yaitu usia terlalu muda (di bawah 20 tahun) atau terlalu tua (di atas 35 tahun). Pada usia remaja, tubuh ibu belum sepenuhnya matang secara fisik maupun psikologis untuk menghadapi tuntutan kehamilan, sehingga meningkatkan risiko komplikasi seperti anemia berat, preeklamsia, persalinan prematur, dan gangguan pertumbuhan janin. Sebaliknya, pada usia yang lebih tua, terutama di atas 35 tahun, terdapat peningkatan risiko gangguan kromosom janin, keguguran spontan, diabetes gestasional, hipertensi kronis, serta komplikasi lain yang dapat membahayakan ibu maupun janin.

Selain usia, riwayat kesehatan ibu juga merupakan faktor risiko yang penting diperhatikan. Ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi kronis, penyakit jantung, penyakit ginjal, atau penyakit autoimun (seperti lupus eritematosus sistemik), berisiko lebih tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan. Misalnya, ibu dengan diabetes mellitus dapat mengalami komplikasi berupa makrosomia janin (bayi lahir dengan berat badan berlebih), hipoglikemia pada bayi baru lahir, serta peningkatan risiko preeklamsia dan persalinan dengan tindakan bedah sesar. Sementara itu, ibu dengan hipertensi kronis cenderung mengalami peningkatan risiko preeklamsia berat, gangguan pertumbuhan janin, serta persalinan prematur.

Selain penyakit kronis, riwayat komplikasi kehamilan sebelumnya juga menjadi faktor risiko signifikan. Ibu yang sebelumnya mengalami preeklamsia atau eklamsia, persalinan prematur, abortus berulang, kehamilan ektopik, atau riwayat perdarahan

pascapersalinan, akan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi serupa pada kehamilan berikutnya. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk melakukan anamnesis atau wawancara mendalam terhadap riwayat kehamilan terdahulu agar dapat mengidentifikasi risiko lebih dini, sehingga penanganan preventif dan rencana persalinan yang aman dapat disiapkan secara matang.

Kondisi lain yang termasuk dalam faktor risiko medis adalah kehamilan multipel atau kehamilan kembar. Kehamilan kembar meningkatkan risiko terjadinya komplikasi seperti persalinan prematur, ketuban pecah dini, plasenta previa (plasenta yang menutupi jalan lahir), solusio plasenta (pelepasan plasenta sebelum waktunya), gangguan pertumbuhan janin, serta risiko tinggi perdarahan postpartum. Oleh sebab itu, kehamilan kembar harus dipantau secara lebih ketat sepanjang masa kehamilan hingga persalinan untuk memastikan keselamatan ibu dan janin.

Di samping faktor medis, faktor non-medis juga memiliki peran penting dalam menentukan risiko suatu kehamilan. Salah satu faktor non-medis yang signifikan adalah faktor sosial-ekonomi. Ibu yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi rendah cenderung memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, baik dari segi jarak, biaya, maupun informasi kesehatan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan kurangnya pemeriksaan kehamilan secara teratur (antenatal care), sehingga berbagai komplikasi kehamilan tidak terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya meningkatkan risiko mortalitas dan morbiditas ibu maupun janin.

Selain itu, rendahnya status sosial-ekonomi juga berkaitan erat dengan kondisi gizi ibu yang buruk. Gizi buruk pada ibu hamil dapat menyebabkan komplikasi serius seperti anemia berat, defisiensi nutrisi penting, pertumbuhan janin terhambat (IUGR), berat bayi lahir rendah (BBLR), serta berbagai gangguan lainnya yang berisiko tinggi terhadap keselamatan ibu dan bayi. Oleh karena itu, dukungan sosial-ekonomi, edukasi gizi, serta pemberian layanan kesehatan yang inklusif dan terjangkau sangat penting untuk menurunkan risiko kehamilan.

Faktor non-medis lain yang tidak kalah penting adalah aspek psikologis dan emosional ibu selama kehamilan. Tingginya tingkat stres, kecemasan, depresi, serta kurangnya dukungan emosional dari pasangan maupun keluarga terbukti dapat meningkatkan risiko terjadinya komplikasi kehamilan. Stres kronis pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan hormon, peningkatan tekanan darah, serta gangguan sistem imun yang berisiko terhadap janin dan menyebabkan persalinan prematur. Oleh karena itu, dalam pelayanan kesehatan ibu hamil, perlu pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik tetapi juga memperhatikan kesejahteraan emosional dan psikologis ibu.

Kondisi lingkungan dan pola hidup ibu juga berperan sebagai faktor risiko penting. Paparan terhadap zat-zat berbahaya seperti rokok, alkohol, obat-obatan terlarang, polusi udara, serta paparan bahan kimia toksik dapat menyebabkan gangguan perkembangan janin, kelainan kongenital, hingga persalinan prematur. Oleh karena itu, edukasi mengenai pola hidup sehat, pencegahan paparan zat berbahaya, serta penyediaan lingkungan hidup yang aman dan sehat sangat diperlukan untuk mengurangi risiko komplikasi kehamilan.

D. Klasifikasi Kehamilan Risiko Tinggi

Klasifikasi kehamilan risiko tinggi merupakan metode pengelompokan yang digunakan oleh tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi serta menentukan tingkat potensi komplikasi yang dapat dialami seorang ibu hamil selama masa kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Klasifikasi ini penting untuk diterapkan secara sistematis agar tenaga kesehatan dapat mengambil keputusan klinis yang tepat dalam hal intervensi, rujukan, serta pemantauan kondisi ibu dan janin secara ketat. Secara umum, klasifikasi kehamilan risiko tinggi mengacu pada standar yang diakui secara internasional maupun nasional, dengan pembagian yang biasanya terdiri dari risiko ringan, risiko sedang, dan risiko berat.

Kehamilan dengan risiko ringan biasanya mengacu pada kondisi di mana seorang ibu memiliki satu atau beberapa faktor risiko yang relatif kecil dan dapat ditangani dengan pemantauan reguler serta pelayanan kebidanan rutin. Contoh kondisi yang termasuk dalam kategori ini adalah ibu dengan usia sedikit di bawah 20 tahun atau sedikit di atas 35 tahun tanpa adanya komplikasi medis lain yang signifikan. Faktor-faktor lain seperti riwayat perdarahan ringan pada kehamilan sebelumnya, riwayat anemia ringan, atau ibu dengan status gizi sedikit kurang optimal juga termasuk dalam kategori risiko ringan. Dalam kategori ini, ibu cukup menjalani pemeriksaan antenatal secara rutin, diberikan edukasi kesehatan yang memadai, serta dimonitor secara teratur untuk memastikan tidak ada perkembangan ke arah komplikasi yang lebih serius.

Selanjutnya, kehamilan dengan risiko sedang adalah kondisi di mana ibu memiliki beberapa faktor risiko yang lebih serius, namun masih memungkinkan untuk ditangani pada tingkat pelayanan kesehatan primer atau sekunder dengan pemantauan intensif. Contoh yang umum ditemukan adalah ibu dengan riwayat preeklamsia ringan pada kehamilan sebelumnya, riwayat persalinan prematur yang tidak ekstrem, ibu dengan diabetes gestasional yang terkontrol dengan baik, atau ibu dengan hipertensi yang stabil dan dapat dikendalikan dengan obat-obatan. Dalam kondisi risiko sedang ini, ibu membutuhkan pemantauan antenatal yang lebih intensif, pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan laboratorium berkala,

ultrasonografi lebih sering untuk mengevaluasi kondisi janin, serta konsultasi rutin dengan spesialis kebidanan atau dokter kandungan. Meskipun demikian, ibu biasanya masih dapat menjalani persalinan di fasilitas kesehatan tingkat primer atau sekunder dengan kesiapan rujukan jika terjadi komplikasi yang tidak terduga.

Kategori tertinggi, yaitu kehamilan dengan risiko berat atau tinggi, merupakan kondisi di mana ibu memiliki satu atau lebih faktor risiko yang sangat serius, yang dapat menyebabkan komplikasi berat, bahkan mengancam nyawa ibu maupun janin jika tidak segera ditangani secara optimal. Kondisi yang masuk dalam kategori risiko berat ini antara lain ibu dengan hipertensi kronis berat, preeklamsia berat atau eklamsia, diabetes mellitus tipe 1 atau 2 yang tidak terkontrol, riwayat penyakit jantung berat, kehamilan dengan kelainan anatomi seperti plasenta previa total, kehamilan dengan pertumbuhan janin terhambat berat (severe IUGR), atau kehamilan dengan komplikasi serius seperti kehamilan kembar siam, oligohidramnion berat, polihidramnion berat, serta ibu dengan riwayat perdarahan postpartum berat di kehamilan sebelumnya. Pada kategori risiko tinggi ini, pelayanan antenatal harus dilakukan oleh tim spesialis multidisiplin, termasuk dokter spesialis obstetri-ginekologi, spesialis penyakit dalam, spesialis anak, dan ahli anestesi, serta dilengkapi fasilitas perawatan intensif ibu dan bayi baru lahir yang memadai.

Di Indonesia, klasifikasi kehamilan risiko tinggi mengacu pada pedoman dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dituangkan dalam berbagai panduan pelayanan kebidanan dan obstetri. Sistem klasifikasi ini digunakan untuk mengarahkan tenaga kesehatan di berbagai tingkat layanan, mulai dari tingkat puskesmas, klinik bersalin, hingga rumah sakit umum dan rumah sakit rujukan tertinggi. Menurut pedoman tersebut, tenaga kesehatan, terutama bidan, harus mampu melakukan skrining risiko secara awal dengan menggunakan kartu skor Poedji Rochjati atau formulir serupa yang memuat daftar faktor risiko tertentu. Kartu skor tersebut berisi daftar variabel risiko seperti usia ibu, paritas, riwayat obstetri, serta kondisi medis tertentu, dengan nilai poin tertentu yang akan menunjukkan tingkat risiko secara kuantitatif.

Jika berdasarkan kartu skor tersebut ibu dikategorikan memiliki skor risiko rendah, maka cukup diberikan pelayanan antenatal dasar secara rutin. Bila ibu diklasifikasikan dalam risiko sedang, maka perlu dilakukan pemantauan yang lebih intensif serta rencana persalinan di fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan untuk menangani komplikasi tingkat sedang. Namun, jika ibu masuk dalam kategori risiko tinggi, maka harus segera dilakukan rujukan ke rumah sakit dengan fasilitas dan tim yang mampu menangani komplikasi berat secara multidisiplin dan komprehensif.

Secara internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga memberikan pedoman serupa dengan klasifikasi tiga tingkat, yang sering digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan ibu di berbagai negara. WHO menekankan pentingnya deteksi dini faktor risiko pada setiap ibu hamil untuk memastikan bahwa ibu dengan risiko tinggi menerima pelayanan kesehatan secara optimal sejak awal kehamilan hingga persalinan dan masa nifas.

E. Metode Identifikasi Kehamilan Risiko Tinggi

Identifikasi dini kehamilan risiko tinggi merupakan bagian esensial dari praktik kebidanan yang bertujuan untuk mencegah serta mengelola komplikasi yang mungkin terjadi selama masa kehamilan, persalinan, maupun periode nifas. Proses ini membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis agar risiko yang ada dapat dikenali sejak dini, sehingga intervensi medis yang tepat dapat dilakukan untuk melindungi keselamatan ibu dan janin. Beberapa pendekatan utama yang digunakan untuk mengidentifikasi kehamilan risiko tinggi mencakup penggunaan kartu skor antenatal, pemeriksaan laboratorium, serta pemeriksaan ultrasonografi (USG).

Kartu skor antenatal merupakan alat penapisan yang paling umum digunakan oleh tenaga kesehatan, terutama di tingkat pelayanan primer seperti puskesmas atau klinik bersalin. Di Indonesia, salah satu instrumen yang telah dikenal luas adalah kartu skor Poedji Rochjati, yang berfungsi untuk menilai secara kuantitatif risiko yang dimiliki seorang ibu hamil berdasarkan sejumlah variabel. Instrumen ini terdiri dari serangkaian pertanyaan dan kategori yang mencakup berbagai aspek kesehatan ibu, riwayat obstetri sebelumnya, usia ibu saat kehamilan, jumlah anak yang dilahirkan sebelumnya (paritas), kondisi kesehatan umum ibu, serta adanya penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, atau penyakit jantung. Setiap variabel memiliki skor tertentu, dan total skor yang dihasilkan akan menentukan apakah kehamilan tersebut tergolong dalam kategori risiko ringan, sedang, atau tinggi. Keuntungan dari penggunaan kartu skor ini adalah kesederhanaannya, kemudahan aplikasinya, serta efektivitasnya dalam membantu bidan atau tenaga kesehatan untuk segera mengambil keputusan apakah diperlukan pemantauan lebih lanjut, konsultasi dengan dokter spesialis, atau bahkan merujuk ibu hamil ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Selain kartu skor antenatal, pendekatan penting lain yang digunakan dalam identifikasi kehamilan risiko tinggi adalah melalui pemeriksaan laboratorium secara rutin selama kunjungan antenatal. Pemeriksaan ini mencakup berbagai tes yang dirancang untuk mendeteksi dini gangguan medis atau kondisi abnormal yang dapat membahayakan kehamilan, seperti anemia, diabetes gestasional, infeksi

saluran kemih, penyakit menular seksual, serta gangguan fungsi hati dan ginjal. Beberapa pemeriksaan dasar yang rutin dilakukan antara lain pemeriksaan kadar hemoglobin (Hb) untuk mendeteksi anemia, pemeriksaan gula darah puasa atau toleransi glukosa oral untuk identifikasi diabetes gestasional, pemeriksaan urin untuk deteksi proteinuria dan infeksi saluran kemih, serta skrining infeksi seperti HIV, hepatitis B, dan sifilis. Adanya temuan abnormal dalam pemeriksaan laboratorium tersebut akan mengarahkan tenaga kesehatan untuk mengambil langkah lanjutan, seperti memberikan intervensi medis yang tepat, meningkatkan intensitas pemantauan kehamilan, atau bahkan merujuk pasien ke fasilitas layanan kesehatan yang lebih tinggi agar penanganan dapat dilakukan secara komprehensif.

Metode lain yang sangat penting dalam identifikasi kehamilan risiko tinggi adalah pemeriksaan ultrasonografi (USG). Pemeriksaan ini merupakan teknik pencitraan yang memungkinkan tenaga kesehatan mendapatkan gambaran yang akurat tentang kondisi janin, plasenta, cairan ketuban, serta kondisi rahim ibu secara real-time. USG sangat berguna dalam mendeteksi berbagai kondisi yang berpotensi menyebabkan risiko tinggi dalam kehamilan, misalnya plasenta previa (plasenta yang menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir), gangguan pertumbuhan janin atau intrauterine growth restriction (IUGR), kehamilan kembar atau multipel yang membawa risiko lebih tinggi dibanding kehamilan tunggal, kelainan kongenital janin yang serius, serta gangguan cairan ketuban seperti oligohidramnion (jumlah cairan ketuban yang sedikit) atau polihidramnion (jumlah cairan ketuban yang berlebihan). Dengan deteksi dini melalui pemeriksaan USG, tenaga kesehatan dapat lebih awal mengembangkan rencana pengelolaan klinis yang tepat, mulai dari pemantauan intensif hingga rencana persalinan yang lebih terstruktur di rumah sakit dengan fasilitas yang memadai.

Pemeriksaan ultrasonografi umumnya dilakukan beberapa kali selama masa kehamilan, tergantung pada kondisi ibu dan janin serta tingkat risiko yang teridentifikasi. Pemeriksaan pada trimester pertama digunakan terutama untuk memastikan usia kehamilan yang akurat, mendeteksi kehamilan multipel, dan menilai kemungkinan risiko awal seperti kehamilan ektopik atau keguguran terancam. Pemeriksaan USG pada trimester kedua bertujuan terutama untuk mendeteksi kelainan anatomi janin, sedangkan pemeriksaan pada trimester ketiga lebih difokuskan untuk mengevaluasi pertumbuhan janin, posisi janin, letak plasenta, serta jumlah cairan ketuban. Adanya temuan abnormal dalam pemeriksaan USG ini dapat segera mengarahkan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan tindak lanjut yang lebih intensif, termasuk melakukan pemeriksaan tambahan seperti doppler ultrasonografi untuk mengevaluasi aliran darah janin, serta melakukan konsultasi dengan spesialis kebidanan dan kandungan.

Selain tiga pendekatan utama tersebut, identifikasi kehamilan risiko tinggi juga memerlukan pendekatan yang bersifat multidisiplin, di mana tenaga kesehatan yang terlibat tidak hanya bidan atau dokter kandungan, melainkan juga spesialis lain seperti ahli gizi, psikolog, spesialis penyakit dalam, ahli anestesi, dan bahkan tenaga kesehatan masyarakat. Pendekatan multidisiplin ini memastikan bahwa faktor risiko non-medis, seperti status gizi buruk, stres psikososial, atau kondisi lingkungan yang tidak mendukung, juga diidentifikasi dan dikelola dengan baik sebagai bagian integral dari upaya pencegahan komplikasi kehamilan.

Keseluruhan metode ini, baik kartu skor antenatal, pemeriksaan laboratorium, maupun pemeriksaan ultrasonografi, memberikan pendekatan komprehensif yang saling melengkapi dalam upaya mendeteksi secara dini kehamilan risiko tinggi. Dengan penggunaan metode-metode ini secara sistematis dan terintegrasi, tenaga kesehatan dapat mengambil tindakan preventif secara lebih dini dan efektif, sehingga mampu menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayi yang baru lahir secara signifikan.

F. Tanda dan Gejala Klinis Kehamilan Risiko Tinggi

Deteksi dini terhadap tanda-tanda dan gejala klinis pada kehamilan risiko tinggi menjadi salah satu kunci penting dalam pencegahan dan penanganan komplikasi kehamilan secara efektif. Tenaga kesehatan, terutama bidan dan dokter yang bertugas dalam pelayanan antenatal, harus mampu mengenali berbagai tanda serta gejala klinis yang khas dari kondisi kehamilan risiko tinggi. Kemampuan ini sangat krusial karena semakin cepat tanda dan gejala klinis ini dikenali, maka semakin besar pula peluang untuk memberikan intervensi yang tepat waktu dan efektif.

Salah satu tanda klinis yang paling sering dijumpai dan penting untuk diamati adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi yang muncul selama kehamilan dapat menjadi indikator adanya preeklampsia atau bahkan eklampsia, yaitu komplikasi serius yang mengancam keselamatan ibu dan janin. Gejala yang sering menyertai hipertensi dalam kehamilan di antaranya sakit kepala hebat, pandangan kabur atau gangguan penglihatan, nyeri perut bagian atas (khususnya di area ulu hati), mual muntah yang terus-menerus, serta pembengkakan (edema) yang signifikan di wajah, tangan, atau kaki. Apabila tanda-tanda ini diabaikan atau tidak dikenali sejak awal, maka risiko komplikasi serius seperti kejang, gagal ginjal, gangguan fungsi hati, hingga kematian ibu maupun janin bisa meningkat tajam.

Selain hipertensi, tanda klinis lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah adanya perdarahan selama masa kehamilan, baik di trimester pertama, kedua,

maupun ketiga. Perdarahan pada trimester pertama dapat menandakan ancaman keguguran, kehamilan ektopik (kehamilan di luar rahim), atau kelainan trofoblas seperti mola hidatidosa. Sedangkan perdarahan di trimester kedua atau ketiga sering dikaitkan dengan komplikasi serius seperti plasenta previa (plasenta yang menutupi jalan lahir), solusio plasenta (plasenta yang terlepas sebelum waktunya), atau bahkan ruptur uteri (pecahnya dinding rahim). Setiap bentuk perdarahan, terutama yang disertai nyeri perut atau kram hebat, memerlukan penanganan darurat karena dapat dengan cepat berkembang menjadi kondisi yang mengancam nyawa.

Nyeri perut hebat yang persisten atau nyeri yang tidak biasa juga menjadi salah satu gejala klinis penting yang patut diwaspadai. Nyeri hebat yang dirasakan secara mendadak di perut bagian bawah, terutama disertai pusing atau lemah, bisa menandakan adanya kehamilan ektopik yang telah pecah, suatu kondisi emergensi yang membutuhkan tindakan segera. Sementara itu, nyeri perut yang tajam dan mendadak di bagian atas perut (epigastrium), terutama pada trimester akhir, bisa menjadi tanda awal dari preeklampsia berat atau sindrom HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count). Kondisi ini membutuhkan pengelolaan intensif di fasilitas kesehatan dengan peralatan lengkap untuk mencegah komplikasi fatal.

Tanda lain yang umum dijumpai pada kehamilan risiko tinggi adalah gangguan pertumbuhan janin, yang bisa diketahui melalui pengukuran tinggi fundus uteri atau pemeriksaan ultrasonografi (USG). Gangguan pertumbuhan janin ini bisa berupa pertumbuhan janin yang terhambat (intrauterine growth restriction/IUGR) maupun janin besar (makrosomia), yang keduanya memiliki implikasi klinis yang serius. Pada janin dengan pertumbuhan terhambat, risiko kematian janin dalam kandungan meningkat signifikan, sementara janin besar berisiko mengalami komplikasi selama proses persalinan seperti distosia bahu atau trauma lahir. Pemantauan ketat dan identifikasi dini terhadap kondisi ini dapat membantu pengelolaan klinis secara lebih optimal dan persiapan persalinan yang lebih aman.

Gejala klinis lain yang harus diwaspadai adalah penurunan gerakan janin. Ibu hamil yang merasakan penurunan drastis atau tiba-tiba pada pola gerakan janinnya perlu segera diperiksa lebih lanjut. Kondisi ini bisa menjadi tanda adanya hipoksia janin (kekurangan oksigen), gawat janin, atau bahkan kematian janin dalam kandungan. Dalam situasi tersebut, pemeriksaan tambahan seperti kardiotokografi (CTG), USG doppler, atau pemeriksaan biofisik janin harus segera dilakukan untuk memastikan kondisi janin dan menentukan langkah intervensi selanjutnya.

Selain gejala-gejala klinis medis, gejala psikologis yang serius seperti kecemasan berlebihan, depresi, dan stres yang berkepanjangan juga merupakan

tanda-tanda yang tidak boleh diabaikan. Kondisi psikologis ibu yang buruk tidak hanya memengaruhi kesehatan mental dan emosional ibu, tetapi juga dapat berdampak negatif pada kehamilan, meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, serta gangguan perkembangan janin. Deteksi dini gangguan psikologis ini memungkinkan tenaga kesehatan memberikan intervensi atau konseling yang tepat, membantu ibu menjalani masa kehamilan dengan kondisi mental yang lebih baik.

Selain itu, kondisi seperti demam tinggi yang terus-menerus, nyeri hebat saat berkemih (disuria), serta urin keruh atau berdarah juga merupakan tanda-tanda klinis penting yang dapat mengindikasikan infeksi saluran kemih yang berat atau infeksi sistemik lainnya, yang jika tidak segera ditangani dapat memicu persalinan prematur atau sepsis. Pemeriksaan laboratorium untuk mengidentifikasi infeksi, seperti pemeriksaan darah dan kultur urin, harus segera dilakukan untuk memastikan diagnosis dan pemberian terapi antibiotik yang tepat.

G. Peran Tenaga Kesehatan dalam Identifikasi Kehamilan Risiko Tinggi

Tenaga kesehatan, terutama bidan, dokter spesialis kandungan (dokter obstetri-ginekologi), dokter umum, serta tenaga kesehatan pendukung lainnya, memainkan peran sentral dalam upaya identifikasi dini, pemantauan rutin, serta manajemen kehamilan risiko tinggi. Peran yang dijalankan tenaga kesehatan ini tidak hanya terbatas pada pemberian pelayanan klinis saja, tetapi juga mencakup aspek edukasi, konseling, advokasi, hingga koordinasi lintas disiplin yang menyeluruh dalam pelayanan kesehatan ibu dan janin.

Bidan memiliki posisi strategis dalam proses identifikasi awal kehamilan risiko tinggi, terutama karena merekalah tenaga kesehatan yang paling dekat dan mudah dijangkau oleh ibu hamil dalam layanan antenatal care (ANC) primer. Dalam kunjungan ANC awal, bidan bertanggung jawab melakukan anamnesis mendalam untuk menggali riwayat kesehatan ibu, riwayat obstetri sebelumnya, faktor sosial-ekonomi, gaya hidup, serta berbagai kondisi medis yang mungkin menjadi pemicu risiko tinggi dalam kehamilan. Selain anamnesis, bidan juga melakukan pemeriksaan fisik lengkap seperti pengukuran tekanan darah, pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan posisi dan gerak janin, serta skrining sederhana seperti pemeriksaan protein urin atau gula darah menggunakan alat diagnostik cepat.

Dalam tugasnya, bidan juga memanfaatkan instrumen penapisan sederhana seperti kartu skor antenatal atau formulir risiko kehamilan yang sudah terstandar secara nasional. Melalui kartu skor ini, bidan dapat dengan mudah mengidentifikasi tanda-tanda bahaya yang muncul sejak dini, misalnya hipertensi, anemia, infeksi, atau tanda-tanda preeklampsia. Setelah proses identifikasi, bidan bertanggung

jawab memberikan edukasi dan konseling awal kepada ibu hamil tentang arti penting dari temuan tersebut, perlunya pemantauan lebih lanjut, serta rujukan tepat waktu ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap apabila diperlukan.

Dokter kandungan atau dokter spesialis obstetri-ginekologi memiliki peran yang lebih spesifik dan kompleks, terutama dalam melakukan pemeriksaan lanjut atau tindak lanjutan pada ibu yang telah diidentifikasi memiliki risiko tinggi. Dokter spesialis ini melakukan evaluasi menyeluruh menggunakan berbagai pemeriksaan tambahan seperti ultrasonografi (USG) untuk menilai pertumbuhan janin secara lebih mendalam, Doppler USG untuk memantau aliran darah janin dan plasenta, pemeriksaan laboratorium yang lengkap, serta pemeriksaan diagnostik lanjutan seperti kardiotokografi (CTG) untuk memonitor kondisi janin secara lebih detail. Dokter kandungan juga menentukan klasifikasi tingkat risiko kehamilan berdasarkan temuan klinis dan hasil investigasi yang didapatkan, apakah termasuk risiko ringan, sedang, atau berat, sehingga strategi pemantauan dan intervensi yang tepat bisa segera dirancang dan diterapkan.

Selain menentukan klasifikasi risiko, dokter kandungan juga berperan penting dalam menyusun rencana tatalaksana kehamilan risiko tinggi. Hal ini mencakup penjadwalan rutin untuk pemeriksaan antenatal yang lebih sering, penyesuaian terapi atau medikasi khusus yang dibutuhkan (seperti pemberian antihipertensi, suplementasi zat besi, atau terapi insulin untuk ibu hamil dengan diabetes gestasional), serta mempersiapkan ibu untuk kemungkinan skenario persalinan yang aman, seperti induksi persalinan dini atau bahkan operasi caesar apabila dibutuhkan. Dokter kandungan juga bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi secara multidisiplin dengan spesialis lain seperti ahli penyakit dalam, ahli jantung, atau ahli neonatologi, tergantung dari kondisi medis ibu dan janin yang dihadapi.

Di sisi lain, dokter umum juga memiliki peran penting sebagai garda depan dalam mengidentifikasi kehamilan berisiko tinggi, terutama di daerah-daerah dengan fasilitas kesehatan terbatas. Dokter umum berfungsi sebagai tenaga kesehatan yang memberikan deteksi awal, stabilisasi awal bila ada komplikasi akut, serta merujuk pasien ke fasilitas yang memiliki layanan spesialisasi lengkap. Peran dokter umum juga mencakup edukasi masyarakat, memberikan pemahaman kepada ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya selama kehamilan yang perlu segera dilaporkan dan diperiksa.

Selain tenaga kesehatan klinis, tenaga kesehatan lain seperti perawat, tenaga laboratorium, tenaga gizi, serta tenaga kesehatan masyarakat memiliki peran pendukung yang tidak kalah penting dalam proses identifikasi dan manajemen kehamilan risiko tinggi. Tenaga laboratorium bertugas melakukan pemeriksaan penunjang, seperti analisis darah, urin, dan pemeriksaan lainnya yang membantu

dokter dan bidan dalam membuat diagnosis yang tepat. Tenaga gizi bertugas memberikan pendampingan serta konseling gizi pada ibu hamil, terutama pada ibu dengan risiko tinggi seperti obesitas, anemia, diabetes gestasional, atau malnutrisi kronis. Sementara itu, tenaga kesehatan masyarakat berperan aktif dalam memberikan edukasi, sosialisasi tanda bahaya kehamilan di tingkat komunitas, serta memastikan bahwa ibu hamil melakukan kunjungan ANC secara teratur.

Koordinasi yang baik antara berbagai tenaga kesehatan ini menjadi kunci utama dalam proses identifikasi dini, pemantauan rutin, dan manajemen kehamilan risiko tinggi. Keberhasilan dalam identifikasi awal, disertai pemantauan yang konsisten dan terencana secara multidisiplin, terbukti mampu menurunkan risiko komplikasi serius yang mengancam keselamatan ibu dan janin. Dalam menjalankan peran ini, tenaga kesehatan juga harus didukung oleh sistem rujukan yang efektif, fasilitas kesehatan yang memadai, serta kebijakan yang jelas untuk memastikan bahwa setiap ibu hamil dengan risiko tinggi mendapatkan pelayanan yang optimal, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan klinisnya.

H. Implikasi dan Dampak Kehamilan Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi merupakan kondisi yang memerlukan perhatian khusus karena membawa implikasi serius, baik jangka pendek maupun jangka panjang, terhadap kesehatan ibu, janin, hingga bayi yang dilahirkan. Dampak ini sangat bervariasi tergantung pada jenis faktor risiko yang dimiliki ibu selama kehamilan, tingkat keparahan kondisi klinis, serta kecepatan intervensi yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Oleh karena itu, memahami dampak dari kehamilan risiko tinggi menjadi penting dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan manajemen kehamilan yang optimal.

Dampak jangka pendek dari kehamilan risiko tinggi terhadap ibu bisa sangat kompleks. Dalam banyak kasus, kondisi kesehatan ibu selama kehamilan dapat mengalami perburukan yang cepat. Misalnya, ibu hamil dengan hipertensi kronik atau preeklampsia berisiko tinggi mengalami komplikasi akut seperti eklampsia, yaitu kejang yang membahayakan nyawa ibu maupun janin, atau komplikasi yang mengarah pada kerusakan organ tubuh seperti gagal ginjal akut, gagal hati, atau edema paru. Selain hipertensi, ibu dengan diabetes gestasional berisiko mengalami komplikasi metabolik akut seperti ketoasidosis diabetik yang memerlukan perawatan intensif dan intervensi medis yang cepat. Kondisi lainnya seperti perdarahan antepartum akibat plasenta previa atau solusio plasenta dapat menyebabkan ibu mengalami anemia berat hingga syok hemoragik yang membahayakan keselamatan ibu jika tidak segera ditangani dengan intervensi bedah maupun transfusi darah.

Selain dampak fisik, ibu dengan kehamilan risiko tinggi juga cenderung mengalami stres psikologis yang signifikan, terutama kecemasan, depresi, dan ketidakpastian tentang keselamatan dirinya dan bayinya. Kondisi psikologis ini dapat memperburuk kualitas hidup ibu selama kehamilan, mengganggu pola makan dan tidur, serta memengaruhi kemampuan ibu untuk merawat diri sendiri secara optimal selama masa kehamilan dan setelah persalinan.

Pada janin, dampak jangka pendek yang muncul akibat kehamilan risiko tinggi juga dapat sangat serius. Kondisi medis ibu seperti preeklampsia, hipertensi kronik, atau gangguan pembuluh darah plasenta dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin dalam kandungan (intrauterine growth restriction/IUGR), di mana janin mengalami hambatan pertumbuhan sehingga lahir dengan berat badan rendah. Selain itu, insufisiensi plasenta dapat menyebabkan hipoksia atau kekurangan oksigen yang serius pada janin, yang berpotensi menyebabkan kematian intrauterin atau kerusakan organ janin sebelum kelahiran. Pada ibu dengan diabetes gestasional yang tidak terkontrol, janin berisiko mengalami makrosomia (berat lahir di atas normal), yang meningkatkan risiko distosia bahu atau cedera lahir akibat persalinan sulit. Kondisi lainnya, seperti infeksi pada ibu selama kehamilan, juga meningkatkan risiko infeksi intrauterin pada janin, menyebabkan komplikasi seperti sepsis neonatal, pneumonia, atau bahkan meningitis segera setelah lahir.

Setelah bayi dilahirkan, dampak dari kehamilan risiko tinggi tidak serta-merta berhenti. Bayi yang lahir dari kehamilan risiko tinggi cenderung memerlukan perawatan intensif neonatal yang lebih lama dibandingkan bayi normal. Mereka seringkali membutuhkan perawatan khusus seperti inkubator, terapi oksigen, atau perawatan di ruang perawatan intensif neonatus (NICU) karena komplikasi seperti prematuritas, berat badan lahir rendah (BBLR), gangguan pernapasan, atau hipoglikemia neonatal. Perawatan intensif ini tentu berdampak secara emosional dan finansial bagi keluarga serta memerlukan dukungan psikososial yang kuat dari tenaga kesehatan.

Selain dampak jangka pendek, kehamilan risiko tinggi juga memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan. Pada ibu, dampak jangka panjang dari kehamilan risiko tinggi bisa berupa peningkatan risiko penyakit kronis di masa mendatang. Misalnya, wanita dengan riwayat preeklampsia memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular, hipertensi kronik, diabetes tipe 2, dan gangguan metabolik lainnya di masa yang akan datang. Demikian pula, ibu dengan diabetes gestasional memiliki risiko lebih tinggi untuk mengembangkan diabetes mellitus tipe 2 beberapa tahun setelah melahirkan, sehingga mereka perlu terus dipantau dan

menjalani pemeriksaan kesehatan berkala untuk mengidentifikasi risiko ini secara dini.

Bagi anak yang lahir dari kehamilan risiko tinggi, dampak jangka panjang juga tidak bisa diabaikan. Bayi yang mengalami pertumbuhan intrauterin terhambat (IUGR) atau lahir prematur berisiko mengalami gangguan tumbuh kembang jangka panjang seperti keterlambatan perkembangan motorik, kognitif, hingga gangguan belajar saat mereka tumbuh besar. Risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, obesitas, serta gangguan kardiovaskular juga meningkat pada anak-anak yang lahir dari ibu dengan komplikasi selama kehamilan. Anak-anak ini memerlukan pemantauan jangka panjang dalam bentuk pemeriksaan rutin, stimulasi tumbuh kembang, serta pola hidup sehat agar dampak ini dapat diminimalisasi.

Dampak psikososial pada keluarga juga menjadi implikasi penting yang seringkali terabaikan. Keluarga yang menghadapi kehamilan risiko tinggi biasanya mengalami stres yang signifikan, kecemasan akan masa depan, serta beban finansial yang besar akibat biaya perawatan kesehatan yang tinggi. Dukungan psikososial dari tenaga kesehatan dan komunitas menjadi sangat krusial dalam membantu keluarga beradaptasi dengan kondisi tersebut dan menjaga kesehatan mental serta emosional mereka dalam jangka panjang.

I. Pencegahan dan Intervensi Dini

Pencegahan dan intervensi dini memiliki peran penting dalam mengurangi dampak negatif kehamilan risiko tinggi, baik terhadap ibu maupun janin. Upaya pencegahan yang tepat dan intervensi dini yang efektif dapat membantu menghindari atau setidaknya meminimalkan komplikasi yang lebih serius selama kehamilan hingga masa persalinan. Oleh karena itu, pemahaman tentang berbagai strategi pencegahan, edukasi yang komprehensif bagi ibu hamil, serta tindakan intervensi yang tepat waktu sangat penting untuk diperhatikan oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter kandungan, guna memastikan hasil kehamilan yang optimal.

Langkah pertama dalam pencegahan adalah memberikan edukasi yang menyeluruh kepada calon ibu sejak masa prakonsepsi atau sebelum kehamilan terjadi. Edukasi prakonsepsi bertujuan agar calon ibu memahami pentingnya menjaga kondisi kesehatan secara umum serta melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi faktor risiko yang mungkin ada sejak awal. Dalam fase ini, tenaga kesehatan perlu memberikan informasi detail mengenai gaya hidup sehat, pola makan yang tepat, aktivitas fisik yang dianjurkan, serta penggunaan suplemen penting seperti asam folat, vitamin, dan mineral lain yang esensial dalam mencegah komplikasi selama kehamilan. Dengan memberikan edukasi sedini mungkin, ibu

akan lebih siap secara fisik dan mental menghadapi kehamilan yang sehat serta mampu mengurangi risiko-risiko potensial yang mungkin terjadi.

Selain itu, ketika kehamilan telah terjadi, upaya pencegahan dilakukan melalui pemeriksaan antenatal yang teratur dan terjadwal dengan baik. Pemeriksaan antenatal rutin adalah kesempatan terbaik untuk mendeteksi secara dini berbagai kondisi medis atau komplikasi yang mungkin muncul selama kehamilan, seperti hipertensi gestasional, diabetes gestasional, anemia, infeksi, serta gangguan pertumbuhan janin. Pada pemeriksaan antenatal, tenaga kesehatan perlu memberikan edukasi yang jelas mengenai tanda bahaya kehamilan serta pentingnya kepatuhan terhadap jadwal kunjungan pemeriksaan. Dengan pemahaman yang baik, ibu akan lebih peka terhadap perubahan pada tubuhnya dan mampu mencari bantuan medis segera apabila terdapat keluhan atau gejala yang mencurigakan.

Dalam upaya intervensi dini, skrining menjadi langkah yang sangat penting. Salah satu metode skrining yang umum dilakukan adalah menggunakan kartu skor antenatal yang membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi ibu hamil yang memiliki risiko tinggi secara cepat dan akurat. Kartu skor antenatal ini biasanya mencakup berbagai indikator seperti usia ibu, riwayat kehamilan sebelumnya, tekanan darah, kadar gula darah, serta status gizi ibu selama kehamilan. Dengan skor yang diperoleh, tenaga kesehatan dapat dengan mudah menentukan tingkat risiko kehamilan, sehingga intervensi yang tepat dapat segera dilakukan. Skrining juga bisa didukung oleh pemeriksaan laboratorium rutin seperti pemeriksaan darah lengkap, gula darah, protein urine, serta pemeriksaan ultrasonografi (USG) yang dilakukan secara berkala untuk memonitor kondisi janin secara lebih detail dan mendeteksi secara dini kemungkinan komplikasi.

Intervensi dini juga mencakup manajemen medis yang spesifik terhadap kondisi yang teridentifikasi sebagai risiko tinggi. Misalnya, jika ibu hamil diketahui mengalami hipertensi atau preeklampsia ringan, maka intervensi berupa pemberian obat antihipertensi serta pemantauan tekanan darah secara ketat perlu segera dilakukan. Begitu pula pada ibu yang mengalami diabetes gestasional, intervensi berupa edukasi pola makan, pemantauan gula darah secara rutin, serta pemberian insulin atau obat hipoglikemik oral akan sangat membantu mencegah perkembangan komplikasi yang lebih parah. Dalam beberapa kasus, ibu hamil dengan kondisi tertentu mungkin juga membutuhkan rawat inap atau pemantauan lebih intensif untuk memastikan kondisinya tetap stabil hingga persalinan.

Di samping intervensi medis, dukungan psikososial juga merupakan bagian penting dari strategi intervensi dini. Kehamilan risiko tinggi sering kali menyebabkan stres emosional yang signifikan bagi ibu dan keluarganya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu memberikan dukungan psikologis yang memadai, termasuk

konseling kehamilan, edukasi tentang cara mengelola kecemasan, serta pendekatan suportif untuk meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi ketakutan ibu menghadapi persalinan. Dalam hal ini, dukungan dari keluarga dan komunitas juga sangat penting untuk memastikan ibu hamil mendapatkan lingkungan yang mendukung secara emosional, sehingga mereka merasa aman dan nyaman dalam menjalani proses kehamilannya.

Selain intervensi pada ibu, upaya pencegahan komplikasi juga dapat dilakukan melalui pemantauan ketat terhadap kondisi janin secara rutin. Pemeriksaan seperti ultrasonografi (USG) Doppler, pemantauan denyut jantung janin secara elektronik (CTG), serta pemantauan pertumbuhan janin secara serial dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengenali secara dini jika terjadi gangguan perkembangan atau kondisi yang memerlukan intervensi segera seperti persalinan prematur atau induksi persalinan untuk keselamatan ibu dan janin.

Selanjutnya, program intervensi dini yang efektif juga harus didukung oleh sistem rujukan yang baik dan terpadu. Kehamilan risiko tinggi biasanya memerlukan pendekatan multidisiplin serta kerja sama yang erat antara bidan, dokter umum, dokter spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, dan ahli neonatologi. Sistem rujukan yang cepat dan terstruktur memungkinkan ibu hamil untuk mendapatkan penanganan tepat waktu, baik di fasilitas primer maupun sekunder atau tersier, tergantung tingkat keparahan risiko yang ditemukan. Hal ini dapat mencegah keterlambatan dalam penanganan kondisi gawat darurat kehamilan, yang sering kali menjadi penyebab utama komplikasi serius atau bahkan kematian maternal maupun perinatal.

J. Simpulan

Kehamilan risiko tinggi merupakan kondisi kehamilan di mana ibu, janin, atau keduanya memiliki potensi lebih tinggi untuk mengalami komplikasi serius dibandingkan kehamilan normal. Pemahaman yang mendalam terhadap definisi, klasifikasi, identifikasi faktor risiko, serta metode deteksi dini menjadi sangat penting bagi tenaga kesehatan dalam praktik kebidanan, agar dapat melakukan pencegahan, intervensi, serta manajemen yang tepat dan efektif.

Berbagai faktor risiko dapat memengaruhi terjadinya kehamilan risiko tinggi, meliputi faktor medis seperti usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, riwayat penyakit kronis (hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung), riwayat komplikasi pada kehamilan sebelumnya, hingga kehamilan multipel. Selain itu, faktor non-medis seperti kondisi sosial-ekonomi yang rendah, status gizi buruk, stres psikologis, serta paparan terhadap zat-zat berbahaya di lingkungan turut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap terjadinya komplikasi.

Klasifikasi kehamilan risiko tinggi umumnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu risiko ringan, sedang, dan berat, yang masing-masing memerlukan pendekatan dan intervensi yang berbeda. Identifikasi dini terhadap kategori risiko ini dilakukan melalui berbagai metode, di antaranya menggunakan kartu skor antenatal, pemeriksaan laboratorium rutin, serta pemeriksaan ultrasonografi (USG). Metode ini bertujuan agar tenaga kesehatan dapat dengan cepat mendeteksi risiko dan segera melakukan intervensi yang sesuai untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Tenaga kesehatan, khususnya bidan, dokter umum, dokter spesialis kandungan, dan tenaga kesehatan pendukung lainnya memiliki peran vital dalam proses identifikasi awal, pemantauan rutin, serta manajemen kehamilan risiko tinggi. Koordinasi lintas disiplin dan sistem rujukan yang efektif sangat dibutuhkan agar ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan klinisnya.

Dampak kehamilan risiko tinggi dapat sangat serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak jangka pendek pada ibu antara lain adalah preeklampsia berat, perdarahan, hingga komplikasi metabolik, sedangkan dampak pada janin meliputi pertumbuhan janin terhambat, hipoksia janin, dan persalinan prematur. Adapun dampak jangka panjang mencakup peningkatan risiko penyakit kronis pada ibu seperti hipertensi dan diabetes, serta gangguan tumbuh kembang pada anak di kemudian hari.

Untuk mengatasi hal tersebut, pencegahan dan intervensi dini perlu dilakukan melalui edukasi kesehatan prakonsepsi, pemeriksaan antenatal rutin, skrining terstruktur, manajemen medis yang spesifik, serta dukungan psikososial secara intensif. Strategi ini perlu diterapkan secara komprehensif dan terintegrasi agar mampu meminimalkan risiko komplikasi yang mungkin terjadi, serta memperbaiki kualitas pelayanan kebidanan dan kesehatan ibu-janin secara keseluruhan.

K. Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2015). Levels of maternal care: Obstetric care consensus No. 2. *Obstetrics & Gynecology*, 125(2), 502–515.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2022). Pregnancy at age 35 years or older (Practice Bulletin No. 277). Washington, DC: American College of Obstetricians and Gynecologists.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Gabbe, S. G., Niebyl, J. R., Simpson, J. L., Landon, M. B., Galan, H. L., Jauniaux, E. R., ...

- Driscoll, D. A. (2020). *Obstetrics: Normal and problem pregnancies* (8th ed.). Philadelphia: Elsevier.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan antenatal terpadu edisi ketiga*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, M. C., Alden, K. R., & Olshansky, E. F. (2019). *Maternity and women's health care* (12th ed.). St. Louis: Mosby.
- Marshall, J. E., & Raynor, M. D. (2020). *Myles textbook for midwives* (17th ed.). Edinburgh: Elsevier.
- Ricci, S. S., Kyle, T., & Carman, S. (2020). *Maternity and pediatric nursing* (4th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer.
- World Health Organization. (2018). *WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2020). *Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors* (2nd ed.). Geneva: World Health Organization.

L. Glosarium

- **Kehamilan Risiko Tinggi**
Kondisi kehamilan yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami komplikasi yang serius, baik untuk ibu, janin, maupun bayi baru lahir dibandingkan dengan kehamilan normal.
- **Preeklamsia**
Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi, protein dalam urin (proteinuria), serta tanda-tanda kerusakan organ lain yang dapat mengancam nyawa ibu dan janin.
- **Perdarahan Antepartum**
Perdarahan yang terjadi selama masa kehamilan, biasanya pada trimester kedua atau ketiga, yang bisa disebabkan oleh plasenta previa atau solusio plasenta.
- **Pertumbuhan Janin Terhambat (IUGR)**
Kondisi ketika janin tidak tumbuh sebagaimana mestinya di dalam rahim, biasanya ditandai dengan berat badan janin di bawah persentil 10 berdasarkan usia kehamilan.
- **Morbiditas Maternal**
Kondisi sakit atau komplikasi yang dialami oleh ibu selama masa kehamilan, persalinan, atau masa nifas.

- **Kartu Skor Antenatal (Poedji Rochjati)**

Alat penapisan yang digunakan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi tingkat risiko kehamilan berdasarkan beberapa variabel tertentu seperti usia ibu, riwayat kehamilan, dan kondisi medis ibu.

- **Skrining Antenatal**

Proses pemeriksaan terstruktur yang dilakukan secara berkala selama kehamilan untuk mendeteksi dini kemungkinan terjadinya komplikasi atau kondisi abnormal pada ibu dan janin.

- **Ultrasonografi (USG)**

Teknik pencitraan menggunakan gelombang suara untuk melihat kondisi janin, plasenta, cairan ketuban, serta rahim ibu secara real-time selama masa kehamilan.

- **Hipoksia Janin**

Kondisi di mana janin tidak mendapatkan cukup oksigen di dalam kandungan, yang dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang atau kematian intrauterin jika tidak segera ditangani.

- **Intervensi Dini**

Tindakan medis maupun non-medis yang dilakukan segera setelah risiko atau kondisi abnormal dalam kehamilan diidentifikasi, dengan tujuan untuk mencegah atau meminimalkan komplikasi lebih lanjut.

CHAPTER 2

MANAJEMEN DIABETES GESTASIONAL DALAM KEBIDANAN

Bdn. Leni Suhartini, S.ST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Diabetes gestasional (DMG) adalah gangguan toleransi glukosa yang pertama kali ditemukan selama kehamilan dan merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang paling umum. DMG meningkatkan risiko komplikasi kehamilan akut seperti preeklampsia, persalinan dengan operasi sesar, hipoglikemia neonatal, makrosomia, serta risiko jangka panjang bagi ibu dan anak, seperti insiden diabetes tipe 2 pada ibu dan peningkatan risiko obesitas atau diabetes pada anak [1]. Berbagai pendekatan diagnostik telah digunakan, termasuk prosedur 2 langkah yang menggabungkan tes tantangan glukosa dan tes toleransi glukosa oral (OGTT), dan baru-baru ini, OGTT 1 langkah 75 g 2 jam yang direkomendasikan oleh American Diabetes Association. Prevalensi kondisi telah meningkat secara signifikan dengan kriteria diagnostik yang diperbarui, menekankan pentingnya deteksi dini dan manajemen untuk mengurangi risiko makrosomia, komplikasi neonatal, dan dampak kesehatan jangka panjang pada ibu dan anak. Strategi manajemen juga berkembang, memanfaatkan modifikasi pola makan, perubahan gaya hidup, dan terapi farmakologis.

Secara epidemiologis, angka kejadian DMG sangat beragam tergantung pada kriteria diagnostik dan populasi. Estimasi global berkisar dari 4% hingga lebih dari 15% kelahiran hidup pada beberapa analisis; salah satu studi mencatat bahwa sekitar 21 juta kelahiran (sekitar 16% dari kelahiran hidup yang terkait dengan hiperglikemia kehamilan) terpengaruh, dan prevalensi standar menurut IDF sangat tinggi di banyak wilayah. Variasi ini menunjukkan bahwa pendekatan lokal sangat penting untuk skrining dan manajemen [2].

Di Indonesia, prevalensi yang sering dikutip secara historis berada pada kisaran rendah (sekitar 1,9–3,6%) dengan kriteria lama; namun, studi regional dan rumah sakit terbaru menunjukkan prevalensi yang jauh lebih tinggi dengan kriteria diagnostik modern (IADPSG, WHO, DIPSI, atau NICE), dengan beberapa studi daerah menunjukkan prevalensi dua digit (misalnya, studi di Yogyakarta dan Jambi menunjukkan prevalensi hingga 11% tergantung kriteria). Penurunan jumlah orang dewasa yang menderita diabetes tipe 2 di Indonesia juga menunjukkan bahwa DMG harus ditangani sebagai kesempatan pencegahan primer.

Berdasarkan bukti dan pedoman internasional terkini, skrining dan manajemen DMG merupakan kunci untuk menurunkan morbiditas maternal–neonatal. Rekomendasi praktik (ADA, ACOG, USPSTF) menekankan skrining pada usia kehamilan sekitar 24–28 minggu (kecuali indikasi risiko tinggi yang memerlukan skrining lebih awal), intervensi gaya hidup dan nutrisi sebagai langkah pertama, pemantauan glukosa kapiler, serta penggunaan insulin (atau agen lain bila sesuai pedoman lokal) bila target glikemik tidak tercapai. Peran bidan sangat krusial: deteksi dini, konseling nutrisi dan aktivitas fisik, pemantauan terapi, edukasi kepatuhan, serta rujukan tepat waktu ke fasilitas yang dapat mengelola terapi farmakologis dan komplikasi [3]

B. Etiologi

Pelepasan hormon plasenta menyebabkan resistensi insulin yang nyata. Laktogen plasenta manusia adalah hormon utama yang terkait dengan peningkatan resistensi insulin; Namun, hormon ini juga meningkatkan sekresi insulin dan proliferasi sel β untuk mengatur hiperglikemia ibu pada kehamilan normal. Sebaliknya, pada pasien dengan DMG, ada kondisi atau faktor yang menyebabkan disfungsi sel β pankreas ibu atau respons sel β yang tertunda, mengakibatkan penurunan sekresi insulin dan pada akhirnya menyebabkan hiperglikemia ibu. Faktor lain yang meningkatkan resistensi insulin secara tidak normal adalah obesitas ibu di awal kehamilan karena kadar asam lemak bebas yang lebih tinggi, yang menghambat penyerapan glukosa ibu dan merangsang glukoneogenesis hati [4].

Faktor-faktor klinis berikut dikaitkan dengan risiko tinggi terkena diabetes gestasional:

1. Peningkatan berat badan (BMI >25 atau >23 pada orang Asia-Amerika)
2. Penurunan aktivitas fisik
3. Riwayat penyakit keturunan dengan diabetes melitus
4. Etnis berisiko tinggi (misalnya, Afrika-Amerika, Latin, Penduduk Asli Amerika, Asia-Amerika, Kepulauan Pasifik)
5. Sejarah masa lalu dari salah satu dari berikut ini : DMG, Berat lahir bayi baru lahir ≥ 4000 g, Penyakit kardiovaskular, Hipertensi, HDL rendah <35 mg/dL atau kadar trigliserida >250 mg/dL, Sindrom ovarium polikistik, Hemoglobin A1C >5.7, Tes toleransi glukosa oral yang tidak normal, Setiap penanda resistensi insulin yang signifikan (misalnya, acanthosis nigricans) [5]

C. Patofisiologi

Peningkatan fisiologis hormon plasenta yang bersirkulasi, termasuk hormon pertumbuhan, hormon pelepas kortikotrofin, laktogen plasenta manusia, prolaktin, estrogen, dan progesteron, meningkatkan resistensi insulin selama kehamilan normal. Laktogen plasenta manusia adalah hormon yang dilepaskan oleh plasenta selama kehamilan; Hormon ini memiliki komposisi yang sebanding dengan hormon pertumbuhan dan menginduksi perubahan metabolisme yang signifikan selama kehamilan untuk mendukung pemeliharaan status gizi janin. Hormon ini mampu memprovokasi perubahan dan modifikasi pada reseptor insulin. Variasi molekuler, termasuk perubahan molekuler reseptor insulin beta-subunit, berkurangnya fosforilasi tirosin kinase, dan remodeling pada substrat reseptor insulin-1 dan fosfatidilinositol 3-kinase, dikaitkan dengan penurunan penyerapan glukosa pada jaringan perifer. Peningkatan resistensi insulin ibu menyebabkan peningkatan kadar glukosa postprandial ibu dan asam lemak bebas, yang menyebabkan lebih banyak glukosa tersedia untuk pertumbuhan janin. Namun, kehamilan normal juga memiliki peningkatan sekresi insulin yang sesuai untuk menjaga euglikemia ibu. Proses fisiologis ini memandu rekomendasi untuk pengujian DMG pada trimester kedua dan ketiga [4].

Patofisiologi DMG mirip dengan diabetes tipe 2, yang disebabkan oleh peningkatan resistensi insulin dan kekurangan hormon insulin. Disfungsi sel β pankreas ibu yang mengakibatkan penurunan sekresi insulin adalah mekanisme utama yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengontrol resistensi insulin ibu dan peningkatan kadar glukosa, yang menyebabkan penurunan penyerapan glukosa, peningkatan glukoneogenesis hati, dan hiperglikemia ibu. Para ahli juga menyarankan bahwa kadar trigliserida serum yang lebih tinggi dapat menyebabkan cedera sel β lipotoksik, bahkan lebih mengganggu sekresi insulin [6]. Peningkatan kadar glukosa serum ibu melintasi plasenta dan menghasilkan hiperglikemia janin, merangsang pankreas janin. Akibatnya, sifat anabolik insulin menginduksi jaringan janin tumbuh pada tingkat yang tinggi [7].

D. Riwayat dan pemeriksaan fisik

DMG terutama awalnya diidentifikasi dengan tes skrining pada kehamilan. Karena skrining dini ditunjukkan oleh riwayat klinis dan penilaian, mendokumentasikan riwayat medis masa lalu, hasil kebidanan, dan riwayat keluarga diabetes mellitus tipe 2 adalah komponen penting dari penilaian DMG. Fitur klinis diabetes mellitus gestasional dapat bervariasi. Penambahan berat badan yang tidak proporsional, obesitas, dan peningkatan BMI dapat menjadi fitur sugestif [5]. *The*

American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) merekomendasikan evaluasi yang ditargetkan untuk diabetes tipe 2 di awal kehamilan dengan tes toleransi glukosa oral 75 g atau 50 g pada kunjungan prenatal awal pada pasien yang memiliki BMI 30 kg/m² atau lebih dan 1 faktor risiko berikut:

1. Riwayat diabetes mellitus gestasional
2. Hemoglobin A1C $\geq 5,7\%$ pada pengujian sebelumnya
3. Anggota keluarga dekat dengan diabetes
4. Ras berisiko tinggi (misalnya, Afrika-Amerika, Amerika Latin, Penduduk Asli Amerika, Asia-Amerika, Kepulauan Pasifik)
5. Riwayat penyakit kardiovaskular
6. Hipertensi
7. Kadar kolesterol high-density lipoprotein (HDL) <35 mg/dL atau kadar trigliserida >250 mg/dL
8. Sindrom ovarium polistik
9. Ketidakaktifan fisik

E. Pemeriksaan Glukosa Pada Masa Kehamilan

Beberapa studi skrining laboratorium dan aneuploid dilakukan selama trimester kedua untuk memberikan waktu yang optimal untuk intervensi potensial. ACOG merekomendasikan agar studi laboratorium untuk diabetes gestasional dilakukan pada semua ibu hamil antara kehamilan 24 dan 28 minggu. Namun, metode skrining dan ambang batas bervariasi di antara para ahli [5]. The IADPSG dan the American Diabetes Association (ADA) mengadvokasi pendekatan skrining 1 langkah untuk DMG menggunakan Oral Glukosa Toleransi Tes (OGTT) 75 g 2 jam. Keuntungan utama dari pendekatan 1 langkah adalah kemampuannya untuk menyaring dan mendiagnosis DMG dalam satu kunjungan, yang merampingkan proses untuk pasien dan dokter. Namun, itu membutuhkan puasa sebelum tes dan komitmen sekitar 2 jam untuk seluruh prosedur [8].

Sebaliknya, pendekatan skrining 2 langkah, yang direkomendasikan oleh ACOG, dimulai dengan tes tantangan glukosa 50 g 1 jam tanpa puasa. Tes awal ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam kunjungan prenatal rutin dan lebih mudah diterapkan. Kebanyakan wanita yang menjalani OGTT 1 jam tidak memerlukan pengujian lebih lanjut, karena mereka tidak memenuhi ambang batas untuk kadar glukosa abnormal. Namun, sekitar 20% wanita gagal dalam skrining awal ini dan kemudian menjalani OGTT diagnostik puasa selama 3 jam untuk mengkonfirmasi diagnosis DMG. Langkah tambahan ini bertujuan untuk mengurangi pengujian dan intervensi yang tidak perlu bagi mereka yang tidak memiliki DMG. Ambang batas yang berbeda digunakan untuk skrining toleransi

glukosa 50 g untuk dianggap sebagai hasil yang tidak normal, termasuk ≥ 135 mg/dL (7,5 mmol/L), ≥ 130 mg/dL (7,22 mmol/L), dan ≥ 140 mg/dL (7,8 mmol/L). Karena penelitian belum menunjukkan ambang batas yang optimal, dokter harus menentukan batas mana yang akan diterapkan berdasarkan prevalensi faktor risiko diabetes gestasional komunitas dan preferensi klinis untuk sensitivitas dan spesifisitas tes.

Pada pasien dengan skrining glukosa 50 g positif, tes diagnostik menggunakan OGTT 100 g 3 jam diperlukan [5]. Nilai-nilai berikut digunakan sebagai parameter untuk hasil abnormal untuk OGTT 3 jam:

1. Puasa: ≥ 95 mg/dL
2. Jam pertama: ≥ 180 mg/dL
3. Jam kedua: ≥ 155 mg/dL
4. Jam ketiga: ≥ 140 mg/dL

Kehadiran ≥ 2 hasil abnormal menetapkan diagnosis diabetes gestasional [5]. Perbedaan utama antara 2 pendekatan terletak pada batas diagnostik mereka. Pendekatan 1 langkah menggunakan kriteria yang lebih ketat, mengidentifikasi wanita dengan bentuk hiperglikemia yang lebih ringan sebagai memiliki DMG. Pendekatan ini bertujuan untuk menangkap kasus DMG lebih awal, berpotensi memungkinkan intervensi dan manajemen lebih awal untuk meningkatkan hasil ibu dan perinatal. Namun, ambang diagnostik yang lebih rendah yang digunakan dalam pendekatan 1 langkah dapat menyebabkan prevalensi DMG yang lebih tinggi daripada metode 2 langkah. Penelitian belum menunjukkan perbedaan yang signifikan antara metode ini dalam hasil perinatal. Akibatnya, beberapa metode dapat diterima untuk mendiagnosis DMG [8].

F. Pemantauan Glukosa Pada Masa Nifas

Pada periode pascapersalinan, 24 hingga 72 jam setelah persalinan, pemantauan glukosa direkomendasikan. Setelah pengangkatan plasenta, resistensi insulin cenderung meningkat; Oleh karena itu, insulin atau agen hipoglikemik biasanya dapat dikurangi. Selain itu, setelah melahirkan, DMG sering sembuh, tetapi hingga sepertiga wanita yang terkena dapat mengembangkan diabetes atau gangguan metabolisme glukosa di kemudian hari. Studi menunjukkan bahwa antara 15% dan 70% wanita dengan riwayat DMG dapat berkembang menjadi diabetes, terutama diabetes tipe 2. Khususnya, wanita dengan diagnosis DMG sebelumnya menghadapi risiko yang jauh lebih tinggi—hingga tujuh kali lipat—terkena diabetes tipe 2 dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki riwayat seperti itu. Mengingat risiko ini, pedoman merekomendasikan skrining pascapersalinan untuk semua wanita yang memiliki DMG, idealnya antara 4 hingga 12 minggu setelah

melahirkan. Dua metode utama untuk skrining pascapersalinan termasuk tes glukosa plasma puasa dan OGTT 75 g, 2 jam. Meskipun tes glukosa plasma puasa lebih sederhana secara logistik, metode ini mungkin gagal mendeteksi bentuk-bentuk tertentu dari metabolisme glukosa abnormal. Oleh karena itu, OGTT biasanya lebih disukai karena dapat mendiagnosis gangguan kadar glukosa puasa dan gangguan toleransi glukosa, memberikan penilaian yang lebih komprehensif tentang status glukosa pascapersalinan [5].

Manajemen berikut direkomendasikan untuk berbagai hasil glukosa plasma puasa dan OGTT 2 jam:

1. Diabetes

- a. >125 mg/dL atau glukosa 2 jam >199 mg/dL
- b. Memulai atau merujuk untuk manajemen diabetes

2. Gangguan glukosa puasa atau gangguan toleransi glukosa

- a. Glukosa 100 hingga 125 mg/dL atau 2 jam 140 hingga 199 mg/dL
- b. Memulai modifikasi pola makan dan meningkatkan aktivitas fisik untuk menurunkan berat badan
- c. Rujuk untuk konseling gizi sesuai kebutuhan
- d. Pertimbangkan terapi metformin jika toleransi glukosa dan glukosa puasa terganggu
- e. Skrining diabetes setiap tahun menggunakan hemoglobin A1C, glukosa plasma puasa, atau OGTT 75 g menggunakan ambang batas yang tidak hamil

3. Temuan normal

- a. <100 mg/dL atau glukosa 2 jam <140 mg/dL
- b. Skrining diabetes setiap 1 hingga 3 tahun
- c. Memulai modifikasi pola makan dan meningkatkan aktivitas fisik untuk mencapai dan mempertahankan BMI dalam kisaran normal

Deteksi dini melalui skrining pascapersalinan dapat bermanfaat bagi wanita dengan gangguan glukosa puasa atau gangguan toleransi glukosa dengan memungkinkan intervensi pencegahan (misalnya, modifikasi gaya hidup) dan terapi yang lebih intensif bagi mereka yang didiagnosis dengan diabetes. Terlepas dari rekomendasi ini, kepatuhan terhadap pengujian pascapersalinan tetap tidak optimal, dengan hanya antara 23% dan 58% wanita yang menjalani evaluasi pascapersalinan yang tepat. Perbedaan antara pedoman pengujian pascapersalinan dan implementasi klinis ini menggarisbawahi perlunya peningkatan pendidikan pasien dan keterlibatan dokter [9][5]

G. Manajemen

1. Terapi Nonfarmakologis

Manajemen DMG dimulai dengan pendekatan nonfarmakologis, termasuk peningkatan aktivitas fisik, perubahan pola makan, dan pemantauan glukosa. Jumlah olahraga yang direkomendasikan pada pasien dengan DMG adalah 30 menit latihan aerobik intensitas sedang setidaknya 5 hari seminggu atau minimal 150 menit per minggu. Selain itu, latihan postprandial sering direkomendasikan karena telah terbukti membantu mengontrol kadar glukosa hingga 3 jam setelah makan [10].

2. Modifikasi pola makan dan penambahan berat badan kehamilan

ADA dan ACOG juga merekomendasikan konseling nutrisi oleh ahli gizi terdaftar dan pengembangan rencana yang dipersonalisasi berdasarkan BMI pasien untuk memastikan bahwa permintaan kalori pasien terpenuhi sambil menghindari penambahan berat badan yang berlebihan. Dokter juga dapat memberi tahu pasien mengenai modifikasi diet umum, termasuk mengonsumsi 3 makanan kecil hingga sedang dan 2 hingga 3 camilan setiap hari yang terdiri dari karbohidrat gandum, protein, dan lemak tak jenuh dengan lebih sedikit karbohidrat saat sarapan karena peningkatan intoleransi karbohidrat selama waktu itu. ACOG merekomendasikan diet rendah karbohidrat; namun, rasio optimal makronutrien spesifik pada pasien dengan DMG belum ditentukan. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa menggabungkan karbohidrat dengan protein tanpa lemak dapat membantu mengurangi hipoglikemia postprandial. Untuk mencegah ketosis di malam hari, yang dapat berdampak buruk pada perkembangan saraf janin, camilan sebelum tidur sering direkomendasikan [1].

Penambahan berat badan gestasional juga dapat memengaruhi kehamilan yang diperumit oleh DMG. Obesitas ibu dan penambahan berat badan yang berlebihan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko makrosomia janin, diabetes gestasional, hipertensi gestasional, preeklampsia, dan operasi caesar [11]. Wanita obesitas juga memiliki peningkatan risiko disfungsi jantung antepartum, proteinuria, penyakit hati berlemak nonalkohol, dan sleep apnea, serta komplikasi intrapartum, termasuk endometritis, kegagalan induksi persalinan, trombosis vena, dan dehisensi luka. Makrosomia, yang memiliki insiden yang lebih tinggi pada mereka yang mengalami obesitas, juga dikaitkan dengan komplikasi ibu (misalnya, persalinan, pecahnya rahim, laserasi saluran genital, dan perdarahan pascapersalinan). Selain itu, neonatus makrosomik memiliki peningkatan risiko distosia bahu, patah tulang klavikular, cedera pleksus brakialis, dan kelumpuhan saraf. Sebuah meta-analisis baru-baru ini menunjukkan risiko tertinggi dari hasil

yang merugikan terjadi pada wanita dengan BMI lebih dari 40 dan penambahan berat badan gestasional total yang tinggi [12]. Meta-analisis yang sama merekomendasikan kisaran berikut untuk penambahan berat badan gestasional untuk setiap kelas berat badan prakehamilan:

- a. Kekurangan berat badan (BMI <18,5): 14 hingga <16 kg
- b. Berat badan normal (BMI 18,5 hingga 24,9): 10 hingga <18 kg
- c. Kelebihan berat badan (BMI 25 hingga 29,9): 2 hingga <16 kg
- d. Obesitas tingkat 1 (BMI 30 hingga 34,9): 2 hingga <6 kg
- e. Obesitas tingkat 2 (BMI 35 hingga 39,9): penurunan atau penambahan berat badan 0 hingga <4 kg
- f. Obesitas tingkat 3 (BMI $\geq$ 40): 0 hingga <6 kg

3. Pemantauan glukosa

Pemantauan glukosa 4 kali sehari umumnya disarankan, meskipun bukti yang mendukung frekuensi terbaik kurang. Mendapatkan kadar glukosa darah jari setelah berpuasa dan kemudian 1 atau 2 jam postprandial pada setiap waktu makan adalah jadwal pemantauan yang paling umum digunakan [4]. Beberapa ahli merekomendasikan pemantauan glukosa 4 kali sehari selama 2 minggu, dan berdasarkan temuan ini, terapi insulin dapat dimulai pada pasien dengan kadar glukosa tinggi atau, pada mereka yang memiliki hasil kisaran normal, pemantauan glukosa dapat dilakukan lebih jarang. ADA dan ACOG menyarankan target glukosa kurang dari 95 mg/dL puasa dan 140 mg/dL postprandial atau kurang pada 1 jam atau 120 mg/dL pada 2 jam. Dokter harus menyarankan pasien untuk menyimpan log pembacaan glukosa yang dapat ditinjau pada kunjungan prenatal mingguan atau lebih sering sesuai kebutuhan [5].

4. Terapi Farmakologis

Jika kontrol glikemik pasien tidak memadai meskipun kepatuhan optimal terhadap diet dan olahraga, pengobatan farmakologis direkomendasikan. Terapi insulin secara tradisional dianggap sebagai terapi standar untuk pasien dengan DMG yang tidak dikontrol oleh pengobatan nonfarmakologis. Agen oral juga umumnya digunakan, meskipun ini adalah penggunaan off-label [5].

5. Terapi insulin

Insulin tidak melintasi penghalang plasenta dan direkomendasikan oleh ADA untuk pengobatan lini pertama DMG. [1] Rejimen insulin biasanya terdiri dari formulasi insulin basal dan kerja pendek. Dosis basal menargetkan hiperglikemia puasa, sedangkan hiperglikemia postprandial biasanya diobati dengan menyesuaikan dosis insulin kerja pendek. Dosis insulin harus disesuaikan secara individual berdasarkan pemantauan glukosa; namun, perkiraan total insulin yang diperlukan saat memulai terapi insulin dapat dihitung menggunakan berat badan

pasien dan usia kehamilan (lihat Tabel. Perhitungan Total Kebutuhan Insulin Harian Awal untuk Diabetes Gestasional). Setelah itu, dosis insulin dapat disesuaikan seperti yang ditunjukkan oleh log glukosa [4].

Tabel 3.1 Perhitungan Kebutuhan Insulin Pada DMG

1-13 minggu	BB dalam kg x 0,7
14-26 minggu	BB dalam kg x 0,8
27-37 minggu	BB dalam kg x 0,9
38 minggu sampai persalinan	BB dalam kg x 1,0

Sumber: Gestasional Diabetes, 2025

Pasien harus membagi total dosis insulin harian menjadi dua, dengan setengahnya diberikan sebagai insulin basal sebelum tidur dan separuh lainnya dibagi antara 3 kali makan dan diberikan sebagai insulin kerja cepat atau reguler sebelum makan [5].

6. Terapi oral

Agan hipoglikemik oral yang paling umum digunakan termasuk metformin dan gliburide, meskipun penelitian tentang efektivitasnya telah menunjukkan hasil yang beragam. Glyburide dapat dimulai pada 2,5 mg setiap hari dan dosis maksimum 20 mg. Namun, penelitian terbaru belum menunjukkan manfaat serupa dengan pengobatan insulin. Secara historis, gliburide dianggap tidak melintasi penghalang plasenta, tetapi ini tidak akurat menurut hasil penelitian baru-baru ini. Selain itu, gliburide dikaitkan dengan peningkatan risiko rawat inap perawatan intensif neonatal, sindrom gangguan pernapasan, hipoglikemia, dan cedera kelahiran, serta kemungkinan stimulasi insulin janin. Oleh karena itu, ACOG telah merekomendasikan bahwa gliburide tidak boleh dianggap sebagai terapi lini pertama [5]. Dosis awal metformin biasanya 500 mg sehari selama 1 minggu, meningkat menjadi dua kali sehari setelahnya hingga dosis maksimum 2.500 hingga 3.000 mg. Metformin diketahui melintasi plasenta dan memiliki efek samping, termasuk kelahiran prematur dan sakit perut ibu dan diare. Selain itu, jika dibandingkan dengan insulin, hasil dengan penggunaan metformin, seperti makrosomia, hipoglikemia neonatal, atau persalinan caesar, serupa. Kegagalan pengobatan yang signifikan juga dicatat, dengan 50% pasien membutuhkan terapi insulin. Metformin dapat dianggap sebagai alternatif insulin pada pasien yang menolak atau tidak mampu membeli insulin [5].

7. Pertimbangan Obstetri

Karena risiko kebidanan yang terkait dengan DMG, manajemen bervariasi tergantung pada beberapa faktor klinis. Misalnya, pertumbuhan janin biasanya

dinilai dengan USG serial karena risiko makrosomia dan distosia bahu. DMG juga merupakan indikasi surveilans janin antepartum karena peningkatan risiko kematian janin pada pasien diabetes. Selain itu, waktu dan mode pengiriman dapat bervariasi tergantung pada indikator klinis. Pedoman ACOG merekomendasikan persalinan pada usia kehamilan 40 6/7 minggu pada pasien dengan DMG yang dikontrol diet dan kehamilan 39 0/7 hingga 39 6/7 minggu pada mereka yang memiliki DMG yang dikontrol obat. Namun, pada pasien dengan DMG yang tidak terkontrol, persalinan antara 37 0/7 minggu dan 38 6/7 minggu kehamilan masuk akal; Bagi mereka yang menderita diabetes yang tidak terkontrol dan faktor klinis abnormal lainnya (misalnya, surveilans janin antenatal abnormal), persalinan lebih awal dapat dipertimbangkan. Selanjutnya, persalinan caesar dapat didiskusikan dengan wanita dengan DMG dan perkiraan berat janin 4500 g atau lebih [5].

H. Diagnosis diferensial

Banyak wanita tidak menerima skrining yang tepat untuk diabetes mellitus sebelum kehamilan, jadi dalam beberapa kasus, sulit untuk membedakan DMG dari diabetes yang sudah ada sebelumnya dan diabetes onset dewasa pada anak muda [13].

I. Prognosis

Kontrol kadar glukosa ibu yang tepat secara signifikan mengurangi risiko DMG, termasuk makrosomia dan hipoglikemia neonatal. Risiko preeklampsia menurun dari 18% menjadi 12% dengan pengobatan. [1] Jika intervensi DMG, termasuk modifikasi diet atau terapi farmakologis, diterapkan cukup dini, perkembangan ke diabetes tipe 2 dalam 10 tahun berkurang 35% hingga 40%. Selain itu, bahkan pengurangan kecil BMI dapat mengakibatkan penurunan risiko diabetes sebesar 25% [14].

J. Komplikasi

Komplikasi ibu dan janin dikaitkan dengan DMG. Komplikasi janin termasuk makrosomia, hipoglikemia neonatal, polisitemia, distosia bahu, hiperbilirubinemia, sindrom gangguan pernapasan neonatal, peningkatan kematian perinatal, dan hipokalsemia. Komplikasi ibu termasuk preeklampsia, peningkatan risiko terkena diabetes melitus, dan peningkatan risiko persalinan Caesar [15].

K. Edukasi pasien

Pendidikan pasien mengenai perubahan pola makan yang tepat, olahraga, dan modifikasi gaya hidup dapat membantu meningkatkan hasil pada pasien dengan DMG [15]. Selain itu, perawatan tindak lanjut secara teratur sangat penting bagi wanita dengan riwayat DMG, termasuk skrining berulang setiap 1 hingga 3 tahun jika hasil awal pascapersalinan normal. Pendekatan ini tidak hanya memantau perkembangan diabetes tetapi juga mendukung intervensi dini untuk mengurangi risiko kesehatan jangka panjang seperti penyakit kardiovaskular. Intervensi gaya hidup yang berkelanjutan dan perubahan pola makan, mirip dengan yang terbukti efektif dalam Program Pencegahan Diabetes, memainkan peran penting dalam mengelola dan berpotensi mencegah diabetes tipe 2 pada populasi berisiko tinggi ini [16] [5].

L. Contoh Asuhan Kebidanan pada Ibu Hamil Dengan DMG

Seorang perempuan, umur 29 tahun datang ke puskesmas. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh bidan jaga dan dibuat dokumentasi dalam bentuk SOAP.

1. S:

- a. Ibu mengatakan hamil anak pertama, tidak pernah keguguran, saat ini usia kehamilan 30 minggu
- b. Keluhan saat ini sering merasa haus, sering berkemih, cepat lelah
- c. Riwayat penyakit keluarga : DM, hipertensi
- d. Pola makan : suka makanan manis dan tinggi karbohidrat
- e. Belum pernah kontrol gula
- f. Kenaikan BB selama hamil 15 kg.

2. O:

- a. Keadaan umum baik, compos mentis
- b. TD 120/80 mmHg, N 89x/menit, P 18x/menit, S 36,5⁰ C, IMT 30
- c. TFU 30 cm, DJJ 140x/menit, teratur, kontraksi uterus tidak ada
- d. Hasil pemeriksaan lab OGTT : GDP 105 mg/dL, GDPP 180 mg/dL.

3. A:

G1P0A0 hamil 30 minggu dengan DMG, janin tunggal hidup intrauterin
Diagnosis potensial: pre eklampsia, makrosomia, persalinan SC, hipoglikemia neonatal.

4. P:

- a. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu dan keluarga, bahwa ibu dalam kondisi DMG dan harus dilakukan pemantauan lebih lanjut

- b. Monitoring gula darah dan pertumbuhan janin. Mengajarkan ibu cara memeriksa GDS sendiri dan edukasi gerak janin.
- c. Memberi edukasi terkait diet sehat dan aktifitas fisik ringan. Diet khusus ibu hamil dengan DMG : mengurangi karbohidrat sederhana, perbanyak makan serat, makan teratur porsi kecil tapi sering, aktifitas fisik ringan dapat berupa jalan kaki, senam hamil.
- d. Merujuk pasien ke RS untuk dilakukan tatalaksana lebih lanjut. Ibu dianjurkan untuk melanjutkan ANC di RS untuk mendapatkan monitoring kadar glukosa dan kondisi janin, antisipasi kemungkinan makrosomia dan hipoglikemia pada neonatus.

M. Simpulan

DMG meningkatkan risiko komplikasi kehamilan akut seperti preeklampsia, persalinan dengan operasi sesar, hipoglikemia neonatal, makrosomia, serta risiko jangka panjang bagi ibu dan anak. Langkah tindakan bidan pada ibu hamil dengan DMG yaitu skrining, diagnosis, monitoring dan edukasi, kolaborasi/rujukan, persiapan persalinan di RS.

1. Deteksi dini dapat dilakukan dengan anamnesis,
2. Pemeriksaan fisik dan pemeriksaan gula darah (GDP, GDPP, TTGO)
3. Penegakkan diagnosis: tentukan DMG
4. Monitoring: TD, BB, TFU, DJJ, Gerak janin, GDS, tanda pre eklampsia
5. Edukasi: diet, aktifitas fisik, tanda bahaya
6. Kolaborasi/rujukan: dengan dokter obgyn, dokter penyakit dalam, dan ahli gizi
7. Persiapan persalinan; di RS, antisipasi persalinan SC atas indikasi makrosomia, pre eklampsia, potensial bayi dengan hipoglikemia

N. Referensi

- H. M. Bryan S, Quintanilla Rodriguez, Elsa S.Vadakekut, *Gestational Diabetes*. National Library of Medicine, 2024.
- S. M. Ratna S Dewi, "Prevalence and Risk Factors Diabetes Melitus in Jambi, Indonesia," *Afr J Reprod Heal.*, pp. 118–124, 2024.
- N. A. Elsayed *et al.*, "15. Management of Diabetes in Pregnancy: Standards of Care in Diabetes—2023," *Diabetes Care*, vol. 46, no. January, pp. S254–S266, 2023, doi: 10.2337/dc23-S015.
- A. Sweeting, J. Wong, H. R. Murphy, and G. P. Ross, "A Clinical Update on Gestational Diabetes Mellitus," *Endocr. Rev.*, vol. 43, no. 5, pp. 763–793, 2022, doi:

10.1210/endrev/bnac003.

- ACOG Practice Bulletins, "Gestational diabetes mellitus. ACOG Practice Bulletin No. 190. American College of Obstetricians and Gynecologists.," *Obstet. Gynecol.*, vol. 131, no. 180, pp. e49–e64, 2018.
- A. Surendran, D. Dixon, and M. Whyte, "Diabetes in pregnancy: A practical guide for midwives," *Br. J. Midwifery*, vol. 27, no. 7, pp. 413–419, 2019, doi: 10.12968/bjom.2019.27.7.413.
- C. Spaight, J. Gross, A. Horsch, and J. J. Puder, "Gestational diabetes mellitus," *Endocr. Dev.*, vol. 31, pp. 163–178, 2016, doi: 10.1159/000439413.
- T. A. Hillier *et al.*, "A Pragmatic, Randomized Clinical Trial of Gestational Diabetes Screening," *Obstet. Gynecol. Surv.*, vol. 76, no. 8, pp. 460–461, 2021, doi: 10.1097/01.ogx.0000771056.71675.a2.
- S. S. Daneshmand, S. Stortz, R. Morrissey, and A. Faksh, "Bridging gaps and understanding disparities in gestational diabetes mellitus to improve perinatal outcomes," *Diabetes Spectr.*, vol. 32, no. 4, pp. 317–323, 2019, doi: 10.2337/DS19-0013.
- et al Hyochol Ahn, "Definition, Diagnosis, Detection, And," *Physiol. Behav.*, vol. 176, no. 10, pp. 139–148, 2017, doi: 10.1016/j.ecl.2019.05.001.Gestational.
- M. A. Kominiarek and A. M. Peaceman, "Gestational weight gain," *Am. J. Obstet. Gynecol.*, vol. 217, no. 6, pp. 642–651, 2017, doi: 10.1016/j.ajog.2017.05.040.
- E. Voerman *et al.*, "Association of Gestational Weight Gain with Adverse Maternal and Infant Outcomes," *Jama*, vol. 321, no. 17, pp. 1702–1715, 2019, doi: 10.1001/jama.2019.3820.
- E. Chiefari, B. Arcidiacono, D. Foti, and A. Brunetti, "Gestational diabetes mellitus: an updated overview," *J. Endocrinol. Invest.*, vol. 40, no. 9, pp. 899–909, 2017, doi: 10.1007/s40618-016-0607-5.
- A. M. Hedeager Momsen *et al.*, "Diabetes prevention interventions for women after gestational diabetes mellitus: an overview of reviews," *Endocrinol. Diabetes Metab.*, vol. 4, no. 3, pp. 1–27, 2021, doi: 10.1002/edm2.230.
- M. V. Senat and P. Deruelle, "Gestational diabetes mellitus," *Gynecol. Obstet. Fertil.*, vol. 44, no. 4, pp. 244–247, 2016, doi: 10.1016/j.gyobfe.2016.01.009.
- D. Care and S. S. Suppl, "2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2025," *Diabetes Care*, vol. 48, no. January, pp. S27–S49, 2025,

O. Glosarium

Antepartum: Periode sebelum persalinan atau masa kehamilan.

Diabetes Gestasional (DMG): Gangguan metabolisme karbohidrat yang pertama kali dikenali atau timbul saat kehamilan.

Glukosa Darah: Kadar gula (glukosa) yang terdapat dalam aliran darah, sumber energi utama tubuh.

Hiperglikemia: Kondisi ketika kadar glukosa darah melebihi batas normal.

Hipoglikemia: Kondisi ketika kadar glukosa darah lebih rendah dari normal.

Insulin: Hormon yang diproduksi pankreas, berfungsi mengatur kadar glukosa darah dengan membantu glukosa masuk ke dalam sel.

Makrosomia: Kondisi bayi baru lahir dengan berat badan lebih dari 4.000 gram, sering terjadi pada ibu dengan diabetes gestasional.

Neonatal Hypoglycemia: Kondisi kadar gula darah bayi rendah setelah lahir, dapat terjadi akibat kompensasi produksi insulin berlebih selama dalam kandungan.

Obstetri: Cabang ilmu kedokteran yang mempelajari kehamilan, persalinan, dan nifas.

Oral Glucose Tolerance Test (OGTT): Uji toleransi glukosa oral, pemeriksaan untuk mendiagnosis diabetes gestasional.

Plasenta: Organ yang terbentuk selama kehamilan untuk menyalurkan oksigen dan nutrisi dari ibu ke janin serta membuang sisa metabolisme.

Postpartum: Masa setelah persalinan hingga 6 minggu pasca melahirkan.

Preeklampsia: Komplikasi kehamilan yang ditandai dengan hipertensi dan proteinuria, dapat menyertai diabetes gestasional.

Prenatal Care (Antenatal Care): Asuhan kehamilan secara menyeluruh untuk memantau kesehatan ibu dan janin.

Resistensi Insulin: Kondisi ketika sel tubuh tidak merespon secara efektif terhadap insulin, sering meningkat selama kehamilan.

Trimester: Pembagian periode kehamilan menjadi tiga bagian, masing-masing sekitar 3 bulan.

USG (Ultrasonografi): Pemeriksaan pencitraan menggunakan gelombang suara untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin.

CHAPTER 3

PENCEGAHAN KOMPLIKASI PADA PERSALINAN RISIKO TINGGI

Hayun Manudyaning Susilo, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Persalinan merupakan suatu proses fisiologis yang alami dialami oleh setiap wanita hamil. Meskipun sebagian besar persalinan dapat berjalan lancar tanpa komplikasi serius, terdapat kelompok ibu hamil yang memiliki faktor risiko tertentu sehingga membutuhkan perhatian ekstra dalam penanganan persalinannya. Kelompok ini dikenal sebagai ibu dengan kehamilan risiko tinggi. Istilah risiko tinggi mengacu pada berbagai kondisi yang dapat meningkatkan peluang terjadinya komplikasi medis serius selama proses persalinan, baik yang berkaitan dengan kesehatan ibu maupun janinnya.

Pencegahan komplikasi pada persalinan risiko tinggi merupakan elemen penting dalam upaya mengurangi angka kematian ibu dan bayi yang masih menjadi perhatian utama secara global, khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dalam situasi di mana faktor risiko telah teridentifikasi sejak masa kehamilan, pendekatan pencegahan yang efektif, deteksi dini, penanganan preventif, serta persiapan optimal sebelum proses persalinan menjadi kunci untuk mencapai hasil persalinan yang aman dan sehat.

Upaya pencegahan ini sangat penting mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh komplikasi selama persalinan risiko tinggi cukup serius dan berpotensi mengancam jiwa. Komplikasi tersebut meliputi perdarahan hebat postpartum, preeklamsia atau eklamsia, persalinan prematur, ruptur uteri (pecah rahim), distosia bahu (kesulitan melahirkan karena bahu bayi tersangkut), hingga kondisi kegawatdaruratan janin yang mengharuskan tindakan medis darurat. Oleh karena itu, apabila faktor-faktor risiko ini dapat dikenali dan dikelola sejak dini, kemungkinan komplikasi serius ini terjadi dapat ditekan secara signifikan.

Deteksi dini faktor risiko menjadi langkah awal yang sangat krusial dalam upaya pencegahan komplikasi selama persalinan. Deteksi ini dilakukan melalui skrining antenatal yang rutin, pemeriksaan fisik teratur, pemantauan ultrasonografi secara berkala, serta pengujian laboratorium yang sesuai. Dengan deteksi dini yang akurat dan tepat waktu, tenaga kesehatan dapat mengembangkan strategi pengelolaan persalinan yang lebih efektif dan aman. Contohnya, ibu dengan riwayat

hipertensi kronik atau preeklamsia dapat segera dirujuk ke fasilitas kesehatan dengan perlengkapan medis memadai sebelum persalinan berlangsung, sehingga komplikasi serius seperti eklamsia dapat dicegah.

Selain deteksi dini, penanganan preventif juga memainkan peranan sangat penting dalam pencegahan komplikasi persalinan risiko tinggi. Penanganan preventif mencakup berbagai intervensi medis dan non-medis yang bertujuan mengurangi risiko kejadian komplikasi selama proses persalinan berlangsung. Intervensi medis preventif seperti pemberian obat antihipertensi pada ibu dengan preeklamsia, pemberian kortikosteroid untuk mempercepat pematangan paru-paru janin pada ibu dengan risiko persalinan prematur, atau pemberian profilaksis antibiotik pada kasus ketuban pecah dini dapat secara efektif mengurangi kemungkinan komplikasi yang serius. Di sisi lain, intervensi non-medis yang berupa edukasi kesehatan tentang pola hidup sehat, teknik relaksasi, manajemen stres, serta dukungan psikososial bagi ibu hamil juga terbukti mampu memberikan hasil positif dalam mengurangi potensi komplikasi selama persalinan.

Selain deteksi dini dan intervensi preventif, persiapan optimal dalam menghadapi persalinan risiko tinggi juga tidak kalah penting. Persiapan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kesiapan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan yang terlatih, hingga perencanaan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila diperlukan. Ibu hamil dengan faktor risiko tinggi perlu menjalani perencanaan persalinan yang komprehensif, meliputi pemilihan lokasi persalinan yang aman dan dilengkapi dengan fasilitas medis serta tenaga spesialis yang mampu menangani komplikasi berat. Dengan persiapan yang matang dan optimal, penanganan terhadap setiap komplikasi yang mungkin timbul dapat segera diberikan secara tepat waktu, sehingga mengurangi risiko morbiditas dan mortalitas ibu maupun janin.

Secara keseluruhan, pencegahan komplikasi dalam persalinan risiko tinggi adalah sebuah proses yang membutuhkan pendekatan multidisiplin dan kolaboratif antara berbagai pihak. Dokter spesialis kandungan, bidan, dokter spesialis penyakit dalam, ahli anestesi, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya harus bekerja sama secara harmonis dalam satu tim yang saling mendukung dan saling menguatkan. Selain itu, dukungan dari keluarga serta lingkungan sosial juga sangat diperlukan agar ibu hamil dapat menjalani persalinannya dengan rasa aman, nyaman, dan percaya diri.

B. Identifikasi Dini Faktor Risiko Persalinan

Identifikasi dini terhadap faktor-faktor risiko dalam persalinan merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan keselamatan ibu dan janin selama proses persalinan. Identifikasi ini dilakukan melalui serangkaian metode dan pendekatan komprehensif yang memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, untuk memprediksi potensi komplikasi yang dapat timbul selama persalinan, sehingga intervensi preventif yang tepat dapat segera direncanakan dan dilaksanakan.

Salah satu pendekatan mendasar dalam mengidentifikasi risiko persalinan adalah dengan mengevaluasi riwayat obstetri ibu. Riwayat obstetri sebelumnya menjadi acuan awal yang sangat berharga karena kondisi kehamilan dan persalinan sebelumnya sering kali memberikan gambaran tentang kemungkinan komplikasi yang akan muncul pada persalinan berikutnya. Misalnya, seorang ibu yang pada kehamilan sebelumnya mengalami preeklamsia, eklamsia, perdarahan postpartum berat, persalinan prematur, atau operasi caesar darurat memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi risiko yang sama atau bahkan lebih berat pada kehamilan berikutnya. Melalui wawancara mendalam atau anamnesis yang dilakukan sejak awal kehamilan, tenaga kesehatan dapat memperoleh informasi penting mengenai riwayat komplikasi persalinan sebelumnya, yang kemudian menjadi dasar dalam menyusun rencana pengelolaan persalinan secara lebih hati-hati dan spesifik.

Selain itu, identifikasi dini juga dilakukan melalui pemeriksaan antenatal rutin yang dilakukan secara berkala selama masa kehamilan. Pemeriksaan antenatal rutin ini tidak hanya berfungsi untuk mengevaluasi pertumbuhan dan perkembangan janin, tetapi juga membantu mendeteksi dini berbagai kondisi medis yang berpotensi menjadi komplikasi serius saat persalinan. Dalam pemeriksaan antenatal, beberapa hal yang dipantau secara rutin meliputi tekanan darah ibu, kenaikan berat badan, tinggi fundus uteri, detak jantung janin, serta tanda-tanda klinis lainnya seperti adanya edema (pembengkakan), proteinuria (protein dalam urin), atau tanda-tanda infeksi saluran kemih. Misalnya, peningkatan tekanan darah secara bertahap yang ditemukan dalam beberapa kunjungan antenatal dapat menjadi indikator awal munculnya preeklamsia. Jika kondisi ini tidak segera diidentifikasi dan ditangani secara preventif, maka risiko komplikasi serius seperti eklamsia atau solusio plasenta dapat meningkat drastis. Oleh karena itu, pemeriksaan antenatal rutin yang dijadwalkan secara teratur memiliki peran sentral dalam memastikan faktor risiko dapat dikenali sejak awal.

Di samping riwayat obstetri dan pemeriksaan antenatal rutin, identifikasi dini faktor risiko juga dilakukan melalui pemeriksaan penunjang seperti ultrasonografi (USG) dan pemeriksaan laboratorium khusus. Pemeriksaan ultrasonografi

memberikan gambaran visual yang akurat mengenai kondisi janin, plasenta, cairan ketuban, dan struktur anatomi rahim secara real-time. Dengan USG, tenaga kesehatan dapat mendeteksi berbagai kondisi patologis yang dapat meningkatkan risiko komplikasi persalinan. Misalnya, melalui USG dapat diketahui adanya plasenta previa (plasenta menutupi jalan lahir), oligohidramnion (volume cairan ketuban kurang), polihidramnion (kelebihan cairan ketuban), atau gangguan pertumbuhan janin seperti intrauterine growth restriction (IUGR). Kondisi-kondisi ini menandakan bahwa ibu memerlukan pemantauan yang lebih ketat dan intervensi medis tertentu sebelum persalinan, seperti persalinan induksi lebih awal atau operasi caesar yang terencana, guna mencegah komplikasi yang lebih parah saat melahirkan.

Selanjutnya, pemeriksaan laboratorium khusus juga menjadi bagian penting dalam proses identifikasi dini. Pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan kadar hemoglobin, profil gula darah, tes fungsi hati dan ginjal, serta skrining infeksi seperti HIV, hepatitis B, sifilis, dan infeksi saluran kemih, dapat mendeteksi secara dini berbagai kondisi yang secara signifikan meningkatkan risiko persalinan. Sebagai contoh, kadar gula darah yang tinggi pada pemeriksaan laboratorium dapat mengindikasikan adanya diabetes gestasional, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan makrosomia janin (bayi besar) yang meningkatkan risiko distosia bahu atau cedera persalinan lainnya. Demikian pula, kadar hemoglobin yang rendah (anemia) dapat menandakan tingginya risiko perdarahan postpartum yang memerlukan perhatian ekstra saat proses persalinan berlangsung.

C. Perencanaan Persalinan secara Komprehensif

Perencanaan persalinan secara komprehensif merupakan bagian penting dalam manajemen persalinan risiko tinggi, yang bertujuan untuk memastikan keselamatan ibu dan janin melalui langkah-langkah yang jelas, terstruktur, dan disesuaikan dengan kondisi medis serta kebutuhan spesifik setiap ibu hamil. Proses ini tidak sekadar menentukan tempat dan waktu persalinan, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting lainnya, seperti pemilihan fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat, persiapan tim kesehatan yang multidisiplin, serta kesiapan sistem rujukan yang cepat dan efektif untuk menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi selama persalinan berlangsung.

Pemilihan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan langkah pertama dan sangat strategis dalam penyusunan rencana persalinan yang komprehensif. Dalam konteks persalinan risiko tinggi, tidak semua fasilitas kesehatan mampu menyediakan layanan yang diperlukan untuk menghadapi kemungkinan komplikasi persalinan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan bersama ibu dan keluarganya harus mempertimbangkan dengan hati-hati pemilihan fasilitas yang memiliki sarana dan

prasarana medis yang lengkap serta mampu menangani kasus persalinan berisiko tinggi. Fasilitas kesehatan yang ideal untuk persalinan risiko tinggi adalah fasilitas yang dilengkapi dengan unit perawatan intensif ibu dan bayi baru lahir (NICU), peralatan penunjang medis canggih seperti ultrasonografi canggih, kardiotokografi (CTG), fasilitas operasi bedah caesar darurat, bank darah yang tersedia 24 jam, serta tenaga spesialis obstetri dan neonatologi yang siap sedia sepanjang waktu. Dengan pemilihan fasilitas kesehatan yang tepat, potensi komplikasi dapat dikelola secara cepat dan efektif, sehingga dampak buruk terhadap ibu maupun janin bisa diminimalisasi.

Setelah menentukan fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat, langkah penting berikutnya adalah persiapan tim kesehatan multidisiplin yang akan terlibat dalam proses persalinan tersebut. Pada kasus persalinan risiko tinggi, pendekatan multidisiplin menjadi sangat krusial karena kondisi yang dihadapi sering kali membutuhkan keahlian lebih dari satu spesialisasi medis. Tim multidisiplin yang ideal terdiri atas dokter spesialis obstetri-ginekologi yang bertanggung jawab atas jalannya persalinan, dokter spesialis anestesi untuk mengelola nyeri persalinan atau bila diperlukan anestesi darurat, dokter spesialis neonatologi untuk menangani bayi yang baru lahir dengan komplikasi atau prematuritas, dokter spesialis penyakit dalam apabila ibu memiliki penyakit penyerta seperti diabetes mellitus atau hipertensi, serta tenaga kesehatan lain seperti bidan dan perawat yang berpengalaman dalam penanganan persalinan risiko tinggi. Selain itu, tenaga pendukung seperti ahli laboratorium, petugas bank darah, serta tenaga gizi juga perlu disiapkan secara khusus. Dengan adanya koordinasi yang baik dan kolaborasi yang harmonis antar berbagai tenaga kesehatan ini, penanganan komplikasi yang muncul selama proses persalinan dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien.

Aspek lain yang tidak kalah pentingnya dalam perencanaan persalinan secara komprehensif adalah kesiapan rujukan darurat. Persalinan risiko tinggi sering kali bersifat tidak dapat diprediksi secara pasti, di mana kondisi ibu atau janin dapat memburuk secara tiba-tiba selama proses persalinan. Oleh karena itu, fasilitas kesehatan yang menangani persalinan risiko tinggi wajib memiliki sistem rujukan yang efektif, cepat, dan terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi atau terspesialisasi. Sistem rujukan ini mencakup kesiapan transportasi medis darurat (ambulans khusus) yang dilengkapi dengan peralatan medis lengkap dan tim medis yang mampu memberikan pertolongan pertama selama perjalanan, komunikasi yang efektif antar fasilitas kesehatan untuk memastikan informasi klinis pasien tersampaikan dengan cepat dan akurat, serta koordinasi yang jelas dengan fasilitas rujukan mengenai kesiapan menerima pasien dan tindakan medis lanjutan yang diperlukan. Dengan kesiapan rujukan yang optimal ini, pasien dapat segera

mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan tanpa adanya keterlambatan yang dapat berakibat fatal bagi ibu maupun bayi.

Selain tiga aspek utama tersebut, perencanaan persalinan secara komprehensif juga harus melibatkan partisipasi aktif ibu dan keluarga dalam proses perencanaan tersebut. Edukasi dan konseling yang jelas harus diberikan kepada ibu dan keluarganya tentang kemungkinan risiko yang bisa terjadi selama persalinan, tindakan preventif yang harus dilakukan, serta tanda-tanda bahaya yang harus segera dilaporkan kepada tenaga kesehatan. Keterlibatan keluarga dalam proses ini akan meningkatkan kesiapan mental dan emosional, serta membantu mengurangi rasa cemas dan stres yang sering kali muncul menjelang persalinan, khususnya dalam kondisi berisiko tinggi.

D. Monitoring Ketat Selama Persalinan

Monitoring ketat selama persalinan merupakan aspek esensial dalam manajemen persalinan risiko tinggi, bertujuan untuk mendeteksi secara dini setiap perubahan kondisi ibu dan janin yang berpotensi berkembang menjadi komplikasi serius. Dalam persalinan risiko tinggi, berbagai komplikasi seperti gangguan denyut jantung janin, gangguan kontraksi uterus, hipertensi mendadak, perdarahan, maupun tanda-tanda kelelahan pada ibu dapat muncul secara tiba-tiba dan berkembang dengan cepat, sehingga pemantauan ketat menjadi langkah yang sangat penting untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Dalam proses ini, pemantauan yang dilakukan tidak hanya sekadar melihat kondisi fisik ibu, tetapi juga mencakup kondisi janin serta progres persalinan secara keseluruhan.

Salah satu metode utama dalam pemantauan persalinan risiko tinggi adalah penggunaan kardiotokografi (CTG) secara kontinu. Kardiotokografi merupakan alat pemantauan elektronik yang memungkinkan tenaga kesehatan memonitor secara real-time denyut jantung janin bersamaan dengan aktivitas kontraksi rahim ibu. Pada persalinan risiko tinggi, CTG kontinu menjadi standar penting karena mampu mendeteksi gangguan kesejahteraan janin secara cepat, seperti denyut jantung yang tidak normal (bradikardia atau takikardia janin), variabilitas yang menurun, atau pola denyut jantung janin yang tidak reassuring, seperti deselerasi yang terlambat atau berkepanjangan. Dengan CTG, tenaga kesehatan dapat segera mengidentifikasi apakah janin mengalami stres atau hipoksia (kekurangan oksigen), sehingga tindakan intervensi dapat dilakukan secara tepat waktu, seperti pemberian oksigen tambahan kepada ibu, perubahan posisi ibu, atau bahkan mempercepat persalinan melalui tindakan operatif seperti operasi caesar jika diperlukan.

Selain pemantauan kesejahteraan janin dengan CTG, pemantauan kondisi ibu juga merupakan bagian integral yang tidak kalah penting dalam monitoring ketat

selama persalinan risiko tinggi. Pemantauan tanda-tanda vital ibu secara teratur, termasuk tekanan darah, nadi, suhu tubuh, dan frekuensi pernapasan, harus dilakukan secara intensif dan dicatat dengan jelas dalam interval yang teratur, misalnya setiap 15-30 menit. Pemantauan tekanan darah sangat penting untuk mendeteksi secara dini komplikasi serius seperti preeklamsia atau hipertensi gestasional yang bisa meningkat mendadak selama proses persalinan. Perubahan tekanan darah yang signifikan dapat menjadi tanda awal komplikasi berat seperti stroke, eklampsia, atau gagal organ yang memerlukan intervensi medis darurat. Demikian pula, pemantauan suhu tubuh ibu secara rutin penting untuk mendeteksi infeksi intrauterin atau korioamnionitis yang mungkin berkembang selama persalinan, yang jika tidak segera diatasi dapat mengarah pada sepsis atau komplikasi infeksi serius lainnya. Dengan pemantauan tanda vital yang ketat ini, setiap perubahan kondisi ibu bisa segera diketahui dan tindakan medis yang tepat dapat dilakukan untuk mencegah kondisi semakin memburuk.

Selain pemantauan janin dan kondisi ibu, aspek lain yang juga memerlukan perhatian khusus adalah pengamatan ketat terhadap kemajuan proses persalinan. Persalinan risiko tinggi sering kali memiliki potensi untuk mengalami hambatan atau komplikasi pada proses pembukaan serviks dan penurunan kepala janin, sehingga pemantauan progres persalinan secara cermat melalui pemeriksaan dalam berkala menjadi hal penting. Pemeriksaan ini membantu tenaga kesehatan dalam menilai kecepatan dilatasi serviks, posisi kepala janin, dan tanda-tanda adanya hambatan persalinan seperti distosia bahu, distosia serviks, atau gangguan mekanik lain yang dapat memperpanjang proses persalinan serta meningkatkan risiko cedera pada ibu dan bayi. Pemantauan ini biasanya dicatat dalam partograf, sebuah alat dokumentasi grafis yang memungkinkan tim medis memvisualisasikan secara cepat kemajuan persalinan. Dengan partograf ini, apabila proses persalinan terlihat menyimpang dari pola normal, tenaga kesehatan dapat segera mengambil keputusan apakah intervensi tambahan, seperti stimulasi kontraksi, penggunaan instrumen bantu persalinan, atau persalinan operatif seperti bedah sesar, perlu segera dilakukan.

Lebih jauh lagi, dalam proses monitoring ketat selama persalinan risiko tinggi, pendekatan kolaboratif dari tim kesehatan menjadi sangat krusial. Dokter kandungan, bidan, dan perawat harus bekerja secara sinergis dan komunikasi antar mereka harus berjalan dengan baik, jelas, dan efektif. Setiap informasi atau perubahan kondisi ibu maupun janin harus dikomunikasikan dengan segera dan akurat antar anggota tim medis untuk meminimalisasi risiko keterlambatan tindakan. Sistem ini akan memastikan setiap tanda bahaya yang terdeteksi selama

pemantauan dapat segera diatasi secara efektif dengan tindakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik.

E. Pencegahan Komplikasi Melalui Manajemen Aktif Persalinan

Manajemen aktif dalam proses persalinan risiko tinggi merupakan pendekatan penting yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi komplikasi yang mungkin terjadi selama proses melahirkan. Manajemen aktif ini meliputi berbagai teknik dan intervensi medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan tujuan menjaga kondisi ibu tetap stabil, memperlancar proses persalinan, dan memastikan keselamatan ibu dan bayi. Dalam implementasinya, manajemen aktif persalinan memerlukan perhatian khusus pada beberapa aspek utama, seperti pengaturan posisi dan mobilisasi ibu, pemberian cairan dan nutrisi secara optimal, serta pengelolaan nyeri yang efektif selama proses persalinan berlangsung.

Pengaturan posisi dan mobilisasi ibu merupakan salah satu intervensi sederhana namun berdampak signifikan dalam pencegahan komplikasi persalinan risiko tinggi. Pada kondisi persalinan risiko tinggi, seperti ibu dengan hipertensi, diabetes gestasional, atau janin yang mengalami gangguan posisi, mobilisasi atau perubahan posisi ibu secara rutin dapat memberikan manfaat besar. Dengan memfasilitasi mobilisasi secara teratur, seperti berdiri, berjalan ringan, duduk tegak, atau menggunakan bola persalinan, dapat membantu memperbaiki sirkulasi darah ibu, mengurangi tekanan pada pembuluh darah utama, serta mempercepat penurunan kepala janin ke dalam jalan lahir secara alami. Hal ini akan mendukung kelancaran pembukaan serviks dan mengurangi risiko persalinan macet (distosia). Sebaliknya, posisi terlentang dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan gangguan peredaran darah, tekanan pada vena cava inferior, yang pada akhirnya mengurangi aliran darah ke janin, meningkatkan risiko hipoksia, dan memperlambat progres persalinan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan sangat dianjurkan untuk terus memotivasi dan membantu ibu dalam mencari posisi yang nyaman sekaligus mendukung proses persalinan secara optimal. Pendekatan ini akan membantu mengurangi stres fisik maupun emosional, serta mengurangi kemungkinan timbulnya komplikasi selama proses melahirkan.

Selain posisi dan mobilisasi, pemberian cairan dan nutrisi secara optimal juga menjadi bagian integral dalam manajemen aktif persalinan risiko tinggi. Persalinan merupakan proses fisik yang intens dan membutuhkan energi yang besar. Kekurangan cairan dan nutrisi selama persalinan dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan otot uterus, serta memperlambat kontraksi, yang pada gilirannya meningkatkan risiko persalinan lama dan komplikasi lain seperti infeksi intrauterin dan postpartum hemorrhage (perdarahan setelah persalinan). Oleh karena itu,

pemantauan ketat terhadap status hidrasi ibu harus dilakukan secara rutin, dan cairan harus diberikan baik melalui oral maupun intravena sesuai kebutuhan klinis. Pada ibu yang masih diperbolehkan makan selama persalinan, pemberian makanan atau minuman ringan yang mengandung karbohidrat sederhana dapat membantu menjaga energi ibu tetap stabil. Pada kondisi tertentu, seperti persalinan yang diperkirakan akan berlangsung lama atau jika ada risiko tinggi operasi caesar, pemberian cairan intravena secara preventif menjadi langkah esensial untuk mencegah dehidrasi berat dan mempertahankan keseimbangan elektrolit serta metabolisme tubuh ibu selama proses persalinan.

Pengelolaan nyeri yang efektif selama persalinan juga menjadi komponen penting dalam manajemen aktif persalinan risiko tinggi. Nyeri hebat yang tidak terkendali selama persalinan tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan fisik, tetapi juga memicu stres psikologis yang tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol, yang pada akhirnya akan menghambat produksi hormon oksitosin alami yang sangat penting dalam proses kontraksi rahim. Oleh sebab itu, pengendalian nyeri yang baik secara tidak langsung membantu menjaga kekuatan kontraksi uterus, meminimalkan durasi persalinan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi seperti persalinan macet, perdarahan postpartum, maupun distress janin akibat proses persalinan yang terlalu panjang.

Dalam pengelolaan nyeri, tenaga kesehatan dapat menggunakan pendekatan farmakologis maupun non-farmakologis. Pendekatan farmakologis, misalnya penggunaan analgesia epidural, analgesia spinal, atau analgesia intravena, memungkinkan kontrol nyeri yang efektif dengan tetap memperhatikan keamanan ibu dan janin. Analgesia epidural sering menjadi pilihan utama dalam persalinan risiko tinggi karena kemampuannya untuk mengurangi rasa sakit secara signifikan tanpa mengurangi kesadaran ibu. Sementara itu, pendekatan non-farmakologis seperti pijat ringan, teknik relaksasi dan pernapasan, terapi musik, hidroterapi, serta akupresur juga terbukti efektif dalam mengurangi nyeri dan stres, khususnya pada tahap awal persalinan atau ketika intervensi farmakologis memiliki keterbatasan klinis tertentu.

F. Penanganan Khusus Komplikasi Umum

Dalam konteks persalinan risiko tinggi, penanganan khusus terhadap komplikasi yang umum terjadi harus dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan berdasarkan standar klinis yang telah ditetapkan. Beberapa komplikasi yang paling sering terjadi dan memiliki dampak signifikan terhadap keselamatan ibu dan bayi antara lain preeklamsia dan eklamsia, perdarahan postpartum, distosia bahu dan

trauma kelahiran lainnya, serta persalinan prematur dan gawat janin. Setiap kondisi tersebut memerlukan perhatian khusus serta langkah-langkah penanganan yang tepat untuk mencegah dampak yang lebih berat dan fatal.

Salah satu komplikasi yang sangat serius dalam persalinan risiko tinggi adalah preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia ditandai dengan peningkatan tekanan darah yang signifikan selama kehamilan, disertai tanda-tanda kerusakan organ lain seperti protein dalam urin, gangguan fungsi hati, gangguan pembekuan darah, hingga edema paru. Jika tidak ditangani secara tepat, kondisi ini dapat berkembang menjadi eklamsia, di mana ibu mengalami kejang yang sangat membahayakan nyawa ibu maupun janin. Penanganan khusus pada preeklamsia melibatkan deteksi dini melalui pemantauan tekanan darah secara ketat, pemeriksaan laboratorium rutin (seperti fungsi hati dan ginjal, serta pemeriksaan protein dalam urin), dan pemberian obat antihipertensi untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Jika tanda-tanda memburuk, pemberian magnesium sulfat menjadi intervensi utama untuk mencegah kejang eklamsia. Dalam kondisi eklamsia, penanganan darurat yang mencakup stabilisasi kondisi ibu, pemberian magnesium sulfat dosis penuh, dan percepatan persalinan dengan induksi atau operasi sesar merupakan pilihan utama untuk menyelamatkan nyawa ibu dan janin.

Perdarahan postpartum merupakan komplikasi lain yang sering ditemui dalam persalinan risiko tinggi, terutama pada ibu dengan riwayat anemia, persalinan lama, atau gangguan kontraksi rahim (atonía uteri). Kondisi ini ditandai dengan perdarahan yang masif setelah bayi lahir, yang dapat dengan cepat menyebabkan syok hemoragik dan kematian apabila tidak ditangani segera. Pencegahan perdarahan postpartum mencakup manajemen aktif kala tiga persalinan, yang terdiri atas pemberian uterotonik seperti oksitosin segera setelah bayi lahir, serta pijat fundus uteri secara rutin untuk membantu rahim berkontraksi optimal. Jika perdarahan tetap terjadi, penanganan khusus meliputi pemberian obat tambahan seperti metilergometrin atau prostaglandin, terapi cairan intravena yang agresif untuk menjaga stabilitas hemodinamik, hingga intervensi bedah seperti tamponade balon intrauterin atau bahkan tindakan histerektomi dalam situasi darurat yang ekstrem.

Komplikasi persalinan berikutnya yang perlu perhatian ekstra adalah distosia bahu dan trauma kelahiran lainnya. Distosia bahu terjadi ketika bahu janin terjepit setelah kepala lahir, kondisi yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan cedera permanen pada bayi seperti cedera pleksus brakialis, patah tulang klavikula, atau bahkan asfiksia neonatal berat. Untuk mencegah dan menangani kondisi ini, tenaga kesehatan harus melakukan estimasi berat janin yang akurat melalui pemeriksaan ultrasonografi sebelum persalinan serta memastikan posisi ibu yang

mendukung kelancaran persalinan, seperti posisi McRoberts atau posisi lateral untuk memperlebar jalan lahir. Penanganan distosia bahu secara khusus melibatkan langkah-langkah manuver obstetri tertentu, seperti manuver McRoberts yang dikombinasikan dengan tekanan suprapubik yang terkoordinasi. Apabila manuver ini gagal, maka tindakan medis lanjut seperti manuver Rubin atau Woods corkscrew dapat dilakukan. Dalam kasus yang sangat sulit, pilihan terakhir bisa melibatkan tindakan bedah darurat seperti pemotongan tulang klavikula janin atau bedah sesar darurat.

Selanjutnya, komplikasi yang juga sering ditemukan dalam persalinan risiko tinggi adalah persalinan prematur dan kondisi gawat janin. Persalinan prematur, yaitu persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan mencapai 37 minggu, dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius bagi bayi baru lahir seperti gangguan pernapasan berat, infeksi neonatal, dan komplikasi neurologis jangka panjang. Pencegahan persalinan prematur meliputi identifikasi dini faktor risiko, pemberian progesteron pada ibu dengan riwayat persalinan prematur sebelumnya, serta pemantauan ketat melalui pemeriksaan ultrasonografi untuk menilai kondisi serviks ibu. Jika persalinan prematur tidak dapat dicegah, maka pemberian kortikosteroid untuk mempercepat pematangan paru janin menjadi prioritas utama. Selain itu, pemberian magnesium sulfat pada usia kehamilan kurang dari 32 minggu juga sangat bermanfaat dalam melindungi sistem saraf bayi.

Gawat janin selama persalinan, yang ditandai dengan penurunan detak jantung janin secara tiba-tiba atau pola detak jantung abnormal pada kardiotokografi (CTG), merupakan kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat untuk mencegah kematian janin atau cedera neurologis akibat kekurangan oksigen (hipoksia). Dalam menghadapi gawat janin, tindakan pertama adalah memperbaiki suplai oksigen ke janin melalui pemberian oksigen tambahan kepada ibu, mengubah posisi ibu ke sisi kiri, serta menghentikan pemberian oksitosin apabila sedang digunakan. Jika kondisi tidak membaik dengan cepat, persalinan darurat melalui operasi sesar harus segera dilakukan untuk memastikan keselamatan janin.

G. Peran Tim Multidisiplin dalam Pencegahan Komplikasi

Dalam menghadapi persalinan risiko tinggi, peran tim multidisiplin menjadi sangat penting dan menentukan dalam upaya mencegah komplikasi yang berpotensi mengancam keselamatan ibu maupun bayi. Kolaborasi interprofesional ini tidak hanya melibatkan tenaga kesehatan inti seperti bidan dan dokter kandungan, tetapi juga melibatkan spesialis anestesi, perawat, dokter spesialis anak atau neonatolog, ahli gizi, hingga petugas laboratorium dan tenaga kesehatan lainnya. Kehadiran dan keterlibatan aktif dari tim multidisiplin ini merupakan kunci

penting dalam memastikan proses persalinan yang aman, efektif, dan terhindar dari komplikasi serius.

Bidan sebagai tenaga kesehatan primer memiliki posisi strategis dalam proses pencegahan komplikasi. Perannya dimulai dari tahap deteksi dini faktor risiko, pemantauan kondisi ibu selama proses antenatal hingga persalinan berlangsung. Bidan memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan edukasi yang jelas kepada ibu dan keluarga mengenai tanda-tanda bahaya yang mungkin terjadi selama persalinan, serta langkah-langkah antisipatif yang harus diambil jika komplikasi terdeteksi. Selain itu, bidan juga memastikan komunikasi yang lancar antara ibu, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya, terutama dalam memfasilitasi proses rujukan yang cepat dan tepat ketika kondisi ibu atau bayi mengalami gangguan yang membutuhkan intervensi lanjut.

Dokter spesialis kandungan atau obstetri memiliki peran sentral dalam tim multidisiplin, terutama dalam mengambil keputusan klinis yang kritis terkait manajemen persalinan risiko tinggi. Dokter kandungan bertanggung jawab untuk mengevaluasi secara menyeluruh kondisi ibu dan janin melalui pemeriksaan ultrasonografi, kardiotokografi (CTG), dan pemeriksaan klinis lainnya. Berdasarkan evaluasi tersebut, dokter kandungan dapat menentukan rencana persalinan yang paling aman, termasuk apakah persalinan normal masih memungkinkan atau perlu dilakukan tindakan bedah seperti operasi sesar. Di samping itu, dokter kandungan juga berperan sebagai pemimpin tim dalam menghadapi situasi emergensi, memberikan panduan klinis kepada seluruh anggota tim kesehatan, serta memastikan bahwa intervensi medis yang dilakukan telah sesuai dengan standar pelayanan kebidanan dan obstetri yang berlaku.

Spesialis anestesi memiliki peran penting dalam penanganan nyeri selama persalinan dan kesiapan tindakan anestesi bila persalinan memerlukan intervensi bedah. Pada persalinan risiko tinggi, pengendalian nyeri yang optimal sangat penting bukan hanya untuk kenyamanan ibu, tetapi juga untuk menjaga kestabilan kondisi medis ibu, seperti tekanan darah dan fungsi kardiovaskular lainnya. Dalam situasi darurat seperti perdarahan hebat atau operasi sesar yang mendadak, spesialis anestesi bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas hemodinamik ibu melalui teknik anestesi yang aman, pengelolaan cairan intravena yang tepat, dan pemantauan intensif selama prosedur berlangsung. Keberadaan spesialis anestesi yang responsif dan kompeten dapat secara signifikan meningkatkan keselamatan ibu serta menekan risiko komplikasi anestesi.

Perawat berperan penting dalam memastikan pemantauan intensif kondisi ibu dan janin selama persalinan, meliputi observasi tanda vital secara ketat, dokumentasi perkembangan persalinan, serta komunikasi secara efektif antar anggota tim

kesehatan. Perawat juga bertugas dalam memberikan dukungan psikologis dan emosional kepada ibu serta keluarga, membantu mereka menghadapi kecemasan dan ketidakpastian selama proses persalinan berlangsung. Tugas perawat tidak berhenti pada aspek klinis saja, melainkan juga mencakup pemberian edukasi, konseling, serta penguatan kapasitas keluarga untuk turut aktif dalam pemantauan tanda-tanda komplikasi persalinan.

Dokter spesialis anak atau neonatolog juga menjadi bagian integral dari tim multidisiplin, terutama dalam konteks persalinan risiko tinggi yang berpotensi menyebabkan bayi mengalami gangguan segera setelah kelahiran. Neonatolog memiliki peran utama dalam menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk menangani bayi baru lahir yang mengalami komplikasi neonatal seperti prematuritas, asfiksia, gangguan pernapasan, atau trauma kelahiran. Kesiapan tenaga neonatologi beserta fasilitas pendukung seperti inkubator, ventilasi mekanis, dan ruang perawatan intensif neonatus (NICU) sangat penting untuk memastikan bayi mendapatkan perawatan optimal sesegera mungkin setelah lahir.

Selain tenaga inti tersebut, peran pendukung lain seperti ahli gizi juga menjadi sangat penting dalam persalinan risiko tinggi, terutama bagi ibu yang memiliki gangguan metabolisme seperti diabetes atau kondisi malnutrisi. Ahli gizi bertugas memberikan panduan nutrisi yang tepat selama kehamilan dan persalinan untuk membantu menjaga kondisi fisiologis ibu tetap stabil dan optimal. Tenaga laboratorium turut mendukung tim multidisiplin dengan menyediakan data laboratorium secara cepat dan akurat, seperti pemeriksaan darah, fungsi hati dan ginjal, serta analisis cairan tubuh lainnya, yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan medis yang tepat.

H. Dukungan Psikososial bagi Ibu dan Keluarga

Dalam menghadapi persalinan risiko tinggi, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek klinis dan medis semata, melainkan juga pada aspek psikososial yang melibatkan dukungan emosional, psikologis, serta sosial bagi ibu dan keluarganya. Kondisi risiko tinggi selama persalinan dapat menyebabkan ibu mengalami tekanan emosional yang signifikan, seperti kecemasan, stres, hingga perasaan takut yang mendalam terkait keselamatan dirinya maupun bayi yang akan dilahirkan. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang menyeluruh, di mana dukungan psikososial menjadi bagian integral dari perawatan persalinan, sangat penting untuk diterapkan secara konsisten.

Dukungan psikososial bagi ibu hamil dengan risiko tinggi harus diberikan sejak masa antenatal atau sebelum persalinan terjadi. Pada tahap ini, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam memberikan edukasi yang jelas dan transparan

tentang kondisi ibu, potensi risiko yang dihadapi, serta berbagai skenario penanganan yang mungkin terjadi selama persalinan. Informasi yang jelas dan akurat ini membantu ibu dan keluarganya untuk memahami situasi yang dihadapi secara lebih realistis, sekaligus mengurangi ketidakpastian yang dapat memperbesar kecemasan mereka. Selain itu, pada tahap ini juga penting untuk memberikan konseling khusus yang mampu mengidentifikasi serta menangani masalah psikologis seperti depresi atau kecemasan berlebihan, yang jika tidak tertangani dengan baik dapat memperberat risiko komplikasi fisik selama persalinan.

Selama proses persalinan berlangsung, dukungan psikososial menjadi lebih penting lagi. Dalam situasi persalinan risiko tinggi, perasaan ibu umumnya bercampur antara rasa takut, khawatir, hingga rasa tidak berdaya akibat kondisi yang sulit diprediksi. Dalam kondisi ini, peran tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, maupun tenaga kesehatan lain menjadi sangat penting sebagai pendamping yang memberikan dukungan emosional secara intensif. Kehadiran pendamping profesional yang memberikan empati, perhatian, serta komunikasi yang baik dapat sangat membantu menenangkan ibu, mengurangi stres dan rasa takut, serta membuat ibu lebih mampu untuk mengikuti arahan medis dengan tenang dan kooperatif.

Peran keluarga juga menjadi sangat krusial dalam memberikan dukungan psikososial yang efektif selama persalinan risiko tinggi. Keterlibatan pasangan atau keluarga terdekat dalam proses persalinan memberikan rasa aman dan nyaman bagi ibu, sehingga dapat membantu mengurangi kecemasan secara signifikan. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu melibatkan keluarga dalam proses edukasi mengenai kondisi ibu, serta memberikan panduan tentang cara memberikan dukungan emosional yang tepat. Keluarga harus dipersiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan situasi selama persalinan, termasuk skenario darurat, sehingga mereka tidak merasa panik atau bingung ketika situasi sulit terjadi.

Setelah persalinan berlangsung, baik yang berakhir dengan kondisi normal maupun dengan komplikasi yang membutuhkan tindakan medis tertentu, dukungan psikososial harus terus diberikan secara konsisten. Masa pasca persalinan merupakan periode sensitif di mana ibu dapat mengalami berbagai gangguan emosional seperti depresi postpartum, kecemasan berkelanjutan, atau trauma akibat pengalaman persalinan yang sulit. Pada fase ini, peran tenaga kesehatan dalam memberikan konseling pasca persalinan, membantu ibu mengelola stres, dan memberikan edukasi tentang perawatan bayi yang lahir dari persalinan risiko tinggi menjadi sangat penting. Dukungan ini membantu ibu merasa lebih percaya diri

dalam menjalankan perannya sebagai ibu baru, serta memastikan bahwa gangguan psikologis yang timbul pasca persalinan dapat segera ditangani secara efektif.

Dalam memberikan dukungan psikososial, tenaga kesehatan juga harus bekerja sama dengan tenaga profesional lain seperti psikolog klinis atau konselor profesional jika diperlukan. Pendekatan interprofesional ini memastikan bahwa masalah psikologis yang dialami ibu dan keluarganya dapat teridentifikasi secara dini dan tertangani secara holistik dan terintegrasi. Lebih lanjut, penting untuk menghubungkan keluarga dengan berbagai kelompok pendukung atau komunitas ibu yang pernah mengalami persalinan risiko tinggi, sehingga mereka dapat berbagi pengalaman, saling mendukung, serta mendapatkan pemahaman bahwa mereka tidak sendiri dalam menghadapi situasi sulit tersebut.

I. Evaluasi dan Monitoring Pasca Persalinan

Evaluasi dan monitoring pasca persalinan merupakan komponen penting dalam manajemen persalinan risiko tinggi yang tidak dapat dianggap remeh. Setelah proses persalinan, terutama yang disertai risiko komplikasi tinggi, ibu dan bayi membutuhkan pemantauan intensif serta evaluasi yang teratur untuk memastikan bahwa kondisi kesehatan keduanya tetap stabil dan komplikasi yang mungkin muncul dapat dideteksi serta ditangani seawal mungkin.

Dalam periode pasca persalinan, kondisi kesehatan ibu perlu diperiksa secara menyeluruh, mengingat potensi komplikasi serius masih dapat terjadi bahkan setelah bayi dilahirkan. Evaluasi ini mencakup pemantauan ketat terhadap tanda-tanda vital ibu seperti tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, suhu tubuh, serta kondisi perdarahan. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini komplikasi umum seperti perdarahan postpartum, infeksi postpartum, atau gangguan tekanan darah yang dapat berkembang secara tiba-tiba pasca persalinan. Pemeriksaan rutin terhadap rahim, luka bekas operasi caesar atau episiotomi, dan kondisi umum ibu juga dilakukan secara reguler untuk memastikan proses penyembuhan berlangsung normal dan tidak terjadi infeksi atau komplikasi lain yang dapat memperburuk kondisi kesehatan ibu.

Selain pemantauan fisik, evaluasi kondisi emosional dan psikologis ibu setelah persalinan juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan secara serius. Banyak ibu, terutama yang mengalami persalinan risiko tinggi, berisiko mengalami gangguan emosional seperti kecemasan berat, baby blues, hingga depresi postpartum. Oleh karena itu, tenaga kesehatan perlu melakukan skrining psikologis yang terstruktur serta wawancara mendalam secara berkala untuk mendeteksi tanda-tanda awal gangguan emosional tersebut. Jika gejala ditemukan, intervensi yang tepat seperti konseling profesional atau pendampingan psikologis harus

segera diberikan. Dukungan keluarga serta lingkungan yang suportif juga perlu dipastikan agar ibu dapat pulih secara emosional dan mampu menyesuaikan diri dengan baik dalam menjalani perannya sebagai ibu baru.

Di sisi lain, monitoring kondisi bayi yang lahir dari persalinan risiko tinggi juga sama pentingnya. Bayi tersebut seringkali memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan, infeksi neonatal, hipoglikemia, ikterus (kuning), atau gangguan tumbuh kembang akibat kelahiran prematur maupun komplikasi yang terjadi selama persalinan. Evaluasi awal kondisi bayi segera setelah lahir meliputi pemeriksaan fisik menyeluruh, pemantauan suhu tubuh, denyut jantung, pernapasan, dan kemampuan bayi dalam menerima asupan nutrisi, baik melalui pemberian ASI maupun formula khusus apabila diperlukan. Pada bayi dengan kondisi khusus atau lahir prematur, pemantauan lebih intensif di ruang NICU (Neonatal Intensive Care Unit) atau ruang perawatan khusus neonatus sangat diperlukan untuk memastikan setiap tanda komplikasi dapat dikenali sejak dini dan intervensi medis yang tepat dapat segera dilakukan.

Selama masa rawat inap pasca persalinan, evaluasi dan pemantauan dilakukan secara rutin dan terjadwal. Namun, penting pula untuk merencanakan pemeriksaan lanjutan setelah ibu dan bayi dipulangkan ke rumah. Pemeriksaan lanjutan ini, biasanya disebut sebagai kunjungan postnatal, dilakukan dalam beberapa hari pertama hingga beberapa minggu setelah persalinan. Dalam kunjungan ini, kondisi kesehatan ibu dan bayi dievaluasi kembali secara detail untuk memastikan tidak ada komplikasi yang terlambat terdeteksi atau muncul setelah pulang ke rumah. Ibu dan keluarga juga diberikan edukasi yang komprehensif mengenai tanda-tanda bahaya pasca persalinan yang perlu segera dilaporkan ke tenaga kesehatan, seperti demam tinggi, perdarahan yang banyak, nyeri hebat di perut, atau gangguan dalam menyusui dan perawatan bayi.

Selain kunjungan secara langsung, evaluasi pasca persalinan juga bisa didukung oleh pemanfaatan teknologi kesehatan digital, seperti telemedicine atau aplikasi kesehatan khusus untuk ibu baru melahirkan. Dengan bantuan teknologi ini, ibu dan keluarga dapat melaporkan kondisi kesehatan secara berkala kepada tenaga kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan, sehingga deteksi dini terhadap komplikasi pasca persalinan tetap dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

J. Simpulan

Pencegahan komplikasi dalam persalinan risiko tinggi merupakan aspek penting dalam meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan ibu maupun bayi. Berbagai strategi pencegahan yang diterapkan secara terstruktur, mulai dari deteksi

dini faktor risiko, perencanaan persalinan yang komprehensif, hingga monitoring intensif selama persalinan, terbukti efektif dalam mengurangi morbiditas dan mortalitas ibu serta neonatal.

Identifikasi dini terhadap faktor risiko melalui evaluasi riwayat obstetri, pemeriksaan antenatal rutin, pemeriksaan ultrasonografi, dan laboratorium khusus merupakan langkah awal yang krusial. Dengan mengenali faktor risiko sejak awal, tenaga kesehatan dapat melakukan intervensi preventif yang tepat guna mencegah berkembangnya komplikasi lebih lanjut.

Perencanaan persalinan secara komprehensif, termasuk pemilihan fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat, kesiapan tim kesehatan multidisiplin, dan sistem rujukan darurat yang cepat dan efektif, juga menjadi elemen penting dalam menghadapi persalinan risiko tinggi. Dengan perencanaan yang matang, intervensi yang tepat waktu dan akurat dapat dilakukan ketika komplikasi muncul.

Selama proses persalinan, monitoring ketat terhadap kondisi ibu dan janin melalui berbagai metode seperti pemantauan kardiotokografi (CTG), pengamatan tanda vital ibu secara teratur, dan evaluasi perkembangan persalinan melalui partograf menjadi sangat penting. Melalui monitoring intensif ini, komplikasi serius dapat dideteksi sejak dini, sehingga tindakan medis dapat segera diambil.

Manajemen aktif persalinan yang mencakup pengaturan posisi dan mobilisasi ibu, pemberian cairan dan nutrisi optimal, serta pengelolaan nyeri yang efektif, terbukti dapat membantu memperlancar persalinan, mencegah komplikasi, dan meningkatkan kenyamanan ibu selama proses melahirkan.

Penanganan khusus terhadap komplikasi umum, seperti preeklamsia dan eklamsia, perdarahan postpartum, distosia bahu, persalinan prematur, dan kondisi gawat janin, memerlukan perhatian khusus dan langkah-langkah medis yang tepat. Tindakan yang cepat dan akurat dalam menghadapi komplikasi ini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa ibu dan bayi.

Keberhasilan dalam pencegahan komplikasi persalinan risiko tinggi juga sangat ditentukan oleh peran tim multidisiplin. Kolaborasi yang efektif antara bidan, dokter spesialis kandungan, spesialis anestesi, perawat, dokter neonatologi, serta tenaga pendukung lainnya menjadi faktor kunci dalam menjamin proses persalinan yang aman dan optimal.

Selain itu, dukungan psikososial yang holistik bagi ibu dan keluarga sebelum, selama, dan setelah persalinan memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi stres, kecemasan, serta gangguan emosional yang dapat memperburuk kondisi ibu secara klinis. Pendekatan psikososial ini perlu diterapkan secara konsisten agar ibu dapat menjalani proses persalinan dengan lebih nyaman dan percaya diri.

K. Referensi

- American Academy of Family Physicians. (2006). Preventing postpartum hemorrhage: Managing the third stage of labor. *American Family Physician*, 73(6), 1025–1032.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). Preeclampsia and high blood pressure during pregnancy: Frequently asked questions. Washington, DC: ACOG.
- Gomez, P., Kinzie, B., & Metcalfe, G. (2005). Active management of the third stage of labor: A demonstration. JHPIEGO Corporation.
- Hofmeyr, G. J., Mshweshwe, N. T., & Gülmezoglu, A. M. (2019). Controlled cord traction for the third stage of labour. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2019(1), CD008020.
- Mayo Clinic. (2022). Preeclampsia – Diagnosis and treatment. Mayo Foundation for Medical Education and Research.
- United States Preventive Services Task Force. (2024). Screening for hypertensive disorders in pregnancy: Recommendation statement. *Journal of the American Medical Association*, 331(9), 873–880.
- World Health Organization. (2007). Prevention of postpartum haemorrhage by active management of the third stage of labour: Making pregnancy safer technical update. Geneva: WHO Press.
- World Health Organization. (2025). Pre-eclampsia fact sheet. Geneva: WHO Press.
- Verywell Health. (2024, December 1). Can high blood pressure during pregnancy cause complications? Verywell Health.
- Nature Communications. (2025, May 15). New at-home blood test shows risk of developing preeclampsia. *Parents Magazine*.

L. Glosarium

- **Persalinan Risiko Tinggi**

Persalinan yang terjadi pada ibu dengan kondisi medis atau komplikasi tertentu yang meningkatkan risiko masalah kesehatan serius bagi ibu dan bayi selama proses persalinan.

- **Deteksi Dini**

Identifikasi awal terhadap kondisi atau faktor risiko yang berpotensi menyebabkan komplikasi selama persalinan, melalui pemeriksaan dan evaluasi medis sejak masa kehamilan.

- **Preeklamsia**

Komplikasi kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi, protein dalam urin, dan tanda-tanda kerusakan organ lain, yang jika tidak ditangani tepat waktu, dapat berkembang menjadi kondisi serius atau bahkan fatal.

- **Eklamsia**

Kondisi yang lebih berat dari preeklamsia, ditandai dengan terjadinya kejang pada ibu hamil yang merupakan komplikasi serius yang memerlukan penanganan darurat medis segera.

- **Perdarahan Postpartum**

Kehilangan darah yang berlebihan setelah proses persalinan yang dapat menyebabkan kondisi syok hemoragik, dan merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu setelah melahirkan.

- **Distosia Bahu**

Kondisi saat bahu bayi terjepit dan tersangkut di jalan lahir setelah kepala bayi keluar, yang berisiko menyebabkan cedera serius atau komplikasi pada bayi maupun ibu.

- **Kardiotokografi (CTG)**

Alat medis elektronik yang digunakan untuk memonitor denyut jantung janin secara bersamaan dengan aktivitas kontraksi rahim ibu selama proses persalinan.

- **Intervensi Preventif**

Tindakan medis atau non-medis yang dilakukan secara dini untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi selama proses persalinan berlangsung.

- **Partograf**

Grafik atau diagram khusus yang digunakan untuk mencatat dan memantau perkembangan proses persalinan secara visual dan terstruktur, agar tim medis dapat mengenali secara cepat bila ada hambatan atau masalah yang muncul.

- **Dukungan Psikososial**

Bantuan emosional, psikologis, dan sosial yang diberikan kepada ibu hamil dan keluarganya sebelum, selama, serta sesudah persalinan, bertujuan untuk mengurangi stres, kecemasan, dan gangguan emosional yang dapat memperberat kondisi ibu maupun proses persalinan.

CHAPTER 4

ASUHAN PADA IBU DENGAN RIWAYAT ABORTUS BERULANG

Bdn. Desi Br Sembiring, SST., M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Abortus berulang merupakan kondisi yang ditandai dengan terjadinya kehilangan kehamilan sebanyak dua kali atau lebih secara berturut-turut, khususnya pada trimester pertama atau kedua masa kehamilan. Abortus berulang dikenal pula dengan istilah "abortus habitualis" atau "recurrent pregnancy loss," di mana seorang ibu mengalami keguguran yang terjadi secara berurutan tanpa adanya kelahiran hidup di antara kejadian tersebut. Kondisi ini merupakan permasalahan kesehatan reproduksi yang cukup serius karena memiliki dampak luas tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis, emosional, bahkan sosial bagi ibu dan keluarganya.

Prevalensi kejadian abortus berulang diperkirakan bervariasi antara 1% hingga 5% dari total kehamilan secara global. Angka ini dapat meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia ibu, terutama pada usia lebih dari 35 tahun, karena peningkatan risiko kelainan genetik janin, gangguan hormonal, serta berbagai kondisi medis lainnya yang cenderung lebih banyak ditemukan pada kelompok usia tersebut. Di Indonesia sendiri, meskipun data statistik nasional terkait abortus berulang masih terbatas, berbagai penelitian klinis dan data dari fasilitas kesehatan menunjukkan adanya tren peningkatan kasus abortus berulang, khususnya pada populasi perkotaan yang lebih banyak menghadapi stres fisik dan emosional, serta paparan faktor lingkungan yang kurang mendukung kesehatan reproduksi.

Abortus berulang memiliki signifikansi klinis yang tinggi dalam konteks kesehatan reproduksi, karena kejadian ini sering kali merupakan manifestasi dari kondisi medis yang mendasari yang belum terdiagnosis sebelumnya. Misalnya, kelainan kromosom pada pasangan suami-istri, gangguan anatomi uterus seperti uterus septum atau adanya mioma uteri, sindrom antifosfolipid atau gangguan imunologis lain, serta kelainan endokrin seperti diabetes melitus, hipotiroidisme, dan hiperprolaktinemia. Oleh karena itu, kejadian abortus berulang sering kali menjadi titik awal bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, dokter kandungan, dan spesialis lainnya, untuk melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap kondisi kesehatan ibu secara menyeluruh. Dengan pendekatan diagnosis yang akurat dan komprehensif, diharapkan ibu dapat memperoleh intervensi yang tepat, sehingga

peluang kehamilan sehat dan berhasil melahirkan bayi yang sehat di masa depan dapat meningkat secara signifikan.

Dampak abortus berulang terhadap kondisi fisik ibu sangat beragam, mulai dari risiko komplikasi jangka pendek seperti perdarahan hebat, infeksi saluran reproduksi, hingga trauma fisik akibat prosedur medis untuk membersihkan jaringan yang tersisa di dalam rahim. Kondisi ini secara fisik dapat memengaruhi kesehatan reproduksi jangka panjang, seperti menyebabkan gangguan pada serviks, adhesi intrauterin (sindrom Asherman), hingga meningkatkan risiko infertilitas sekunder. Selain dampak fisik tersebut, abortus berulang memiliki konsekuensi yang jauh lebih dalam dan sering kali berkelanjutan terhadap aspek psikologis dan emosional ibu. Kehilangan kehamilan yang berulang dapat memicu perasaan bersalah, cemas, depresi, serta ketakutan yang mendalam terhadap kehamilan berikutnya. Bahkan, dalam beberapa kasus, ibu bisa mengalami trauma emosional yang berkepanjangan, penurunan rasa percaya diri, gangguan hubungan sosial, serta menurunnya kualitas hubungan suami-istri.

Dalam menghadapi permasalahan kompleks ini, penting bagi tenaga kesehatan untuk tidak hanya memberikan penanganan secara medis, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan holistik yang mencakup aspek emosional dan psikologis. Pendekatan holistik ini termasuk pemberian konseling psikologis, edukasi dan dukungan emosional yang intensif, baik kepada ibu maupun pasangannya. Dukungan ini bertujuan untuk membantu ibu mengatasi rasa kehilangan, mengelola kecemasan yang timbul akibat pengalaman abortus yang berulang, serta meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk menghadapi kehamilan yang lebih sehat di masa mendatang.

B. Etiologi dan Faktor Risiko Abortus Berulang

Abortus berulang merupakan kondisi yang memiliki beragam penyebab kompleks serta multifaktorial. Untuk dapat memberikan asuhan kebidanan yang tepat dan efektif, tenaga kesehatan harus memahami secara mendalam etiologi dan berbagai faktor risiko yang berkontribusi terhadap kondisi ini. Secara umum, penyebab abortus berulang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori besar, yaitu kelainan genetik, gangguan imunologis, kelainan anatomi uterus, gangguan hormonal dan endokrin, serta faktor gaya hidup dan lingkungan. Penjelasan secara rinci dari masing-masing kategori ini menjadi sangat penting dalam menentukan strategi diagnosis, manajemen, dan pencegahan untuk ibu dengan riwayat abortus berulang.

Salah satu penyebab utama abortus berulang adalah kelainan genetik atau kromosom. Diperkirakan sekitar 50-60% kasus abortus spontan dini berhubungan

dengan abnormalitas kromosom janin, seperti trisomi, monosomi, maupun trans lokasi kromosom yang diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua. Abnormalitas kromosom tersebut sering kali menyebabkan gangguan perkembangan embrio yang tidak kompatibel dengan kelangsungan hidup janin, sehingga menyebabkan keguguran dini. Pasangan dengan riwayat abortus berulang sering kali dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan genetik, seperti kariotipe, guna mengetahui adanya kelainan kromosom struktural yang mendasari. Dengan pemeriksaan ini, pasangan dapat memperoleh gambaran jelas tentang risiko yang mungkin terjadi pada kehamilan selanjutnya serta dapat mempertimbangkan berbagai alternatif seperti konseling genetik atau teknologi reproduksi berbantu untuk meningkatkan peluang kehamilan yang berhasil.

Selain kelainan genetik, gangguan imunologis juga menjadi penyebab penting yang sering dikaitkan dengan abortus berulang. Salah satu gangguan imunologis yang paling dikenal adalah sindrom antifosfolipid (APS), suatu kondisi di mana tubuh menghasilkan antibodi terhadap fosfolipid, yang merupakan komponen penting dari membran sel tubuh, termasuk plasenta. Antibodi ini dapat menyebabkan pembentukan bekuan darah abnormal di plasenta, yang pada akhirnya mengganggu sirkulasi darah antara ibu dan janin, menyebabkan kematian janin dan keguguran berulang. Selain APS, gangguan imunologis lain seperti ketidakseimbangan aktivitas sel imun (termasuk sel NK atau natural killer) dalam endometrium juga telah diteliti sebagai faktor risiko abortus berulang. Penanganan gangguan imunologis ini biasanya melibatkan terapi medis khusus, seperti pemberian aspirin dosis rendah atau heparin, untuk meningkatkan keberhasilan kehamilan.

Kelainan anatomi uterus adalah faktor lain yang secara signifikan berkontribusi terhadap abortus berulang. Beberapa kelainan anatomi yang sering ditemukan meliputi uterus septum (rahim yang terbagi dua oleh septum), uterus bikornis (rahim bercabang dua), uterus unicornis (rahim yang hanya terbentuk sebagian), atau adanya mioma submukosa yang menonjol ke dalam rongga rahim. Kondisi ini mengganggu proses implantasi embrio, pertumbuhan janin, serta sirkulasi darah plasenta, sehingga meningkatkan risiko keguguran berulang, terutama pada trimester pertama dan kedua. Kelainan anatomi ini biasanya dapat didiagnosis melalui ultrasonografi, histeroskopi, atau pemeriksaan radiologi khusus seperti MRI. Koreksi bedah atau prosedur histeroskopi untuk menghilangkan septum atau mioma yang ada sering kali menjadi pilihan terapi untuk memperbaiki bentuk uterus dan meningkatkan peluang kehamilan yang sehat.

Gangguan hormonal atau endokrin juga merupakan salah satu penyebab penting dalam kasus abortus berulang. Beberapa gangguan hormonal yang sering

dikaitkan dengan abortus berulang antara lain gangguan tiroid (hipotiroidisme atau hipertiroidisme), diabetes mellitus yang tidak terkontrol, hiperprolaktinemia, serta defisiensi hormon progesteron. Gangguan hormonal ini dapat menyebabkan perubahan lingkungan endometrium yang tidak kondusif untuk implantasi dan perkembangan janin, sehingga menyebabkan keguguran berulang. Pemeriksaan hormonal yang komprehensif selama perencanaan kehamilan dan trimester awal kehamilan sangat penting untuk mendeteksi adanya gangguan endokrin, sehingga terapi yang tepat seperti suplementasi hormon atau koreksi metabolik dapat segera diberikan.

Selain faktor medis tersebut, faktor gaya hidup dan lingkungan juga memiliki peranan signifikan dalam meningkatkan risiko abortus berulang. Beberapa gaya hidup yang terbukti secara ilmiah meningkatkan risiko abortus berulang antara lain kebiasaan merokok, konsumsi alkohol berlebihan, penggunaan obat-obatan terlarang, stres kronis, serta paparan lingkungan terhadap bahan toksik seperti pestisida, logam berat, atau radiasi ionisasi. Gaya hidup yang tidak sehat ini dapat menyebabkan gangguan dalam proses implantasi embrio, meningkatkan kerusakan DNA janin, serta menyebabkan gangguan sirkulasi plasenta. Oleh sebab itu, intervensi untuk memperbaiki pola hidup melalui konseling, edukasi kesehatan, serta pendekatan multidisiplin dengan melibatkan ahli gizi, psikolog, serta tenaga kesehatan lainnya sangat penting untuk mencegah terulangnya keguguran.

C. Identifikasi dan Diagnosis Dini pada Ibu dengan Abortus Berulang

Identifikasi dan diagnosis dini pada ibu dengan riwayat abortus berulang merupakan tahap yang sangat penting dan krusial dalam penanganan kondisi ini. Semakin cepat dan akurat diagnosis ditegakkan, maka semakin besar pula peluang untuk menerapkan intervensi yang tepat, efektif, dan tepat waktu guna mencegah terjadinya keguguran pada kehamilan berikutnya. Proses identifikasi dan diagnosis ini mencakup tiga aspek utama, yaitu anamnesis (wawancara riwayat medis secara mendalam), pemeriksaan fisik yang komprehensif, serta pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, ultrasonografi, dan analisis genetik.

Tahap pertama dalam proses identifikasi adalah melalui anamnesis yang terstruktur dan mendalam. Anamnesis bertujuan untuk menggali informasi mengenai riwayat kesehatan ibu secara keseluruhan, riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya, riwayat penyakit keluarga, serta faktor gaya hidup dan lingkungan yang mungkin berperan dalam kejadian abortus berulang. Dalam proses ini, tenaga kesehatan akan menanyakan secara rinci mengenai jumlah keguguran yang pernah dialami, usia kehamilan saat keguguran terjadi, serta tanda-tanda klinis yang menyertai seperti perdarahan, nyeri, atau gejala infeksi yang dialami. Informasi

ini penting karena pola waktu terjadinya keguguran (trimester awal, tengah, atau akhir) sering kali dapat memberikan petunjuk awal mengenai kemungkinan etiologi yang mendasarinya. Sebagai contoh, keguguran berulang pada trimester pertama lebih cenderung berkaitan dengan kelainan kromosom janin atau gangguan hormonal, sementara keguguran trimester kedua lebih sering terkait dengan kelainan anatomi rahim atau gangguan imunologis.

Selain menggali riwayat keguguran sebelumnya, tenaga kesehatan juga perlu menanyakan secara detail riwayat kesehatan ibu yang berhubungan dengan kondisi medis tertentu seperti diabetes mellitus, gangguan tiroid, hipertensi kronis, penyakit autoimun (seperti lupus atau sindrom antifosfolipid), serta riwayat pengobatan tertentu yang mungkin berkontribusi terhadap abortus berulang. Selain itu, riwayat keluarga yang berhubungan dengan penyakit genetik, gangguan pembekuan darah, atau gangguan imunologis juga perlu dicatat secara cermat, karena hal ini dapat membantu dalam menentukan langkah-langkah diagnostik yang lebih spesifik seperti analisis genetik atau pemeriksaan imunologi.

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan fisik secara komprehensif yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini adanya kelainan atau kondisi patologis yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya abortus berulang. Pemeriksaan fisik ini tidak hanya terbatas pada pemeriksaan umum seperti pengukuran tekanan darah, denyut nadi, berat badan, dan tinggi badan saja, melainkan juga mencakup pemeriksaan ginekologis secara khusus. Pemeriksaan ginekologis ini meliputi pemeriksaan panggul untuk mengetahui kelainan anatomi seperti adanya massa di uterus yang mungkin merupakan mioma atau polip, kelainan serviks, atau indikasi infeksi yang bisa meningkatkan risiko keguguran. Penilaian terhadap adanya nyeri atau sensitivitas saat palpasi abdomen juga penting untuk mendeteksi kondisi inflamasi atau infeksi intra-abdominal yang bisa berkontribusi terhadap abortus berulang.

Setelah anamnesis dan pemeriksaan fisik, tahap selanjutnya yang juga sangat penting adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini meliputi berbagai tes laboratorium, ultrasonografi, serta analisis genetik untuk memastikan diagnosis secara akurat serta mengidentifikasi faktor risiko secara lebih spesifik. Pemeriksaan laboratorium biasanya mencakup pemeriksaan darah rutin, kadar gula darah, hormon tiroid (TSH, T3, T4), kadar prolaktin, serta kadar progesteron. Evaluasi kadar hormon ini penting untuk mengetahui kemungkinan gangguan hormonal atau endokrin yang dapat menyebabkan keguguran berulang. Selain itu, pemeriksaan laboratorium lain seperti pemeriksaan profil autoimun, seperti antibodi antifosfolipid (anticardiolipin, lupus anticoagulant, dan anti-beta-2 glycoprotein I) juga diperlukan untuk mendeteksi gangguan imunologis seperti sindrom antifosfolipid yang sering kali ditemukan pada kasus abortus berulang.

Pemeriksaan ultrasonografi (USG), khususnya USG transvaginal, memiliki peran vital dalam identifikasi dini kelainan anatomi rahim yang dapat menyebabkan keguguran berulang. Dengan ultrasonografi, tenaga kesehatan dapat melihat dengan jelas kondisi uterus, endometrium, ovarium, serta rongga panggul. Kelainan seperti septum uterus, mioma submukosa, polip endometrium, atau insufisiensi serviks dapat dideteksi secara dini melalui pemeriksaan ini. Pemeriksaan ultrasonografi juga dapat membantu menilai ketebalan endometrium serta kualitas ovarium, yang merupakan faktor penting dalam menentukan kesuburan dan kelangsungan kehamisan pada wanita yang memiliki riwayat keguguran berulang.

Selain pemeriksaan laboratorium dan ultrasonografi, analisis genetik juga menjadi bagian integral dalam proses identifikasi dan diagnosis pada kasus abortus berulang. Analisis genetik ini biasanya melibatkan pemeriksaan kariotipe pasangan suami istri untuk mendeteksi adanya kelainan kromosom struktural yang mungkin diwariskan kepada embrio atau janin. Pemeriksaan ini penting terutama bagi pasangan yang mengalami keguguran berulang tanpa sebab yang jelas. Dengan mengetahui status genetik pasangan secara lebih detail, tenaga kesehatan dapat memberikan konseling genetik yang tepat serta opsi penanganan selanjutnya seperti preimplantation genetic testing (PGT) atau teknologi reproduksi berbantu lainnya untuk meningkatkan peluang kehamilan yang sehat.

D. Manajemen Klinis pada Ibu dengan Riwayat Abortus Berulang

Manajemen klinis pada ibu dengan riwayat abortus berulang adalah suatu pendekatan yang kompleks dan membutuhkan perencanaan serta pelaksanaan yang teliti, mengingat kondisi ini melibatkan berbagai faktor penyebab yang saling terkait. Prinsip dasar manajemen klinis ini adalah menerapkan berbagai strategi intervensi medis secara individual, berdasarkan penyebab atau faktor risiko yang teridentifikasi melalui pemeriksaan komprehensif sebelumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan rahim yang optimal dan memastikan kondisi kesehatan ibu mendukung kelangsungan kehamilan hingga lahirnya bayi yang sehat.

Salah satu strategi yang sering diterapkan dalam manajemen klinis abortus berulang adalah terapi hormonal. Terapi hormonal diberikan pada kasus-kasus di mana keguguran berulang disebabkan oleh gangguan hormonal atau ketidakseimbangan endokrin, seperti insufisiensi fase luteal atau rendahnya kadar progesteron. Progesteron merupakan hormon esensial yang bertugas menjaga stabilitas endometrium dan mendukung implantasi serta perkembangan awal embrio. Terapi progesteron biasanya diberikan dalam bentuk oral, vaginal, atau injeksi, tergantung kondisi klinis pasien. Pada beberapa kasus, penggunaan

progesteron dimulai segera setelah terjadinya ovulasi atau setelah konfirmasi kehamilan, dan dilanjutkan hingga usia kehamilan tertentu, umumnya hingga trimester pertama berakhir, untuk memastikan embrio memiliki lingkungan rahim yang mendukung perkembangannya.

Selain progesteron, terapi hormon lainnya seperti pengaturan hormon tiroid juga menjadi bagian penting dalam manajemen klinis abortus berulang. Gangguan tiroid, baik hipotiroidisme maupun hipertiroidisme, telah dikaitkan secara signifikan dengan risiko keguguran berulang. Oleh karena itu, pengobatan gangguan tiroid melalui pemberian levotiroksin untuk kasus hipotiroidisme atau obat antitiroid untuk hipertiroidisme, disertai dengan pemantauan ketat terhadap kadar hormon tiroid, menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan hormonal yang diperlukan selama kehamilan berlangsung.

Strategi lain dalam manajemen klinis abortus berulang adalah pendekatan imunoterapi, yang ditujukan untuk kasus-kasus yang memiliki dasar imunologis, seperti sindrom antifosfolipid atau gangguan imunologis lain yang menyebabkan respon imun tubuh ibu terhadap kehamilan berlebihan atau abnormal. Salah satu contoh kondisi yang umum adalah sindrom antifosfolipid, yang menyebabkan kecenderungan pembekuan darah yang berlebihan pada pembuluh darah kecil di plasenta, sehingga mengganggu suplai nutrisi dan oksigen ke janin. Untuk kasus ini, terapi yang umum diterapkan adalah kombinasi aspirin dosis rendah (baby aspirin) dan pemberian heparin, biasanya low molecular weight heparin (LMWH), yang diberikan secara injeksi subkutan. Penggunaan aspirin dosis rendah bertujuan untuk mencegah agregasi trombosit berlebihan, sedangkan heparin bekerja dengan mencegah pembentukan trombus pada pembuluh darah plasenta. Kedua obat ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan tingkat kelangsungan kehamilan pada ibu dengan gangguan imunologis tertentu.

Selain terapi farmakologis tersebut, manajemen klinis juga mencakup tata laksana kelainan anatomi uterus, seperti septum uterus, polip endometrium, mioma submukosa, dan insufisiensi serviks. Kelainan anatomi ini dapat mengganggu implantasi embrio dan pertumbuhan janin secara normal. Tata laksana pada kelainan anatomi uterus umumnya dilakukan melalui prosedur pembedahan minimal invasif seperti histeroskopi. Histeroskopi digunakan untuk mengoreksi kelainan seperti septum uterus atau polip dengan memotong atau mengangkat jaringan abnormal melalui alat khusus yang dimasukkan lewat serviks. Sementara untuk mioma submukosa, prosedur serupa dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat atau mengurangi ukuran mioma yang dapat menghambat perkembangan embrio atau menyebabkan keguguran spontan. Setelah prosedur pembedahan selesai, biasanya ibu akan menjalani pemulihan selama beberapa

bulan sebelum kehamilan berikutnya direkomendasikan, untuk memastikan kondisi rahim benar-benar pulih dan optimal untuk kehamilan berikutnya.

Pada kasus insufisiensi serviks, yang ditandai dengan pembukaan serviks secara prematur di trimester kedua, tindakan pembedahan seperti serklase serviks dapat dilakukan. Serklase adalah prosedur di mana serviks dijahit dengan benang khusus untuk mempertahankan kehamilan hingga mencapai usia kehamilan cukup bulan. Tindakan ini dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan risiko infeksi dan ruptur ketuban. Selain itu, ibu juga biasanya diminta untuk mengurangi aktivitas fisik atau menjalani istirahat total dalam periode tertentu, tergantung pada rekomendasi medis, guna mengurangi tekanan intrauterin yang berpotensi mempercepat pembukaan serviks.

Di samping berbagai pendekatan medis dan bedah yang disebutkan, pendekatan farmakologis lain juga sering diterapkan dalam manajemen klinis abortus berulang. Penggunaan antibiotik, misalnya, dapat dipertimbangkan dalam kasus keguguran yang disebabkan oleh infeksi kronis atau berulang pada saluran reproduksi. Antibiotik yang dipilih harus berdasarkan hasil pemeriksaan kultur dan sensitivitas terhadap patogen tertentu. Selain itu, pada kondisi di mana terdapat inflamasi atau peradangan kronis, obat antiinflamasi dalam dosis dan jenis tertentu dapat digunakan untuk mengurangi respon inflamasi yang merugikan implantasi dan perkembangan janin.

Aspek penting lainnya dalam manajemen klinis ini adalah pendekatan secara multidisiplin dan kolaboratif. Hal ini melibatkan dokter spesialis kandungan, dokter spesialis penyakit dalam, spesialis endokrinologi, spesialis imunologi, psikolog, serta tenaga kesehatan lain yang bekerja sama secara erat untuk merancang strategi pengobatan yang tepat, spesifik, dan personal bagi masing-masing pasien. Selain intervensi medis, pendekatan psikososial juga penting untuk membantu ibu mengelola stres, kecemasan, dan dampak psikologis lainnya yang sering kali muncul akibat riwayat keguguran berulang. Konseling psikologis, terapi relaksasi, serta dukungan sosial dari keluarga maupun kelompok pendukung khusus sangat membantu dalam menciptakan lingkungan emosional yang positif yang secara tidak langsung mendukung keberhasilan kehamilan berikutnya.

E. Peran Bidan dalam Pendampingan dan Edukasi Ibu

Bidan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mendampingi serta memberikan edukasi kepada ibu dengan riwayat abortus berulang. Pendampingan oleh bidan tidak hanya terbatas pada aspek klinis saja, namun juga meliputi berbagai pendekatan holistik, melibatkan aspek emosional, psikologis, sosial, serta gaya hidup ibu. Mengingat dampak emosional yang signifikan pada ibu

yang mengalami keguguran berulang, peran bidan dalam memberikan dukungan psikologis melalui konseling empati menjadi aspek yang tak kalah penting dibandingkan intervensi medis itu sendiri.

Pendampingan emosional yang dilakukan oleh bidan diawali sejak tahap awal konsultasi, bahkan sebelum kehamilan berikutnya terjadi. Dalam tahap ini, bidan bertugas untuk membangun hubungan terapeutik yang kuat dengan ibu, menciptakan suasana nyaman yang memungkinkan ibu untuk terbuka dalam menyampaikan perasaan, kekhawatiran, ketakutan, maupun harapan yang ia rasakan terkait riwayat keguguran sebelumnya. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, bidan membantu ibu mengatasi trauma psikologis, mengurangi tingkat kecemasan, dan membangun kembali rasa percaya dirinya dalam menghadapi kehamilan selanjutnya. Proses pendampingan ini sangat penting karena kondisi psikologis yang baik secara tidak langsung akan mendukung kondisi fisik ibu, sehingga memperbesar peluang suksesnya kehamilan berikutnya.

Dalam aspek konseling, bidan juga bertanggung jawab memberikan informasi yang jelas, faktual, dan akurat mengenai kondisi kesehatan ibu serta penyebab potensial dari keguguran yang dialaminya. Informasi yang diberikan meliputi penjelasan tentang berbagai faktor risiko, hasil pemeriksaan diagnostik, strategi pengobatan yang sedang dijalani, serta kemungkinan prognosis kehamilan berikutnya. Pengetahuan yang memadai ini membantu ibu untuk lebih memahami kondisi kesehatannya, sehingga ia dapat mengambil keputusan secara aktif bersama tim medis terkait pilihan perawatan maupun tindakan preventif yang perlu dijalankan. Bidan secara proaktif juga harus mengklarifikasi berbagai mitos atau informasi keliru yang sering berkembang di masyarakat tentang penyebab keguguran, dengan memberikan fakta medis yang jelas guna mengurangi beban psikologis tambahan bagi ibu.

Selain aspek emosional dan psikologis, bidan juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi tentang pola hidup sehat yang menjadi bagian integral dari intervensi non-farmakologis dalam mencegah terjadinya abortus berulang. Edukasi tentang pola hidup sehat yang dimaksud mencakup berbagai elemen penting seperti pola makan yang seimbang, aktivitas fisik yang teratur namun sesuai dengan kondisi medis ibu, serta istirahat yang cukup. Bidan perlu memberikan panduan spesifik tentang jenis makanan yang dianjurkan untuk dikonsumsi, seperti makanan kaya asam folat, zat besi, vitamin B kompleks, serta protein tinggi, yang semuanya sangat penting untuk menunjang kesehatan reproduksi dan kehamilan. Selain itu, bidan juga memberikan informasi tentang jenis makanan atau minuman yang sebaiknya dihindari, seperti alkohol, kafein berlebih, serta makanan cepat saji yang dapat memperburuk kondisi inflamasi atau hormonal ibu.

Dalam konteks aktivitas fisik, peran bidan adalah mengedukasi ibu tentang pentingnya olahraga ringan seperti jalan santai, yoga prenatal, atau latihan relaksasi yang terbukti mampu membantu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan sirkulasi darah, yang pada akhirnya dapat memperbaiki lingkungan rahim serta mendukung pertumbuhan embrio. Namun demikian, bidan juga harus menyesuaikan rekomendasi ini dengan kondisi medis masing-masing ibu secara spesifik, agar aktivitas fisik yang dilakukan tidak menambah risiko terjadinya komplikasi.

Pendekatan non-farmakologis lain yang tidak kalah penting adalah edukasi mengenai manajemen stres dan teknik relaksasi. Dalam hal ini, bidan bertanggung jawab untuk mengajarkan ibu teknik relaksasi sederhana seperti pernapasan dalam, meditasi ringan, visualisasi positif, dan latihan mindfulness. Teknik-teknik tersebut efektif dalam mengurangi kecemasan dan meningkatkan ketahanan psikologis ibu selama proses kehamilan berlangsung. Selain itu, bidan juga dapat mendorong ibu untuk terlibat dalam kelompok dukungan atau komunitas yang berisi ibu-ibu lain dengan riwayat serupa, sehingga mereka bisa saling memberikan dukungan emosional serta berbagi pengalaman, yang pada akhirnya membantu mengurangi rasa terisolasi atau perasaan bersalah yang seringkali muncul.

Lebih lanjut, peran bidan dalam strategi pencegahan abortus berulang melalui intervensi non-farmakologis juga meliputi edukasi tentang pentingnya menjauhi paparan lingkungan yang berbahaya atau zat toksik seperti asap rokok, bahan kimia berbahaya, atau radiasi. Bidan perlu memberikan informasi jelas tentang bagaimana paparan terhadap zat-zat tersebut berpotensi meningkatkan risiko keguguran, dan bagaimana cara efektif untuk menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi ini sangat penting untuk menanamkan kesadaran kepada ibu tentang pentingnya menjaga lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja yang aman dan sehat selama masa kehamilan.

Selain itu, bidan bertugas memberikan edukasi tentang perencanaan kehamilan yang optimal, termasuk waktu ideal untuk konsepsi berikutnya setelah keguguran sebelumnya. Rekomendasi tentang jeda waktu yang tepat sebelum mencoba hamil kembali membantu ibu dalam mempersiapkan fisik dan mentalnya secara lebih matang. Dalam periode ini, bidan berperan penting dalam mendampingi ibu menjalani pemeriksaan rutin dan membantu mengontrol kondisi medis tertentu yang mungkin menjadi penyebab keguguran sebelumnya, seperti gangguan tiroid, diabetes, atau obesitas.

F. Dukungan Psikososial bagi Ibu dan Pasangan

Abortus berulang merupakan sebuah peristiwa yang sangat menantang secara emosional dan psikologis, tidak hanya bagi ibu namun juga pasangan serta keluarganya. Dampak dari pengalaman ini seringkali jauh melampaui aspek fisik saja; banyak ibu yang mengalami beban psikologis mendalam, seperti rasa bersalah, kehilangan rasa percaya diri, kecemasan tinggi, hingga depresi berat. Oleh karena itu, pendekatan dalam memberikan dukungan psikososial harus dilakukan secara holistik dan komprehensif agar mampu menjawab kebutuhan psikologis, emosional, serta sosial ibu dan pasangannya secara bersamaan.

Konseling emosional menjadi komponen yang sangat penting dalam memberikan dukungan psikososial bagi ibu dan pasangan yang mengalami abortus berulang. Melalui konseling ini, ibu diberikan ruang aman dan nyaman untuk mengungkapkan perasaannya tanpa rasa takut akan dihakimi. Konselor atau tenaga kesehatan yang melakukan konseling berperan sebagai pendengar aktif yang mampu memahami dan menunjukkan empati yang tulus terhadap situasi yang dialami oleh ibu. Dalam sesi konseling, ibu diajak untuk merefleksikan emosi negatif yang mungkin dirasakannya seperti kesedihan mendalam, perasaan gagal sebagai seorang ibu, rasa bersalah karena merasa tidak mampu mempertahankan kehamilannya, serta berbagai bentuk tekanan psikologis lainnya. Proses ini sangat penting untuk membantu ibu mengenali dan menerima emosi tersebut, sebagai langkah awal dalam proses pemulihan emosional.

Selain ibu, pasangan juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses konseling. Banyak pasangan yang cenderung merasa bingung dalam menghadapi situasi abortus berulang yang dialami oleh istrinya. Mereka bisa saja merasa frustrasi karena tidak tahu cara memberikan dukungan yang tepat, atau bahkan mengalami perasaan bersalah yang serupa dengan yang dirasakan oleh ibu. Dalam konseling pasangan, tenaga kesehatan atau konselor dapat memberikan edukasi serta strategi komunikasi efektif, sehingga pasangan mampu memberikan dukungan emosional yang tepat dan efektif kepada ibu. Melalui komunikasi terbuka yang difasilitasi oleh konseling pasangan ini, mereka mampu memperkuat hubungan emosional yang pada akhirnya dapat membantu keduanya melewati masa sulit tersebut dengan lebih kuat dan solid.

Selain pendekatan konseling secara individu dan pasangan, dukungan psikologis lebih lanjut mungkin diperlukan, khususnya jika ibu menunjukkan tanda-tanda gangguan psikologis yang lebih serius, seperti depresi atau kecemasan berat yang berkepanjangan. Dalam situasi ini, intervensi dari psikolog klinis atau psikiater menjadi penting. Intervensi ini dapat berupa terapi perilaku kognitif, terapi interpersonal, atau bahkan farmakoterapi bila diperlukan. Tujuan dari dukungan

psikologis ini adalah untuk mengurangi tingkat kecemasan atau depresi yang dialami ibu, serta membantu ibu mengembangkan strategi koping yang sehat dalam menghadapi peristiwa traumatis tersebut.

Selain konseling emosional dan dukungan psikologis, aspek penting lainnya dalam pendekatan holistik adalah penguatan dukungan sosial, terutama dari pasangan dan keluarga terdekat. Keluarga memiliki peran sentral dalam memberikan rasa aman, nyaman, dan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan oleh ibu. Namun, seringkali keluarga merasa tidak cukup terampil atau canggung dalam memberikan dukungan karena khawatir akan menyinggung perasaan ibu. Oleh karena itu, tenaga kesehatan seperti bidan dan konselor perlu memberikan edukasi khusus kepada keluarga mengenai bagaimana cara terbaik memberikan dukungan yang positif dan suportif tanpa memberikan tekanan tambahan. Edukasi ini meliputi strategi komunikasi yang empati, cara mendengarkan yang baik, serta cara memberikan motivasi dan dukungan emosional yang tepat.

Dalam penguatan dukungan sosial ini, pasangan memegang peranan yang paling krusial. Pasangan dapat memberikan dukungan emosional secara langsung dengan mendampingi ibu selama pemeriksaan medis, menemani selama proses terapi, hingga menjadi pendengar yang baik di rumah. Dukungan dari pasangan juga berupa pemberian afirmasi positif serta penguatan rasa percaya diri ibu bahwa mereka mampu melewati masa sulit tersebut. Sebaliknya, ketika pasangan mampu memberikan dukungan emosional yang kuat dan positif, kondisi psikologis ibu secara signifikan dapat membaik, yang pada gilirannya dapat berkontribusi terhadap peningkatan peluang keberhasilan kehamilan berikutnya.

Lebih jauh lagi, pendekatan psikososial juga mencakup integrasi ibu dan pasangan dalam kelompok dukungan atau komunitas yang berisi pasangan lain yang mengalami pengalaman serupa. Berinteraksi dengan orang lain yang memiliki pengalaman sejenis dapat sangat bermanfaat secara psikologis, karena memberikan kesempatan untuk berbagi cerita, mendapatkan perspektif baru, serta mengetahui bahwa mereka tidak sendirian menghadapi tantangan ini. Kelompok dukungan tersebut memberikan rasa solidaritas dan pemahaman emosional yang mendalam, sehingga mampu membantu mengurangi isolasi sosial dan rasa kesepian yang mungkin dirasakan oleh ibu dan pasangannya.

G. Monitoring dan Evaluasi Kehamilan Pasca Abortus Berulang

Pemantauan intensif selama kehamilan berikutnya pada ibu yang memiliki riwayat abortus berulang merupakan langkah strategis yang sangat krusial dalam upaya mencegah terulangnya kegagalan kehamilan. Pemantauan ini melibatkan pendekatan terpadu dan sistematis, menggabungkan metode diagnostik berbasis

teknologi modern dengan observasi klinis secara teratur yang dilakukan oleh tim kesehatan multidisiplin. Melalui pendekatan yang terstruktur ini, peluang keberhasilan mempertahankan kehamilan secara signifikan dapat ditingkatkan, serta kecemasan ibu dan keluarga juga dapat ditekan seminimal mungkin.

Salah satu metode yang paling penting dalam monitoring intensif pada kehamilan setelah abortus berulang adalah penggunaan pemeriksaan ultrasonografi (USG) secara berkala dan konsisten. Ultrasonografi memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan evaluasi visual yang detail terhadap kondisi janin, kantung kehamilan, plasenta, serta struktur anatomi rahim. Pada trimester pertama, USG dapat memastikan apakah kantung kehamilan berkembang secara normal, mendeteksi ada tidaknya detak jantung janin, serta memastikan usia kehamilan yang akurat. Evaluasi ini sangat penting karena sebagian besar kejadian abortus berulang terjadi pada trimester pertama. Dengan pemeriksaan USG rutin, potensi ancaman seperti kehamilan kosong (*blighted ovum*), pertumbuhan janin terhambat, atau kelainan anatomis lainnya dapat segera diketahui. Selanjutnya, pada trimester kedua dan ketiga, ultrasonografi juga digunakan untuk memantau perkembangan janin secara keseluruhan, menilai kecukupan cairan ketuban, serta memastikan fungsi plasenta dalam memberikan nutrisi optimal kepada janin. Pemeriksaan yang dilakukan secara rutin ini memungkinkan tindakan intervensi cepat dan tepat bila ditemukan tanda-tanda komplikasi dini.

Selain pemeriksaan ultrasonografi, pemantauan hormon secara rutin juga memiliki peran yang signifikan dalam mempertahankan kehamilan pasca abortus berulang. Pemantauan hormon yang paling umum dilakukan adalah terhadap kadar hormon progesteron dan hormon beta-hCG (*human Chorionic Gonadotropin*). Progesteron merupakan hormon penting dalam mempertahankan kehamilan, karena berperan dalam menciptakan lingkungan rahim yang optimal bagi janin. Kadar progesteron yang rendah seringkali berkaitan dengan risiko keguguran. Oleh sebab itu, dalam monitoring kehamilan ibu dengan riwayat abortus berulang, pemeriksaan kadar progesteron dilakukan secara rutin dan terjadwal, terutama pada trimester pertama, agar defisiensi hormon tersebut dapat segera terdeteksi dan ditangani dengan terapi pengganti hormon. Demikian pula, pemantauan kadar beta-hCG, hormon yang dihasilkan oleh plasenta pada awal kehamilan, dapat memberikan indikasi penting mengenai kondisi kehamilan yang sehat. Kadar beta-hCG yang tidak mengalami peningkatan secara normal atau bahkan menurun secara tiba-tiba merupakan tanda awal ancaman abortus, sehingga pemantauan rutin terhadap hormon ini sangat krusial untuk memungkinkan intervensi segera sebelum kondisi menjadi semakin parah.

Observasi klinis secara berkala yang dilakukan oleh tenaga kesehatan juga merupakan bagian penting dalam evaluasi kehamilan setelah abortus berulang. Observasi ini mencakup berbagai pemeriksaan fisik rutin seperti pengukuran tekanan darah, evaluasi pertambahan berat badan, pengukuran tinggi fundus uteri, dan pemantauan tanda-tanda vital lainnya secara berkala. Observasi klinis ini memungkinkan deteksi dini terhadap berbagai komplikasi yang mungkin terjadi selama kehamilan, misalnya hipertensi gestasional, preeklamsia, infeksi, ataupun gangguan lain yang berpotensi memicu terjadinya abortus. Dengan pemantauan rutin, setiap perubahan abnormal yang terdeteksi dapat segera ditangani secara preventif.

Evaluasi psikologis juga menjadi bagian integral dalam monitoring dan evaluasi kehamilan setelah abortus berulang. Banyak ibu yang mengalami kecemasan tinggi terhadap kemungkinan keguguran kembali, sehingga evaluasi psikologis secara berkala dapat membantu mengelola stres dan kecemasan tersebut. Pemantauan psikologis melibatkan wawancara dan konseling rutin yang bertujuan untuk mengetahui kondisi emosional ibu serta memberikan intervensi psikososial bila diperlukan. Pendampingan yang terus-menerus dari tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, atau konselor khusus akan membantu ibu untuk tetap tenang, optimis, dan percaya diri selama menjalani kehamilannya.

Selain metode pemantauan intensif yang disebutkan di atas, strategi evaluasi lain yang juga penting adalah dokumentasi dan analisis secara sistematis terhadap semua data medis yang dikumpulkan selama kehamilan. Dengan mencatat perkembangan kehamilan secara detail, mulai dari hasil ultrasonografi, pemantauan hormon, pemeriksaan laboratorium, hingga laporan observasi klinis, tenaga kesehatan dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas intervensi yang telah dilakukan. Melalui analisis data ini, tim medis dapat menyesuaikan strategi manajemen kehamilan secara tepat, misalnya dengan mengubah dosis terapi hormonal, memperketat frekuensi pemantauan, atau bahkan mengambil keputusan klinis lain seperti perawatan rawat inap singkat jika risiko keguguran dinilai tinggi.

Dalam pelaksanaannya, pendekatan kolaboratif dari tim multidisiplin, yang terdiri dari dokter kandungan, bidan, perawat, ahli laboratorium, psikolog, hingga tenaga kesehatan lainnya, sangat penting. Setiap anggota tim harus memiliki komunikasi yang baik dan efektif satu sama lain, sehingga setiap perubahan kecil pada kondisi ibu maupun janin dapat segera diketahui dan direspons secara cepat serta terkoordinasi dengan baik. Kolaborasi tim ini memastikan ibu mendapatkan layanan terbaik dalam mempertahankan kehamilannya, serta memperbesar peluang kelahiran bayi yang sehat.

H. Strategi Pencegahan Abortus Berulang Jangka Panjang

Abortus berulang merupakan kondisi yang menimbulkan dampak fisik maupun psikologis yang mendalam bagi ibu dan keluarganya. Untuk mencegah terjadinya abortus berulang di masa mendatang, pendekatan preventif yang komprehensif dan berkesinambungan menjadi sangat penting. Pencegahan ini tidak hanya terbatas pada intervensi medis saat terjadi kehamilan, namun mencakup strategi jangka panjang yang melibatkan modifikasi gaya hidup, pengendalian faktor risiko kronis, serta pengelolaan kesehatan reproduksi secara menyeluruh.

Strategi awal yang perlu dilakukan adalah edukasi gaya hidup sehat yang berkelanjutan kepada pasangan, khususnya ibu yang pernah mengalami abortus berulang. Edukasi ini mencakup pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya akan vitamin, mineral, serat, dan protein. Nutrisi yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas sel telur dan sperma serta menciptakan lingkungan intrauterin yang optimal untuk kehamilan berikutnya. Penjelasan detail mengenai dampak negatif dari konsumsi makanan cepat saji, minuman berkafein tinggi, alkohol, dan rokok juga harus ditekankan dalam sesi edukasi tersebut. Konsumsi alkohol dan rokok diketahui meningkatkan risiko keguguran karena menyebabkan kerusakan pada plasenta, gangguan hormonal, serta mengurangi aliran darah ke janin. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, termasuk bidan, perlu memastikan pasangan memahami risiko ini secara mendalam dan termotivasi untuk melakukan perubahan gaya hidup secara permanen.

Selain edukasi mengenai nutrisi, aktivitas fisik yang rutin dan teratur juga merupakan bagian integral dari gaya hidup sehat yang perlu diterapkan. Olahraga ringan seperti jalan kaki, berenang, yoga, atau latihan aerobik moderat secara teratur terbukti mampu meningkatkan kesehatan reproduksi dengan memperlancar sirkulasi darah, meningkatkan keseimbangan hormonal, serta membantu mengendalikan berat badan. Penjelasan kepada ibu harus mencakup informasi mengenai manfaat olahraga bagi keseimbangan hormon estrogen dan progesteron yang sangat penting untuk mempertahankan kehamilan. Lebih jauh lagi, olahraga teratur juga dapat menurunkan risiko penyakit metabolik seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan hipertensi, yang semuanya merupakan faktor risiko abortus berulang.

Pengendalian faktor risiko kronis menjadi bagian penting lainnya dalam pencegahan abortus berulang jangka panjang. Diabetes mellitus, terutama diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, memiliki korelasi erat dengan risiko keguguran. Oleh sebab itu, ibu dengan riwayat diabetes harus mendapat pengawasan ketat sejak sebelum kehamilan direncanakan. Tenaga kesehatan perlu memberikan

edukasi tentang pentingnya pengontrolan kadar gula darah melalui diet rendah glikemik, olahraga teratur, serta penggunaan obat antidiabetik yang tepat jika diperlukan. Kontrol gula darah yang optimal akan menciptakan lingkungan rahim yang kondusif untuk implantasi embrio dan mendukung perkembangan janin yang sehat.

Demikian pula, hipertensi merupakan faktor risiko lain yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam strategi pencegahan abortus berulang. Tekanan darah tinggi yang tidak terkendali dapat menyebabkan gangguan suplai darah ke plasenta, menyebabkan insufisiensi plasenta dan meningkatkan risiko keguguran maupun kelahiran prematur. Oleh sebab itu, edukasi tentang pentingnya pemantauan tekanan darah secara rutin dan pengelolaan yang efektif melalui modifikasi pola makan rendah garam, teknik manajemen stres, olahraga, serta terapi farmakologis bila diperlukan, perlu disampaikan secara jelas dan kontinu. Pengendalian tekanan darah jangka panjang akan memperbaiki kondisi vaskular ibu, sehingga mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan berikutnya.

Selain faktor metabolik, pengelolaan kesehatan reproduksi secara komprehensif juga harus menjadi bagian penting dalam pencegahan jangka panjang. Hal ini melibatkan evaluasi rutin kondisi anatomi dan fisiologi reproduksi wanita, seperti pemeriksaan ultrasonografi berkala untuk menilai kondisi rahim, endometrium, serta ovarium. Kelainan anatomi seperti septum uterus, mioma, atau polip endometrium yang dapat meningkatkan risiko abortus berulang harus segera diidentifikasi dan ditangani dengan tepat, baik melalui tindakan operatif maupun terapi medikamentosa yang sesuai.

Selanjutnya, infeksi saluran reproduksi juga harus dicegah dan dikelola secara optimal, mengingat infeksi kronis dapat menyebabkan inflamasi endometrium yang berujung pada keguguran spontan. Pemeriksaan rutin untuk infeksi seperti toksoplasmosis, rubella, cytomegalovirus (TORCH), serta infeksi saluran kemih dan bakteri vagina lainnya perlu dilakukan sebelum kehamilan berikutnya direncanakan. Jika infeksi terdeteksi, terapi antibiotik atau antivirus yang tepat harus segera diberikan untuk mengeliminasi agen penyebab infeksi dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

Pengelolaan psikologis jangka panjang juga merupakan strategi preventif penting yang tidak boleh diabaikan. Wanita yang pernah mengalami abortus berulang cenderung memiliki tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang tinggi, yang secara tidak langsung dapat memperburuk kondisi kesehatan fisik dan mengganggu keseimbangan hormonal. Pendampingan psikologis secara kontinu melalui sesi konseling rutin dapat membantu ibu mengatasi tekanan emosional ini, sekaligus membantu mereka membangun sikap positif terhadap kehamilan

berikutnya. Konseling tersebut juga melibatkan pasangan atau keluarga untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pemulihan emosional ibu.

Terakhir, strategi pencegahan abortus berulang jangka panjang harus dilakukan dengan pendekatan tim multidisiplin yang melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai latar belakang seperti dokter spesialis kandungan, bidan, ahli gizi, psikolog, serta tenaga kesehatan lain yang relevan. Kerja sama antarprofesi ini sangat penting agar berbagai aspek pencegahan, baik fisik maupun psikologis, dapat dilakukan secara terintegrasi, konsisten, dan holistik. Dengan pendekatan yang sistematis ini, ibu dan keluarganya dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat secara keseluruhan, sekaligus meningkatkan peluang keberhasilan kehamilan yang sehat dan aman di masa depan.

I. Simpulan

Abortus berulang merupakan kondisi kompleks yang ditandai dengan kehilangan kehamilan secara berturut-turut, dan memiliki dampak signifikan terhadap aspek fisik, psikologis, dan sosial ibu serta keluarganya. Kondisi ini sering kali mengindikasikan adanya berbagai kelainan medis yang belum terdiagnosis sebelumnya, seperti kelainan genetik, imunologis, anatomi uterus, gangguan hormonal, hingga faktor gaya hidup yang tidak sehat.

Identifikasi dan diagnosis dini menjadi langkah awal yang penting dalam manajemen kasus abortus berulang. Proses ini meliputi anamnesis mendalam, pemeriksaan fisik menyeluruh, serta berbagai pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, ultrasonografi, dan analisis genetik. Dengan mengetahui penyebab yang mendasari, tenaga kesehatan dapat menyusun strategi intervensi yang lebih tepat dan efektif.

Manajemen klinis pada kasus ini mencakup berbagai pendekatan medis, seperti terapi hormonal untuk mengatasi ketidakseimbangan endokrin, imunoterapi untuk gangguan imunologis, tata laksana bedah untuk kelainan anatomi uterus, serta berbagai intervensi farmakologis lainnya. Strategi ini bertujuan menciptakan lingkungan rahim yang optimal, yang sangat penting untuk mempertahankan kehamilan berikutnya.

Peran bidan dalam pendampingan dan edukasi kepada ibu sangatlah penting, tidak hanya dalam hal klinis tetapi juga dalam memberikan dukungan emosional yang intensif. Edukasi mengenai gaya hidup sehat, pola nutrisi yang baik, aktivitas fisik teratur, serta manajemen stres merupakan bagian integral dari pendekatan preventif non-farmakologis yang dilakukan bidan.

Dukungan psikososial bagi ibu dan pasangan juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Konseling emosional, penguatan dukungan sosial dari

pasangan dan keluarga, serta keterlibatan dalam kelompok pendukung dapat membantu mengurangi stres, kecemasan, dan dampak emosional lain yang dialami ibu. Pendekatan holistik ini mampu meningkatkan kualitas hidup ibu secara keseluruhan, sekaligus mendukung keberhasilan kehamilan di masa depan.

Monitoring intensif selama kehamilan berikutnya merupakan langkah strategis dalam mencegah terjadinya keguguran kembali. Pemantauan melalui ultrasonografi rutin, pemantauan kadar hormon secara berkala, serta observasi klinis secara teratur memungkinkan deteksi dini dan intervensi cepat terhadap komplikasi yang muncul. Evaluasi psikologis secara rutin juga penting dalam mengelola kecemasan ibu selama kehamilan.

Strategi pencegahan jangka panjang mencakup edukasi gaya hidup sehat, pengendalian faktor risiko kronis seperti diabetes dan hipertensi, serta pengelolaan kesehatan reproduksi secara komprehensif. Kerja sama antarprofesi melalui pendekatan tim multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis kandungan, bidan, ahli gizi, psikolog, dan tenaga kesehatan lainnya sangat penting untuk memberikan pelayanan yang terpadu, holistik, dan konsisten.

J. Referensi

- Alijotas-Reig, J., Esteve-Valverde, E., & Ferrer-Oliveras, R. (2017). Immunotherapy in reproductive failures: new insights. *American Journal of Reproductive Immunology*, 77(3), e12654. <https://doi.org/10.1111/aji.12654>
- Bashiri, A., Halper, K. I., & Orvieto, R. (2018). Recurrent Pregnancy Loss: Current Perspectives. *International Journal of Women's Health*, 10, 331–345. <https://doi.org/10.2147/IJWH.S100672>
- Chen, S. L., & Chang, S. M. (2020). Uterine anatomical abnormalities and recurrent pregnancy loss. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, 46(7), 1207–1215. <https://doi.org/10.1111/jog.14293>
- Egerup, P., Mikkelsen, A. P., & Kolte, A. M. (2016). Pregnancy loss: a review of current literature and perspectives. *Fertility and Sterility*, 106(5), 1215–1223. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2016.06.035>
- Ford, H. B., & Schust, D. J. (2009). Recurrent pregnancy loss: etiology, diagnosis, and therapy. *Reviews in Obstetrics and Gynecology*, 2(2), 76–83.
- Garrido-Gimenez, C., & Alijotas-Reig, J. (2015). Recurrent miscarriage: causes, evaluation and management. *Postgraduate Medical Journal*, 91(1073), 151–162. <https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2014-132672>

- Larsen, E. C., Christiansen, O. B., Kolte, A. M., & Macklon, N. (2013). New insights into mechanisms behind miscarriage. *BMC Medicine*, 11(1), 154. <https://doi.org/10.1186/1741-7015-11-154>
- Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. (2020). Evaluation and treatment of recurrent pregnancy loss: a committee opinion. *Fertility and Sterility*, 113(6), 1100–1111. <https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2020.03.008>
- Quenby, S., Gallos, I. D., Dhillon-Smith, R. K., Podsek, M., & Stephenson, M. D. (2021). Recurrent miscarriage: Evaluation and treatment. *The Lancet*, 397(10285), 1679–1686. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)00463-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00463-8)
- Rai, R., & Regan, L. (2006). Recurrent miscarriage. *The Lancet*, 368(9535), 601–611. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)69204-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69204-0)
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2017). The Investigation and Treatment of Couples with Recurrent First-trimester and Second-trimester Miscarriage (Green-top Guideline No. 17). RCOG Press.
- Toth, B., Würfel, W., Bohlmann, M., Zschocke, J., & Rudnik-Schöneborn, S. (2019). Recurrent miscarriage: diagnostic and therapeutic procedures. *Deutsches Ärzteblatt International*, 116(16), 264–270. <https://doi.org/10.3238/arztebl.2019.0264>
- Vissenberg, R., Goddijn, M., & Ismail, A. M. (2020). Clinical practice guidelines on recurrent pregnancy loss. *Human Reproduction Open*, 2020(2), hoaa002. <https://doi.org/10.1093/hropen/hoaa002>
- World Health Organization. (2022). Maternal Health: Recurrent Pregnancy Loss. WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int/publications/i/item/recurrent-pregnancy-loss>
- Zhang, T., Sun, Y., Chen, Z., Li, T., & Li, C. (2022). Endocrine disorders and recurrent pregnancy loss: mechanisms and management. *Frontiers in Endocrinology*, 13, 842879. <https://doi.org/10.3389/fendo.2022.842879>

K. Glosarium

- **Abortus Berulang**

Kondisi terjadinya keguguran sebanyak dua kali atau lebih secara berturut-turut, umumnya pada trimester pertama atau kedua kehamilan, tanpa kelahiran hidup di antaranya.

- **Abortus Habitualis**

Istilah lain dari abortus berulang, merujuk pada keguguran yang terjadi secara berturut-turut lebih dari dua kali.

- **Sindrom Antifosfolipid (APS)**

Kelainan imunologis yang ditandai oleh adanya antibodi terhadap fosfolipid, menyebabkan pembentukan bekuan darah abnormal yang dapat mengganggu suplai darah ke janin.

- **Sindrom Asherman**

Kondisi adhesi intrauterin yang terbentuk akibat trauma atau infeksi, sering kali setelah tindakan medis seperti kuretase, menyebabkan infertilitas atau keguguran berulang.

- **Uterus Septum**

Kelainan anatomi berupa septum (pembatas) di dalam rahim yang membagi rongga uterus menjadi dua bagian, meningkatkan risiko keguguran atau persalinan prematur.

- **Insufisiensi Serviks**

Kondisi melemahnya serviks yang menyebabkan serviks terbuka sebelum waktunya, sering mengakibatkan keguguran pada trimester kedua kehamilan.

- **Terapi Progesteron**

Terapi hormon dengan memberikan progesteron tambahan untuk menjaga stabilitas endometrium serta mendukung implantasi dan perkembangan janin pada kehamilan yang berisiko.

- **Analisis Kariotipe**

Pemeriksaan kromosom untuk mendeteksi adanya kelainan struktural atau numerik pada kromosom yang mungkin menyebabkan keguguran berulang atau gangguan perkembangan janin.

- **Preimplantation Genetic Testing (PGT)**

Teknik pemeriksaan genetik pada embrio sebelum ditanamkan ke dalam rahim untuk mendeteksi kelainan kromosom atau genetik guna mengurangi risiko keguguran berulang.

- **Histeroskopi**

Prosedur bedah minimal invasif menggunakan alat optik (histeroskop) yang dimasukkan ke dalam rahim untuk diagnosis dan pengobatan berbagai kelainan anatomi uterus, seperti septum, mioma, atau polip endometrium.

CHAPTER 5

MANAJEMEN KEBIDANAN IBU DENGAN PENYAKIT PENYERTA KRONIS

Bdn. Desi Handayani Lubis, SST., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Manajemen kebidanan pada ibu hamil dengan penyakit penyerta kronis merupakan salah satu tantangan penting dalam praktik kebidanan masa kini. Penyakit kronis sendiri didefinisikan sebagai kondisi medis yang berlangsung dalam jangka waktu lama, biasanya lebih dari enam bulan, bersifat progresif, serta memerlukan pengelolaan medis secara kontinu untuk menjaga kualitas hidup yang optimal. Kondisi ini mencakup berbagai jenis penyakit seperti diabetes melitus, hipertensi kronis, penyakit jantung, penyakit ginjal kronis, epilepsi, dan penyakit autoimun, yang mana dapat memberikan dampak serius pada kesehatan ibu hamil maupun janinnya.

Ibu dengan penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas dibandingkan dengan ibu yang sehat tanpa penyakit penyerta. Misalnya, ibu dengan diabetes melitus memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami preeklamsia, komplikasi metabolik, makrosomia janin, hingga gangguan pertumbuhan janin intrauterin. Sedangkan ibu dengan hipertensi kronis berisiko lebih besar mengalami komplikasi serius seperti preeklamsia berat, solusio plasenta, persalinan prematur, serta komplikasi terkait gangguan perfusi plasenta yang memengaruhi tumbuh kembang janin.

Dalam konteks tersebut, manajemen kebidanan yang tepat sangat penting dilakukan guna mengoptimalkan kondisi kesehatan ibu, menjaga keselamatan janin, serta memastikan proses persalinan dan pascapersalinan berjalan aman dan lancar. Pelaksanaan manajemen kebidanan ibu dengan penyakit kronis membutuhkan pendekatan khusus yang bersifat multidisiplin, interprofesional, dan kolaboratif, melibatkan berbagai profesi kesehatan seperti dokter spesialis kandungan, dokter spesialis penyakit dalam, dokter ahli jantung, dokter neurologi, ahli gizi, psikolog, serta tenaga kesehatan lainnya yang relevan.

Bidan sebagai tenaga kesehatan yang berperan penting dalam asuhan kehamilan, persalinan, dan nifas, harus mampu mengidentifikasi secara dini tanda-tanda bahaya yang berkaitan dengan kondisi kronis tersebut. Bidan perlu memahami prinsip dasar pemantauan yang ketat serta melakukan pengelolaan

secara tepat, terutama terkait intervensi kegawatdaruratan dan rujukan tepat waktu ketika kondisi ibu memburuk atau membutuhkan perhatian medis yang lebih intensif. Lebih dari itu, edukasi kepada ibu dan keluarga tentang risiko dan tanda bahaya yang mungkin terjadi, pengaturan pola hidup sehat, pengobatan yang rutin, dan pentingnya kontrol secara teratur menjadi bagian integral dari peran seorang bidan dalam manajemen kebidanan ini.

Melalui pendekatan manajemen yang tepat dan komprehensif, ibu hamil dengan penyakit kronis dapat tetap menjalani kehamilannya dengan optimal. Keselamatan dan kesehatan ibu serta janin selama masa kehamilan hingga pascapersalinan pun dapat ditingkatkan secara signifikan. Oleh karena itu, memahami secara mendalam manajemen kebidanan pada ibu dengan penyakit penyerta kronis menjadi hal esensial yang harus dimiliki setiap tenaga kesehatan khususnya bidan dalam praktik kebidanan modern.

B. Konsep Dasar Penyakit Kronis pada Kehamilan

Penyakit kronis merupakan suatu kondisi medis yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, biasanya lebih dari enam bulan, yang dapat bersifat progresif serta memerlukan perawatan medis yang berkelanjutan. Dalam konteks kehamilan, penyakit kronis didefinisikan sebagai kondisi medis yang sudah diderita oleh seorang perempuan sebelum kehamilannya dimulai, atau kondisi medis yang terjadi selama kehamilan tetapi berlangsung lama, tidak segera pulih, dan membutuhkan pengelolaan khusus yang berkelanjutan hingga masa persalinan dan bahkan sesudahnya. Kondisi ini dapat secara signifikan meningkatkan risiko komplikasi medis selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas, yang membutuhkan pendekatan khusus serta intervensi medis yang lebih intensif dibandingkan dengan kehamilan normal tanpa penyakit kronis.

Terdapat berbagai jenis penyakit kronis yang sering dijumpai pada ibu hamil. Beberapa kondisi yang paling umum ditemukan antara lain adalah diabetes melitus, hipertensi kronis, penyakit jantung kronis, penyakit ginjal kronis, epilepsi, penyakit tiroid (baik hipotiroidisme maupun hipertiroidisme), penyakit autoimun seperti lupus eritematosus sistemik (SLE), asma kronis, dan penyakit infeksi kronis seperti HIV/AIDS atau hepatitis B dan C. Diabetes melitus pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan metabolik, baik pada ibu maupun janin, seperti risiko bayi lahir dengan berat badan lebih besar (makrosomia), hipoglikemia neonatal, hingga kelainan kongenital. Sementara hipertensi kronis dapat meningkatkan risiko preeklamsia, solusio plasenta, retardasi pertumbuhan intrauterin, hingga persalinan prematur. Penyakit jantung kronis pada ibu hamil meningkatkan risiko gagal jantung selama kehamilan atau setelah melahirkan, sedangkan penyakit ginjal kronis dapat

menyebabkan gangguan perkembangan janin akibat terganggunya perfusi plasenta serta kondisi medis yang memburuk pada ibu selama kehamilan.

Keberadaan penyakit kronis pada ibu hamil memberikan dampak serius terhadap kesehatan ibu dan janin. Pada ibu, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa peningkatan risiko komplikasi kehamilan, tetapi juga dapat memperberat perjalanan penyakit kronis itu sendiri. Misalnya, ibu hamil yang sebelumnya mengidap hipertensi kronis mungkin akan mengalami peningkatan tekanan darah selama masa kehamilannya, yang berisiko menyebabkan komplikasi berbahaya seperti preeklamsia atau eklamsia yang dapat mengancam nyawa. Begitu pula pada ibu dengan diabetes melitus, kondisi kehamilan dapat memperburuk kendali gula darah, menyebabkan kondisi hiperglikemia yang berlebihan, yang kemudian memerlukan pengaturan diet dan terapi insulin yang lebih ketat.

Dampak pada janin pun tidak kalah seriusnya. Penyakit kronis pada ibu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin yang signifikan. Misalnya, hipertensi kronis dapat menyebabkan gangguan perfusi plasenta sehingga janin mengalami hambatan pertumbuhan intrauterin, yang berakibat pada bayi lahir dengan berat badan rendah dan berbagai komplikasi neonatal. Diabetes melitus yang tidak terkontrol dengan baik meningkatkan risiko bayi mengalami kelainan kongenital, gangguan respirasi neonatus, serta gangguan metabolik setelah lahir. Selain itu, ibu dengan penyakit autoimun memiliki risiko melahirkan bayi dengan kondisi autoimun neonatal tertentu atau komplikasi lainnya yang membutuhkan perhatian khusus.

Mengelola penyakit kronis selama kehamilannya tidak sekadar menjaga kesehatan ibu, tetapi juga memastikan janin dapat berkembang secara optimal. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti kebidanan, penyakit dalam, kardiologi, neurologi, ahli gizi, serta psikologi sangat dibutuhkan untuk memastikan kehamilan yang aman dan sehat. Dengan memahami secara mendalam konsep dasar penyakit kronis dalam konteks kehamilan, tenaga kesehatan, khususnya bidan, dapat lebih siap dalam menghadapi berbagai situasi klinis yang kompleks, memberikan edukasi yang tepat kepada pasien dan keluarga, serta melakukan intervensi yang dibutuhkan secara dini dan tepat waktu, sehingga tujuan utama dalam kebidanan, yakni ibu dan bayi sehat, dapat tercapai secara optimal.

C. Pengkajian Kebidanan pada Ibu dengan Penyakit Kronis

Pengkajian kebidanan merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen ibu hamil dengan penyakit kronis. Pengkajian yang teliti dan komprehensif akan membantu bidan serta tenaga kesehatan lainnya dalam

menentukan rencana asuhan yang paling tepat, efektif, dan aman bagi ibu maupun janin yang dikandungnya. Dalam konteks ibu hamil dengan penyakit kronis, proses pengkajian kebidanan memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kehamilan biasa, karena harus mempertimbangkan kondisi kesehatan ibu yang sudah memiliki kondisi medis khusus, kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi selama kehamilan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan oleh penyakit tersebut terhadap perkembangan janin.

Langkah pertama dalam pengkajian ini adalah pengumpulan data melalui anamnesis yang bersifat komprehensif. Anamnesis dilakukan dengan pendekatan yang empati dan mendalam, yang mencakup seluruh informasi tentang riwayat kesehatan ibu sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, hingga kondisi kesehatan terkini yang dirasakan. Informasi tersebut mencakup riwayat penyakit kronis yang dialami ibu, seperti sejak kapan penyakit tersebut diderita, pengobatan atau terapi yang selama ini dijalani, tingkat kepatuhan terhadap pengobatan, serta kondisi terkini dari penyakit tersebut (stabil atau memburuk). Selain itu, informasi mengenai riwayat obstetri sebelumnya juga dikumpulkan secara rinci, termasuk riwayat keguguran, kelahiran prematur, komplikasi persalinan, dan komplikasi kehamilan sebelumnya. Data tambahan yang penting seperti riwayat alergi, kebiasaan hidup sehari-hari (pola makan, aktivitas fisik, penggunaan alkohol atau rokok), serta faktor psikososial seperti dukungan keluarga, kecemasan, atau kondisi stres yang dialami ibu juga perlu digali secara cermat karena semua ini dapat memengaruhi perjalanan kehamilan serta penyakit kronis yang sedang diderita.

Setelah data anamnesis diperoleh dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan fisik yang spesifik dan penunjang diagnostik yang sesuai dengan kondisi penyakit kronis yang dialami ibu. Pemeriksaan fisik tidak hanya mencakup pemeriksaan umum seperti tanda vital (tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, respirasi), tetapi juga pemeriksaan khusus yang berhubungan langsung dengan penyakit kronis ibu. Misalnya, pada ibu dengan hipertensi kronis, pemeriksaan tekanan darah secara teratur, evaluasi edema atau pembengkakan pada tungkai bawah, serta pemeriksaan refleks dan proteinuria sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Begitu pula pada ibu dengan diabetes melitus, pemeriksaan kadar gula darah secara rutin, pemeriksaan kaki diabetik, evaluasi status nutrisi, serta pengukuran antropometri menjadi bagian wajib dalam pemeriksaan. Pemeriksaan penunjang tambahan juga perlu dilakukan secara spesifik sesuai dengan kondisi penyakit kronis tersebut, seperti pemeriksaan ultrasonografi (USG) untuk memantau pertumbuhan janin secara berkala, pemeriksaan elektrokardiogram (EKG) pada ibu dengan penyakit jantung kronis, pemeriksaan fungsi ginjal lengkap pada ibu dengan

gangguan ginjal, atau pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan profil tiroid pada ibu yang mengalami gangguan hormon tiroid.

Berdasarkan hasil anamnesis serta pemeriksaan fisik dan penunjang, bidan kemudian melakukan penilaian risiko secara menyeluruh terhadap kehamilan yang sedang berlangsung. Penilaian status risiko ini merupakan bagian kritis dalam proses pengkajian kebidanan, yang bertujuan untuk menentukan tingkat risiko komplikasi yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Ibu dengan penyakit kronis pada umumnya dikategorikan sebagai kehamilan risiko tinggi, sehingga membutuhkan pemantauan yang lebih ketat serta penanganan yang lebih khusus dibandingkan dengan kehamilan tanpa penyakit penyerta. Penilaian risiko ini akan menjadi dasar dalam menetapkan rencana pengelolaan klinis selanjutnya, seperti intensitas pemeriksaan antenatal, perlunya intervensi khusus selama masa kehamilan, penentuan waktu serta metode persalinan yang paling aman, serta perlunya rujukan ke fasilitas kesehatan dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi.

D. Manajemen Antenatal pada Ibu Hamil dengan Penyakit Kronis

Manajemen antenatal pada ibu hamil dengan penyakit kronis merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan secara sistematis dan komprehensif selama masa kehamilan, untuk menjamin kesehatan dan keselamatan ibu serta janinnya hingga persalinan. Penyakit kronis yang dialami ibu hamil dapat memperberat risiko komplikasi, sehingga membutuhkan pendekatan yang terstruktur, multidisiplin, dan berkelanjutan.

Secara prinsip, manajemen antenatal pada ibu hamil dengan penyakit kronis harus dilaksanakan secara kolaboratif. Kolaborasi di sini berarti keterlibatan aktif dari berbagai tenaga kesehatan profesional dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan terapi, serta pelaksanaan pemantauan kondisi ibu dan janin secara intensif selama masa kehamilan. Kolaborasi ini bertujuan agar intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan klinis ibu dan janin, serta mampu mengantisipasi komplikasi yang mungkin muncul selama kehamilan hingga proses persalinan selesai.

1. Adapun prinsip umum manajemen antenatal kolaboratif meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

- a. Koordinasi rutin antar tenaga kesehatan, seperti bidan, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis jantung, dokter spesialis neurologi, ahli gizi, dan psikolog.
- b. Komunikasi terbuka antar anggota tim mengenai perkembangan kondisi kesehatan ibu dan janin.

- c. Rencana perawatan yang disusun secara individual, spesifik terhadap penyakit yang diderita, dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu sesuai kondisi klinis ibu.
- d. Evaluasi periodik terhadap efektivitas terapi, respons klinis ibu terhadap pengobatan, serta tumbuh kembang janin secara teratur.

2. Rencana Perawatan Khusus Berdasarkan Jenis Penyakit Kronis

Setiap penyakit kronis membutuhkan rencana perawatan khusus yang berbeda satu sama lain, disesuaikan dengan karakteristik dan komplikasi yang mungkin timbul akibat penyakit tersebut.

a. Diabetes Melitus

- 1) Pemantauan ketat kadar gula darah ibu melalui tes gula darah harian.
- 2) Terapi insulin bila diperlukan untuk mengontrol gula darah.
- 3) Edukasi diet seimbang khusus untuk penderita diabetes dengan bantuan ahli gizi.
- 4) Monitoring rutin perkembangan janin untuk menghindari komplikasi seperti makrosomia, hipoglikemia neonatal, dan kelainan kongenital.

b. Hipertensi Kronis

- 1) Pengukuran tekanan darah rutin setiap kunjungan antenatal.
- 2) Penggunaan obat antihipertensi yang aman untuk kehamilan, sesuai rekomendasi dokter.
- 3) Evaluasi tanda-tanda preeklamsia secara rutin melalui pemeriksaan urin (proteinuria) serta gejala klinis seperti nyeri kepala, pandangan kabur, dan edema ekstremitas.
- 4) Edukasi mengenai tanda bahaya yang memerlukan tindakan segera.

c. Penyakit Jantung Kronis

- 1) Pemantauan rutin status kardiovaskular melalui pemeriksaan EKG atau ekokardiografi.
- 2) Pembatasan aktivitas fisik berat sesuai toleransi jantung.
- 3) Penyesuaian jenis persalinan berdasarkan status kesehatan jantung ibu.
- 4) Kerja sama dengan ahli kardiologi untuk mengatur terapi obat yang aman selama kehamilan.

d. Penyakit Ginjal Kronis

- 1) Pemeriksaan rutin fungsi ginjal dan pemeriksaan urin untuk evaluasi proteinuria.
- 2) Pengaturan ketat asupan protein dan cairan untuk menjaga fungsi ginjal.
- 3) Monitoring tekanan darah serta keseimbangan elektrolit secara berkala.
- 4) Pengawasan khusus terhadap perkembangan janin akibat risiko gangguan perfusi plasenta.

e. Epilepsi

- 1) Pemantauan terhadap jenis dan dosis obat antiepilepsi yang aman bagi janin.
- 2) Pemeriksaan neurologis secara berkala untuk menilai pengendalian kejang.
- 3) Edukasi pada ibu dan keluarga mengenai penanganan serangan epilepsi selama kehamilan.
- 4) Koordinasi erat dengan dokter spesialis neurologi terkait rencana persalinan yang aman.

3. Monitoring Tumbuh Kembang Janin Secara Rutin

Salah satu komponen penting dalam manajemen antenatal ibu dengan penyakit kronis adalah monitoring rutin terhadap tumbuh kembang janin. Tujuan monitoring ini adalah untuk mendeteksi sedini mungkin gangguan pertumbuhan intrauterin, risiko kelainan kongenital, maupun tanda-tanda gawat janin yang bisa timbul akibat penyakit kronis yang dialami ibu.

Monitoring rutin tersebut dilakukan melalui pemeriksaan ultrasonografi (USG) secara berkala, baik USG standar maupun USG Doppler untuk menilai aliran darah di plasenta dan tali pusat. Selain itu, dapat pula dilakukan pemeriksaan tambahan seperti kardiotokografi (CTG), khususnya pada usia kehamilan lanjut, untuk memastikan kesejahteraan janin tetap terjaga hingga menjelang persalinan.

4. Pendampingan Psikososial dan Edukasi Keluarga

Selain penanganan medis dan monitoring klinis, pendekatan psikososial sangat penting dalam mendukung ibu hamil dengan penyakit kronis. Ibu dengan kondisi kronis sering kali mengalami tekanan psikologis berupa kecemasan, stres, dan depresi yang dapat memperberat kondisi kesehatannya.

Pendampingan psikososial diberikan dalam bentuk konseling individual maupun kelompok, dengan melibatkan psikolog atau konselor profesional. Tujuannya adalah membantu ibu mengelola kecemasan dan stres, meningkatkan rasa percaya diri, serta mendorong kepatuhan terhadap pengobatan yang dijalani.

Edukasi keluarga juga sangat vital dalam mendukung proses pengobatan ibu. Keluarga perlu diberi informasi mendalam mengenai penyakit kronis yang dialami ibu, dampaknya terhadap kehamilan dan janin, serta peran keluarga dalam mendukung ibu selama proses kehamilan hingga masa nifas. Dengan edukasi yang memadai, keluarga dapat menyediakan dukungan emosional, fisik, dan sosial yang dibutuhkan ibu untuk menjalani masa kehamilan dengan lebih aman dan nyaman.

5. Secara ringkas, komponen penting dari pendampingan psikososial dan edukasi keluarga adalah:

- a. Konseling psikologis untuk mengelola stres dan kecemasan.
- b. Edukasi mengenai penyakit dan potensi komplikasinya.
- c. Pelibatan keluarga dalam proses pengobatan dan pengambilan keputusan.
- d. Dukungan emosional dan sosial berkelanjutan hingga masa persalinan selesai.

E. Manajemen Intranatal untuk Ibu dengan Penyakit Kronis

Manajemen intranatal merupakan rangkaian asuhan kebidanan yang diberikan pada ibu hamil dengan penyakit kronis selama proses persalinan berlangsung. Pada fase ini, ibu dengan penyakit kronis menghadapi risiko komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan ibu yang sehat, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari tim kesehatan. Tujuan utama manajemen intranatal pada ibu dengan penyakit kronis adalah memastikan proses persalinan berjalan aman, mencegah timbulnya komplikasi yang serius, dan menjaga kondisi kesehatan ibu dan bayi hingga proses persalinan selesai.

1. Persiapan Persalinan dan Tempat Bersalin yang Sesuai Risiko

Persiapan persalinan bagi ibu dengan penyakit kronis harus dilakukan secara cermat dan terencana sejak masa kehamilan. Hal ini mencakup kesiapan fisik, mental, serta fasilitas kesehatan tempat ibu akan melahirkan. Pemilihan tempat bersalin yang tepat sangat penting, mengingat tingginya potensi komplikasi medis yang mungkin timbul selama persalinan. Fasilitas kesehatan yang dipilih harus mampu memberikan pelayanan yang komprehensif, memiliki peralatan medis yang lengkap, tim tenaga medis yang kompeten, serta layanan penunjang medis seperti unit perawatan intensif atau ICU yang dapat digunakan sewaktu-waktu jika kondisi darurat terjadi.

Secara lebih rinci, persiapan tersebut meliputi:

- a. Konsultasi pra-persalinan dengan tim multidisiplin (dokter spesialis kandungan, penyakit dalam, anestesi, dan tenaga kesehatan terkait lainnya).
- b. Pemilihan fasilitas kesehatan dengan level pelayanan sesuai kondisi medis ibu, idealnya rumah sakit dengan fasilitas ICU atau NICU.
- c. Kesiapan sarana dan prasarana medis yang mendukung penanganan emergensi, seperti bank darah, peralatan resusitasi, dan monitoring kardiovaskular.
- d. Persiapan mental ibu dan keluarga melalui edukasi mendalam mengenai proses persalinan, kemungkinan komplikasi yang timbul, dan rencana tindakan medis yang akan diambil.
- e.

2. Pemilihan Metode Persalinan Aman Berbasis Kondisi Klinis

Pemilihan metode persalinan pada ibu dengan penyakit kronis harus didasarkan pada kondisi klinis ibu secara menyeluruh. Tidak semua ibu dengan penyakit kronis bisa menjalani persalinan normal, karena beberapa kondisi dapat meningkatkan risiko serius jika menjalani persalinan pervaginam. Oleh karena itu, pemilihan metode persalinan perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk status kesehatan ibu, kondisi janin, dan jenis penyakit kronis yang dialami.

Beberapa pertimbangan dalam pemilihan metode persalinan meliputi:

- a. **Persalinan pervaginam** dapat dilakukan apabila kondisi klinis ibu stabil, risiko komplikasi rendah, dan tidak ada kontraindikasi medis.
- b. **Persalinan dengan tindakan (forceps atau vakum)** dapat dipertimbangkan jika terdapat indikasi tertentu seperti kelemahan atau kondisi medis yang mengharuskan persalinan segera diakhiri.
- c. **Operasi caesar** merupakan pilihan utama pada beberapa kondisi, seperti penyakit jantung berat, hipertensi kronis dengan preeklamsia berat, gagal ginjal kronis, atau penyakit lain yang mengharuskan persalinan diselesaikan dengan cepat untuk menyelamatkan nyawa ibu maupun janin.

Tim kesehatan harus melakukan evaluasi mendalam terhadap manfaat dan risiko masing-masing metode persalinan sebelum membuat keputusan akhir, dengan melibatkan ibu dan keluarga secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

3. Monitoring Intensif Selama Persalinan

Pemantauan intensif selama proses persalinan sangat penting dilakukan untuk mendeteksi secara dini tanda-tanda komplikasi medis yang mungkin terjadi akibat penyakit kronis ibu. Monitoring intensif ini dilakukan secara kontinu selama persalinan berlangsung.

Aspek penting dalam monitoring intensif ini mencakup:

- a. Pemantauan tanda vital ibu (tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, suhu tubuh) secara ketat dan berkala.
- b. Pemantauan kondisi janin menggunakan alat seperti kardiotokografi (CTG) untuk memantau detak jantung janin serta kontraksi rahim secara kontinu.
- c. Pengamatan terhadap tanda-tanda klinis kegawatdaruratan, misalnya peningkatan tekanan darah yang signifikan, sesak napas, atau perdarahan abnormal.
- d. Pemeriksaan penunjang tambahan yang relevan berdasarkan kondisi penyakit kronis ibu, misalnya pemeriksaan gula darah berkala pada ibu dengan diabetes, pemeriksaan elektrokardiogram (EKG) pada ibu dengan penyakit

jantung, serta pemantauan keseimbangan cairan dan elektrolit pada ibu dengan penyakit ginjal.

Pemantauan yang intensif ini bertujuan agar tim kesehatan bisa melakukan tindakan cepat apabila terjadi komplikasi selama persalinan, demi menjamin keselamatan ibu dan janin.

4. Manajemen Nyeri Persalinan pada Ibu dengan Penyakit Kronis

Manajemen nyeri persalinan merupakan aspek penting dalam perawatan intranatal, khususnya bagi ibu dengan penyakit kronis. Nyeri yang tidak terkontrol dengan baik dapat meningkatkan stres dan kecemasan, memperberat kondisi medis ibu, serta memicu komplikasi lain yang berbahaya.

Strategi manajemen nyeri persalinan pada ibu dengan penyakit kronis antara lain:

- a. **Teknik non-farmakologi:** metode relaksasi, latihan pernapasan, pijatan ringan, dukungan emosional dari keluarga atau bidan, serta terapi komplementer seperti aromaterapi atau hidroterapi yang sesuai kondisi ibu.
- b. **Teknik farmakologi:** pemberian obat-obatan analgesik atau anestesi epidural yang aman, dengan mempertimbangkan kondisi medis spesifik ibu serta risiko efek samping terhadap janin. Pemberian obat ini harus dikoordinasikan secara ketat dengan dokter spesialis anestesi.
- c. Evaluasi berkala efektivitas metode manajemen nyeri yang diberikan, dengan melakukan komunikasi aktif antara tim kesehatan dengan ibu dan keluarganya.

Pemilihan metode manajemen nyeri yang tepat dan efektif sangat menentukan kenyamanan dan keamanan proses persalinan, sekaligus membantu ibu melewati proses ini dengan rasa aman dan percaya diri.

F. Manajemen Pascapartum pada Ibu dengan Penyakit Kronis

Manajemen pascapartum pada ibu dengan penyakit kronis merupakan fase penting dalam pelayanan kebidanan, yang dimulai segera setelah ibu melahirkan hingga berakhirnya masa nifas sekitar enam minggu setelah persalinan. Pada fase ini, ibu yang memiliki penyakit kronis memerlukan perhatian khusus dan pemantauan intensif untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap stabil serta mencegah munculnya komplikasi serius yang berisiko memperburuk keadaan ibu. Pelayanan pascapartum tidak hanya terbatas pada pemulihan kondisi fisik semata, melainkan juga meliputi aspek psikologis, emosional, serta sosial ibu dan keluarga yang harus diperhatikan dengan seksama.

Observasi kondisi kesehatan ibu pascapersalinan merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam manajemen pascapartum. Observasi ini bertujuan untuk memantau secara ketat kondisi umum ibu serta tanda-tanda vital seperti tekanan

darah, suhu tubuh, denyut nadi, respirasi, kondisi kesadaran, serta pendarahan yang dialami ibu. Bagi ibu dengan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, ginjal, maupun epilepsi, observasi akan lebih intensif dilakukan guna mendeteksi sedini mungkin tanda-tanda perburukan kondisi medis atau timbulnya komplikasi. Misalnya, pada ibu dengan hipertensi kronis, pemantauan ketat terhadap tekanan darah menjadi prioritas untuk mencegah terjadinya preeklamsia pascapersalinan atau bahkan eklamsia yang dapat mengancam nyawa. Sementara itu, ibu dengan diabetes perlu dilakukan pemantauan kadar gula darah secara ketat untuk mencegah terjadinya kondisi hipoglikemia atau hiperglikemia setelah persalinan.

Setelah observasi rutin dilakukan, pengelolaan penyakit kronis selama masa nifas menjadi langkah penting berikutnya. Ibu yang telah melahirkan tetap memerlukan terapi yang sesuai untuk menjaga kondisi kesehatan optimal. Pengelolaan ini mencakup penyesuaian dosis obat-obatan yang sebelumnya digunakan selama kehamilan, penyesuaian terapi insulin pada ibu dengan diabetes, kontrol tekanan darah pada ibu dengan hipertensi kronis, evaluasi fungsi ginjal atau jantung secara berkala, serta pemantauan obat anti-kejang pada ibu dengan epilepsi. Dalam pengelolaan ini, tim kesehatan harus secara teratur mengevaluasi efektivitas terapi yang diberikan serta kemungkinan efek sampingnya terhadap ibu dan bayi, khususnya bagi ibu yang sedang menyusui.

Selain aspek pengobatan medis, manajemen pascapartum juga mencakup konseling mengenai nutrisi, menyusui, dan perawatan bayi. Konseling nutrisi sangat penting, karena pola makan yang tepat akan mendukung pemulihan tubuh ibu sekaligus memberikan nutrisi yang cukup bagi bayi melalui ASI. Pada ibu dengan penyakit kronis, pengaturan nutrisi harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus sesuai kondisi medisnya. Sebagai contoh, ibu dengan diabetes perlu mendapat edukasi khusus tentang diet seimbang rendah gula namun tetap bergizi lengkap, sedangkan ibu dengan hipertensi kronis diberikan edukasi untuk menerapkan pola makan rendah garam. Konseling menyusui juga menjadi bagian penting, khususnya dalam pemberian informasi terkait manfaat menyusui, posisi menyusui yang nyaman, serta pengelolaan masalah yang mungkin muncul seperti nyeri atau pembengkakan payudara. Selain itu, perawatan bayi yang benar juga diajarkan kepada ibu dan keluarganya, termasuk pengenalan tanda-tanda bayi sehat serta deteksi dini tanda bahaya pada bayi baru lahir.

Tidak kalah penting adalah upaya deteksi dini dan pencegahan komplikasi pascapartum. Ibu dengan penyakit kronis memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami komplikasi pascapersalinan, baik yang berkaitan langsung dengan penyakit kronisnya maupun komplikasi umum seperti perdarahan postpartum,

infeksi nifas, gangguan psikologis seperti depresi postpartum, hingga komplikasi serius seperti trombosis vena dalam (DVT). Oleh karena itu, tim kesehatan harus proaktif dalam melakukan pengkajian rutin untuk mendeteksi komplikasi secara dini melalui pemeriksaan fisik, evaluasi klinis, dan pemeriksaan laboratorium atau penunjang lain yang relevan. Pencegahan komplikasi ini juga mencakup edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai tanda-tanda bahaya yang harus segera dilaporkan ke tenaga kesehatan, serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan seperti mobilisasi dini, kebersihan diri, pemberian antibiotik profilaksis bila diperlukan, serta pemantauan status psikologis ibu secara berkala.

Dengan pelaksanaan manajemen pascapartum yang komprehensif dan holistik seperti ini, diharapkan kondisi kesehatan ibu dengan penyakit kronis dapat dipulihkan dengan optimal. Selain itu, dukungan penuh dari tim kesehatan dan keluarga sangat dibutuhkan agar ibu dapat melewati masa nifas dengan aman, nyaman, serta terbebas dari komplikasi serius yang mungkin timbul akibat kondisi kronis yang dimilikinya.

G. Kolaborasi dan Koordinasi dalam Tim Kesehatan

Kolaborasi dan koordinasi dalam tim kesehatan merupakan bagian integral dari pelayanan kebidanan bagi ibu hamil dengan penyakit kronis. Mengingat kompleksitas kondisi kesehatan ibu yang mengalami penyakit kronis, serta risiko komplikasi yang tinggi, maka sangat penting adanya keterlibatan aktif berbagai tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu yang relevan. Dalam konteks ini, kolaborasi berarti kerja sama yang erat, saling mendukung, dan berkomunikasi secara terbuka antara berbagai profesi kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan yang komprehensif, aman, serta berkelanjutan bagi ibu dan janinnya. Koordinasi, pada sisi lain, merujuk pada pengaturan, pengorganisasian, dan sinkronisasi berbagai layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien agar berjalan secara harmonis dan terstruktur.

Pentingnya komunikasi antar profesi dalam tim kesehatan tidak dapat diragukan lagi. Komunikasi yang baik dan efektif antar anggota tim sangat menentukan keberhasilan pelayanan yang diberikan. Melalui komunikasi efektif, setiap anggota tim dapat berbagi informasi penting secara tepat waktu, termasuk perkembangan kondisi kesehatan ibu, rencana perawatan, tindakan yang akan dilakukan, serta kendala atau tantangan yang muncul selama proses pelayanan berlangsung. Komunikasi yang efektif juga membantu menghindari terjadinya kesalahpahaman atau miskomunikasi yang dapat menyebabkan keterlambatan tindakan, kesalahan pengobatan, atau bahkan terjadinya komplikasi yang merugikan bagi pasien. Selain itu, komunikasi yang terbuka antar profesi

memungkinkan terbangunnya suasana kerja yang kondusif dan saling menghargai kompetensi masing-masing profesi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.

Dalam tim interprofesional yang menangani ibu hamil dengan penyakit kronis, masing-masing profesi memiliki peran yang sangat spesifik namun saling melengkapi. Dokter spesialis obstetri dan ginekologi bertanggung jawab atas evaluasi klinis kehamilan, pengelolaan komplikasi kebidanan, serta menentukan strategi persalinan yang paling aman bagi ibu dan janin. Dokter spesialis penyakit dalam memainkan peran penting dalam mengelola kondisi medis ibu terkait penyakit kronisnya seperti diabetes melitus atau hipertensi kronis, termasuk penyesuaian terapi obat selama masa kehamilan hingga masa nifas. Dokter spesialis jantung bertanggung jawab atas pemantauan dan pengelolaan kondisi ibu dengan penyakit jantung kronis, memastikan bahwa kondisi kardiovaskular ibu tetap stabil selama kehamilan hingga persalinan. Dokter spesialis neurologi berperan dalam manajemen ibu dengan penyakit kronis neurologis seperti epilepsi, yang mencakup pemilihan obat anti-kejang yang aman serta strategi untuk mencegah kejang selama masa kehamilan dan persalinan. Ahli gizi bertugas menyusun rencana diet dan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan khusus ibu berdasarkan kondisi penyakit kronisnya, untuk menjamin kesehatan ibu serta pertumbuhan optimal janin. Psikolog juga memiliki peran penting dalam mendukung ibu dari aspek mental dan emosional, terutama mengatasi kecemasan, depresi, atau stres yang sering kali menyertai ibu hamil dengan penyakit kronis. Dengan demikian, keterlibatan tim interprofesional ini akan memastikan bahwa seluruh aspek kesehatan ibu dan janin dipantau, dikelola, dan dijaga secara optimal.

Agar kolaborasi antar profesi dapat berjalan efektif, diperlukan strategi koordinasi pelayanan yang baik. Strategi ini mencakup beberapa aspek penting seperti penentuan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota tim, penjadwalan rutin pertemuan antar profesi untuk mendiskusikan kondisi pasien dan evaluasi rencana perawatan, serta pendokumentasian hasil diskusi dan keputusan klinis secara teratur dan terintegrasi dalam rekam medis pasien. Selain itu, penggunaan sistem komunikasi elektronik, seperti sistem rekam medis elektronik, aplikasi komunikasi internal rumah sakit, atau platform telekonsultasi, dapat sangat membantu memperlancar komunikasi dan koordinasi antar tim, terutama ketika tim terdiri dari banyak profesi yang mungkin memiliki jadwal kerja yang berbeda. Strategi koordinasi juga termasuk penyelenggaraan pelatihan interprofesional secara rutin, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masing-masing profesi tentang kompetensi, batas tanggung jawab, serta keterampilan komunikasi tim yang efektif. Pelatihan ini penting untuk membangun hubungan profesional yang saling

percaya, saling menghargai, dan mampu bekerja sama secara harmonis dalam mengatasi berbagai tantangan klinis yang kompleks pada pasien dengan penyakit kronis.

Dengan adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik dalam tim kesehatan, pelayanan kebidanan pada ibu dengan penyakit kronis akan jauh lebih efektif, aman, dan berkualitas. Hal ini tidak hanya berdampak positif terhadap keselamatan ibu dan janin, tetapi juga meningkatkan kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan yang diterima. Pada akhirnya, pendekatan ini menciptakan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, holistik, dan berpihak sepenuhnya pada keselamatan dan kesejahteraan pasien.

H. Tantangan dalam Manajemen Kebidanan Penyakit Kronis

Manajemen kebidanan pada ibu hamil dengan penyakit kronis memang memberikan tantangan tersendiri bagi tenaga kesehatan, baik yang bertugas di tingkat komunitas maupun di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi seperti rumah sakit. Tantangan ini bersifat kompleks karena terkait dengan berbagai aspek pelayanan, mulai dari aspek teknis medis, sumber daya yang terbatas, hingga masalah sosial dan budaya yang ada di masyarakat.

Salah satu tantangan besar yang sering dihadapi dalam manajemen kebidanan pada ibu hamil dengan penyakit kronis adalah hambatan pelayanan di komunitas maupun fasilitas kesehatan. Di tingkat komunitas, terutama di daerah terpencil atau pedesaan, pelayanan kesehatan sering kali masih terbatas. Tenaga kesehatan yang tersedia, seperti bidan atau dokter, mungkin tidak memiliki pengalaman yang memadai atau kurang terlatih secara khusus untuk menangani ibu dengan penyakit kronis yang kompleks. Kondisi ini semakin diperburuk oleh keterbatasan fasilitas pelayanan, kurangnya peralatan medis pendukung, dan ketiadaan alat diagnostik yang memadai untuk mendeteksi atau memantau kondisi penyakit kronis pada ibu hamil. Selain itu, kendala geografis seperti jarak tempuh yang jauh dan sulitnya akses transportasi juga menyebabkan ibu hamil sulit menjangkau fasilitas kesehatan untuk kontrol secara rutin atau mendapatkan penanganan segera dalam kondisi gawat darurat.

Di sisi lain, fasilitas kesehatan yang lebih besar seperti rumah sakit, meskipun memiliki tenaga kesehatan dan fasilitas medis yang lebih lengkap, juga menghadapi tantangan tersendiri. Misalnya, adanya beban kerja yang tinggi atau terbatasnya jumlah tenaga medis spesialis yang terlatih menangani ibu hamil dengan penyakit kronis, membuat pelayanan menjadi kurang optimal. Selain itu, koordinasi antara berbagai tenaga medis yang menangani pasien kadang-kadang tidak berjalan

efektif, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan klinis maupun penanganan pasien secara terpadu.

Tantangan lainnya adalah ketersediaan sumber daya serta akses terhadap layanan rujukan yang masih terbatas, khususnya di daerah yang jauh dari kota besar. Tidak semua fasilitas kesehatan di daerah mampu memberikan layanan rujukan yang memadai, terutama untuk pasien dengan kondisi medis kompleks yang membutuhkan penanganan spesifik. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya sistem rujukan yang terorganisasi dengan baik, sehingga proses rujukan pasien sering kali menjadi lambat atau tidak efisien. Kurangnya fasilitas transportasi medis yang memadai, seperti ambulans yang dilengkapi dengan peralatan gawat darurat, juga turut menyulitkan proses rujukan pasien dari daerah terpencil menuju fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Akibatnya, ibu hamil dengan penyakit kronis yang membutuhkan penanganan cepat sering terlambat mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan, yang bisa meningkatkan risiko komplikasi atau bahkan kematian.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, tenaga kesehatan dan pihak-pihak terkait perlu merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasinya. Strategi yang dapat diterapkan di antaranya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan seperti bidan, dokter umum, maupun perawat yang bertugas di tingkat komunitas maupun rumah sakit, sehingga mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani ibu hamil dengan penyakit kronis. Program pelatihan ini bisa dilakukan secara rutin dalam bentuk seminar, workshop, maupun pelatihan berbasis simulasi kasus klinis nyata.

Selain peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, strategi penguatan fasilitas pelayanan juga sangat dibutuhkan. Pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor kesehatan perlu memastikan ketersediaan alat medis dasar maupun spesifik di fasilitas kesehatan, mulai dari alat pemeriksaan gula darah, tensimeter digital, hingga alat diagnostik canggih seperti mesin ultrasonografi (USG), elektrokardiogram (EKG), atau fasilitas laboratorium yang memadai. Perlu pula dikembangkan sistem rujukan yang lebih terorganisasi, misalnya melalui penguatan sistem informasi kesehatan berbasis digital yang memungkinkan fasilitas kesehatan primer dan rujukan berkomunikasi secara real-time sehingga pasien bisa segera mendapatkan pelayanan yang tepat sesuai kondisinya.

Di tingkat komunitas, edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi strategi yang tidak kalah pentingnya. Masyarakat perlu diedukasi mengenai pentingnya pemeriksaan rutin, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pengenalan tanda bahaya selama kehamilan. Dengan pemberdayaan ini, ibu hamil dengan penyakit kronis dan keluarganya akan lebih sadar pentingnya akses terhadap

pelayanan kesehatan serta lebih aktif dalam mencari bantuan medis ketika kondisi kesehatan memburuk.

Strategi lain yang efektif adalah peningkatan koordinasi antar tenaga kesehatan melalui pendekatan interprofesional. Koordinasi yang baik antar profesi, seperti dokter spesialis, bidan, perawat, ahli gizi, dan psikolog, memungkinkan pelayanan kebidanan yang diberikan menjadi lebih holistik dan komprehensif. Dengan adanya koordinasi ini, setiap tenaga kesehatan akan lebih memahami perannya masing-masing, sehingga pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil dengan penyakit kronis akan menjadi lebih efektif, efisien, dan aman.

Melalui strategi-strategi tersebut, diharapkan berbagai tantangan dalam manajemen kebidanan ibu dengan penyakit kronis dapat diatasi secara optimal. Dengan demikian, ibu hamil dapat menjalani kehamilan, persalinan, hingga masa nifas dengan aman dan nyaman, terhindar dari komplikasi serius, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi.

I. Simpulan

Manajemen kebidanan pada ibu hamil dengan penyakit kronis merupakan tantangan besar dalam pelayanan kebidanan yang membutuhkan perhatian khusus, pengetahuan mendalam, serta pendekatan multidisiplin. Kondisi penyakit kronis seperti diabetes melitus, hipertensi kronis, penyakit jantung, ginjal, dan epilepsi secara signifikan meningkatkan risiko komplikasi yang dapat berdampak negatif pada kesehatan ibu dan janin selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas. Oleh karena itu, tenaga kesehatan khususnya bidan dituntut untuk memiliki keterampilan dan kompetensi khusus dalam melakukan pengkajian secara komprehensif, menyusun rencana perawatan individual, serta menerapkan intervensi klinis yang tepat waktu dan efektif.

Pengelolaan antenatal pada ibu dengan penyakit kronis harus dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai tenaga kesehatan profesional seperti dokter spesialis, ahli gizi, psikolog, serta tenaga kesehatan lain yang relevan. Pemantauan kondisi ibu dan janin secara rutin serta pendampingan psikososial menjadi bagian penting dalam manajemen antenatal yang bertujuan memastikan kehamilan berjalan aman hingga persalinan.

Pada saat persalinan (fase intranatal), manajemen yang intensif meliputi pemilihan tempat bersalin yang sesuai risiko, metode persalinan yang aman berbasis kondisi klinis ibu, pemantauan intensif terhadap kondisi ibu dan janin selama proses persalinan, serta manajemen nyeri yang efektif. Fase ini menuntut koordinasi yang baik di antara tim kesehatan untuk memastikan ibu melewati proses persalinan dengan aman dan nyaman.

Pada masa pascapersalinan, perhatian khusus terhadap observasi kondisi ibu, pengelolaan penyakit kronis yang berkelanjutan, konseling tentang nutrisi, menyusui, serta perawatan bayi, serta deteksi dini komplikasi sangatlah krusial. Pendekatan ini memastikan pemulihan ibu berlangsung optimal, serta risiko komplikasi pascapartum dapat diminimalkan.

Kolaborasi interprofesional yang efektif serta koordinasi pelayanan yang terorganisasi menjadi kunci utama dalam mengatasi tantangan manajemen kebidanan pada ibu dengan penyakit kronis. Tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, akses layanan rujukan, serta hambatan pelayanan di komunitas dan fasilitas kesehatan, harus diatasi melalui peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, penguatan fasilitas pelayanan, edukasi masyarakat, serta penerapan sistem rujukan yang efektif.

Dengan penerapan strategi manajemen kebidanan yang komprehensif, terintegrasi, dan kolaboratif, pelayanan kesehatan pada ibu hamil dengan penyakit kronis dapat diberikan secara optimal, sehingga meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup ibu dan bayi hingga masa nifas selesai.

J. Referensi

- American Diabetes Association. (2022). Management of diabetes in pregnancy: Standards of medical care in diabetes—2022. *Diabetes Care*, 45(Suppl. 1), S232–S243. <https://doi.org/10.2337/dc22-S015>
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Spong, C. Y., & Casey, B. M. (2022). *Williams Obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hutcheon, J. A., Lisonkova, S., & Joseph, K. S. (2021). Epidemiology of pre-eclampsia and the other hypertensive disorders of pregnancy. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 75, 7–18. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2021.05.006>
- Johnson, C. T., & Louis, J. M. (2022). Management of chronic hypertension during pregnancy. *American Family Physician*, 105(2), 141–148.
- Kattah, A. G., & Garovic, V. D. (2022). Pregnancy and chronic kidney disease: Clinical considerations. *Seminars in Nephrology*, 42(2), 151–162. <https://doi.org/10.1016/j.semnephrol.2022.02.005>
- Lawrence, H. C., Copel, J. A., & O’Keeffe, D. F. (2021). Interprofessional collaboration in obstetric care: Enhancing patient safety and quality outcomes. *Obstetrics & Gynecology*, 138(3), 472–477.

<https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000004531>

Miller, E. C., & Leffert, L. R. (2022). Cardiovascular disease in pregnancy: Principles and management. *Anesthesiology Clinics*, 40(1), 71–88. <https://doi.org/10.1016/j.anclin.2021.10.005>

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2019). Intrapartum care for women with existing medical conditions or obstetric complications and their babies (NICE Guideline No. NG121). NICE. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng121>

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2018). Epilepsy in pregnancy (Green-top Guideline No. 68). RCOG Press. <https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/gtg68/>

World Health Organization. (2019). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. World Health Organization. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/250796>

K. Glosarium

Anamnesis:

Proses wawancara yang dilakukan tenaga kesehatan untuk mengumpulkan riwayat kesehatan pasien secara menyeluruh, termasuk keluhan, riwayat penyakit, riwayat obstetri, serta aspek psikososial.

Diabetes Melitus Gestasional:

Gangguan metabolik berupa peningkatan kadar gula darah yang terjadi atau terdiagnosis pertama kali selama kehamilan, meningkatkan risiko komplikasi pada ibu dan janin.

Epilepsi:

Gangguan neurologis kronis yang ditandai dengan kejang berulang akibat aktivitas listrik abnormal di otak, memerlukan pengobatan jangka panjang dan pemantauan khusus selama kehamilannya.

Hipertensi Kronis:

Kondisi medis berupa tekanan darah tinggi yang dialami sejak sebelum kehamilan atau yang terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu, dapat meningkatkan risiko komplikasi serius seperti preeklamsia dan persalinan prematur.

Kolaborasi Interprofesional:

Pendekatan pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai profesi kesehatan dalam tim, bertujuan untuk memberikan pelayanan terpadu, komprehensif, dan optimal bagi pasien.

Komplikasi Metabolik:

Gangguan metabolisme tubuh akibat penyakit kronis yang menyebabkan perubahan kondisi kesehatan secara drastis, seperti hiperglikemia pada diabetes melitus.

Makrosomia Janin:

Kondisi janin tumbuh lebih besar dibanding ukuran normal sesuai usia kehamilan, sering dikaitkan dengan diabetes melitus pada ibu, berisiko menyebabkan komplikasi saat persalinan.

Manajemen Antenatal:

Rangkaian tindakan pemantauan dan pengelolaan selama masa kehamilan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin, termasuk pemeriksaan fisik rutin, evaluasi perkembangan janin, serta edukasi.

Manajemen Intranatal:

Serangkaian asuhan medis dan kebidanan selama persalinan, mencakup persiapan persalinan, pemilihan metode persalinan yang aman, pemantauan intensif, dan manajemen nyeri.

Manajemen Pascapartum:

Proses pemantauan dan pengelolaan kondisi kesehatan ibu setelah persalinan hingga akhir masa nifas, bertujuan memastikan pemulihan optimal dan pencegahan komplikasi serius.

Monitoring Intensif:

Pengawasan yang dilakukan secara ketat dan terus-menerus terhadap kondisi klinis ibu dan janin selama proses persalinan, untuk mendeteksi secara dini munculnya komplikasi medis.

Penyakit Autoimun:

Kelompok penyakit kronis yang terjadi karena sistem imun tubuh menyerang sel-sel sehatnya sendiri, misalnya lupus eritematosus sistemik (SLE), yang dapat berpengaruh negatif pada kehamilan.

Penyakit Ginjal Kronis:

Gangguan fungsi ginjal jangka panjang yang memerlukan pemantauan intensif selama kehamilan untuk mencegah komplikasi seperti gangguan pertumbuhan janin dan memburuknya fungsi ginjal.

Perfusi Plasenta:

Proses aliran darah dari ibu menuju plasenta yang menentukan suplai oksigen dan nutrisi bagi janin. Gangguan perfusi plasenta dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan intrauterin (IUGR).

Preeklamsia:

Komplikasi serius dalam kehamilan yang ditandai tekanan darah tinggi, proteinuria, dan tanda kerusakan organ lainnya, dapat mengancam nyawa ibu dan janin jika tidak ditangani dengan tepat.

Risiko Tinggi:

Kategori kehamilan dengan peningkatan risiko komplikasi akibat kondisi medis yang diderita ibu sebelum atau selama masa kehamilan, membutuhkan pemantauan intensif.

Rujukan:

Proses pengalihan perawatan pasien ke fasilitas kesehatan dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi untuk mendapatkan penanganan lebih spesifik dan intensif.

Solusio Plasenta:

Pelepasan plasenta dari dinding rahim sebelum persalinan, merupakan kondisi darurat yang dapat mengancam nyawa ibu dan janin, sering terkait dengan hipertensi kronis.

Tim Multidisiplin:

Kelompok tenaga kesehatan dari berbagai disiplin ilmu yang bekerja sama secara terpadu dalam pengelolaan pasien, bertujuan mencapai hasil pelayanan terbaik.

USG Doppler:

Teknologi ultrasonografi yang digunakan untuk mengevaluasi aliran darah di plasenta dan tali pusat, membantu mendeteksi gangguan perfusi yang mungkin terjadi pada janin.

CHAPTER 6

TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI EVIDENCE-BASED MIDWIFERY DI INDONESIA

Bd. Atika Pohan, SST., M.KM.

A. Pendahuluan/Prolog

Evidence-Based Midwifery (EBM) atau kebidanan berbasis bukti merupakan pendekatan penting yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan melalui penerapan praktik klinis yang didasarkan pada bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, serta preferensi pasien. Implementasi EBM dalam praktik kebidanan menjadi sangat relevan di Indonesia, mengingat tingginya angka kematian ibu dan bayi yang hingga saat ini masih menjadi isu utama dalam bidang kesehatan maternal. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih tinggi, dan beberapa penyebab utamanya berkaitan erat dengan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan termasuk bidan.

Urgensi implementasi EBM di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek penting. Pertama, penerapan EBM secara konsisten dan sistematis akan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, karena setiap tindakan dan keputusan klinis yang dilakukan oleh bidan didasarkan pada hasil penelitian terbaru yang terbukti efektif, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi ibu dan bayi. Dengan demikian, praktik kebidanan yang dilakukan tidak lagi sekadar mengandalkan pengalaman klinis yang bersifat subjektif, tradisi turun-temurun, atau kebiasaan yang belum tentu efektif atau bahkan bisa berisiko tinggi bagi pasien. Sebaliknya, implementasi EBM memastikan bahwa setiap intervensi klinis didasarkan pada bukti ilmiah yang valid dan reliabel sehingga risiko kesalahan klinis dapat diminimalkan dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi dapat ditingkatkan secara signifikan.

Selain itu, implementasi EBM di Indonesia juga penting untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh para bidan di era informasi digital yang semakin berkembang pesat. Saat ini, pengetahuan medis, termasuk ilmu kebidanan, berkembang sangat cepat, dengan penelitian-penelitian terbaru yang terus bermunculan. Tanpa adanya pendekatan berbasis bukti, para bidan akan kesulitan mengikuti perkembangan informasi terbaru yang relevan dan penting dalam praktik klinisnya. Hal ini bisa berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan,

karena keputusan klinis yang diambil bisa saja didasarkan pada informasi yang sudah usang atau tidak lagi relevan dengan kondisi klinis pasien saat ini. Oleh karena itu, penerapan EBM akan mendorong para bidan untuk terus memperbarui pengetahuan, mengakses informasi ilmiah terbaru secara aktif, dan meningkatkan kemampuan kritis dalam menilai bukti-bukti penelitian yang tersedia.

Implementasi EBM juga sangat krusial dalam konteks tantangan pelayanan kesehatan maternal di Indonesia, yang memiliki karakteristik geografis dan sosial-budaya yang beragam. Di berbagai wilayah, terutama di daerah terpencil atau pedesaan, praktik kebidanan sering kali masih dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional, adat istiadat, atau mitos yang tidak didukung oleh bukti ilmiah. Situasi ini bisa memperbesar risiko terjadinya komplikasi, baik pada ibu maupun bayi, karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar keamanan klinis. Oleh sebab itu, penerapan EBM menjadi solusi strategis untuk mengubah praktik kebidanan di masyarakat agar lebih rasional, aman, dan efektif, tanpa mengabaikan aspek budaya dan sosial yang ada. Dengan demikian, implementasi EBM tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan klinis, tetapi juga berkontribusi dalam proses edukasi masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan berbasis bukti ilmiah.

Di sisi lain, implementasi EBM di Indonesia bukanlah tanpa hambatan. Tantangan-tantangan nyata yang dihadapi mencakup rendahnya pemahaman tenaga kesehatan, termasuk bidan, mengenai konsep dasar EBM dan cara menerapkannya dalam praktik sehari-hari, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber literatur ilmiah terbaru, kurangnya dukungan infrastruktur kesehatan di berbagai wilayah, serta terbatasnya pelatihan dan pengembangan keterampilan berbasis bukti bagi para bidan. Selain itu, faktor regulasi dan kebijakan nasional yang mendukung penuh implementasi EBM juga masih belum optimal. Hal ini mengakibatkan praktik kebidanan berbasis bukti belum sepenuhnya diadopsi secara sistematis dalam sistem pelayanan kesehatan maternal nasional.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan kondisi tersebut, diperlukan strategi implementasi yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan agar EBM dapat benar-benar diterapkan secara luas dan efektif di seluruh Indonesia. Strategi tersebut antara lain meliputi penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berbasis bukti secara rutin, peningkatan akses terhadap sumber informasi ilmiah terbaru bagi para bidan, serta pengembangan kebijakan nasional yang secara eksplisit mendukung penerapan praktik kebidanan berbasis bukti sebagai standar nasional dalam pelayanan kesehatan maternal. Di samping itu, pendekatan kolaboratif dan interprofesional yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan—seperti institusi pendidikan kebidanan, organisasi profesi, lembaga

pemerintah, serta masyarakat—menjadi penting untuk memastikan bahwa implementasi EBM bisa terlaksana secara maksimal, terintegrasi, dan berkelanjutan.

implementasi EBM bukan sekadar pendekatan teknis atau metode klinis semata, tetapi juga merupakan upaya strategis dalam mendorong transformasi pelayanan kebidanan di Indonesia agar lebih efektif, aman, efisien, serta mampu meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi secara signifikan. Melalui penerapan kebidanan berbasis bukti, tenaga kesehatan termasuk bidan akan lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan klinis, mampu mengambil keputusan yang tepat dan akurat dalam situasi kritis, serta memberikan pelayanan yang optimal yang berlandaskan bukti ilmiah terbaik yang tersedia. Dengan demikian, implementasi Evidence-Based Midwifery menjadi langkah penting dalam upaya nasional untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan maternal, serta mencapai kesejahteraan ibu dan anak secara menyeluruh di Indonesia.

B. Konsep Dasar Evidence-Based Midwifery

Evidence-Based Midwifery (EBM) atau kebidanan berbasis bukti merupakan sebuah pendekatan yang secara khusus mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan preferensi pasien dalam praktik pelayanan kebidanan. Dalam pengertian yang lebih rinci, EBM dapat diartikan sebagai proses pengambilan keputusan klinis yang sistematis, rasional, dan objektif, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi dan pelayanan kebidanan yang diberikan kepada ibu dan bayi merupakan tindakan yang paling aman, efektif, dan didukung oleh penelitian ilmiah yang valid dan terkini.

Konsep EBM pertama kali muncul sebagai bagian dari gerakan evidence-based medicine, yang berkembang pada akhir abad ke-20 sebagai reaksi atas praktik klinis yang cenderung bersifat tradisional, subjektif, atau bahkan otoriter. Dalam bidang kebidanan, pendekatan ini diadaptasi untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh bidan benar-benar berdasarkan informasi ilmiah yang valid, serta memperhatikan aspek-aspek penting seperti keselamatan pasien, efektivitas klinis, efisiensi biaya, serta kepuasan pasien terhadap layanan yang diterima.

EBM memiliki beberapa prinsip mendasar yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap tenaga kesehatan, khususnya bidan. Prinsip pertama adalah integrasi bukti ilmiah terbaik. Ini berarti bahwa setiap keputusan klinis yang diambil harus didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terbaru yang relevan dengan kasus atau situasi klinis yang dihadapi. Penelitian ilmiah yang digunakan harus memiliki kualitas yang baik, seperti penelitian eksperimental (misalnya randomized controlled trial),

meta-analisis, atau tinjauan sistematis yang memberikan bukti kuat tentang efektivitas intervensi atau tindakan klinis tertentu.

Prinsip kedua adalah pengalaman klinis yang terampil. Dalam implementasi EBM, pengalaman klinis yang dimiliki oleh seorang bidan tetap merupakan elemen penting yang tidak boleh diabaikan. Pengalaman ini mencakup kemampuan praktis, keahlian teknis, serta kemampuan dalam menilai secara kritis situasi klinis yang sedang dihadapi. Seorang bidan yang terampil tidak hanya mampu mengakses dan menilai bukti ilmiah, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata dengan mempertimbangkan kondisi spesifik pasien, situasi sosial, budaya, ekonomi, maupun fasilitas kesehatan yang tersedia.

Prinsip ketiga adalah penghormatan terhadap preferensi, nilai, dan keputusan pasien. Dalam praktik kebidanan berbasis bukti, seorang bidan wajib memperhatikan dan menghormati preferensi atau keinginan pasien serta keluarganya. Prinsip ini menekankan pentingnya komunikasi terapeutik yang baik antara bidan dan pasien, di mana pasien diberdayakan untuk terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan klinis terkait perawatan kesehatan yang mereka terima. Dalam konteks kebidanan, keputusan-keputusan mengenai pilihan metode persalinan, jenis intervensi yang diambil, atau prosedur perawatan bayi yang dilakukan, harus melibatkan pasien dengan mempertimbangkan kepercayaan, nilai, serta harapan pasien terhadap hasil klinis yang diinginkan.

Penerapan EBM dalam praktik kebidanan memiliki berbagai manfaat signifikan yang dapat dirasakan baik oleh tenaga kesehatan maupun oleh pasien. Salah satu manfaat utama penerapan EBM adalah peningkatan kualitas pelayanan kebidanan. Dengan mengacu pada bukti ilmiah terbaru, tindakan klinis yang dilakukan akan menjadi lebih efektif, efisien, dan aman. Risiko terjadinya kesalahan klinis atau komplikasi yang tidak diinginkan dapat diminimalkan secara signifikan, sehingga pasien mendapatkan layanan kebidanan yang lebih berkualitas dan lebih terjamin keamanannya.

Manfaat lain dari penerapan EBM adalah peningkatan kepercayaan pasien terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Ketika pasien mengetahui bahwa setiap tindakan klinis didasarkan pada penelitian ilmiah terbaik yang tersedia, pasien cenderung merasa lebih tenang, percaya, dan puas terhadap pelayanan kesehatan yang mereka terima. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada hubungan antara tenaga kesehatan, dalam hal ini bidan, dengan pasien dan keluarganya, serta mendorong pasien untuk terlibat lebih aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatannya.

Lebih jauh lagi, implementasi EBM juga membawa manfaat penting bagi pengembangan profesionalisme tenaga kesehatan, khususnya bidan. Dengan

terbiasa menggunakan pendekatan berbasis bukti, bidan didorong untuk terus belajar, memperbarui pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan klinisnya secara berkelanjutan. Hal ini akan membantu bidan untuk terus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terbaru, mengasah kemampuan kritis dalam mengevaluasi informasi ilmiah, serta mampu mengambil keputusan klinis secara cepat dan tepat berdasarkan bukti ilmiah yang tersedia.

Tidak kalah pentingnya, EBM juga memberikan manfaat ekonomis bagi sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Dengan menerapkan praktik klinis berbasis bukti, intervensi yang tidak efektif atau berbiaya tinggi tetapi manfaatnya rendah dapat dihindari. Sebaliknya, intervensi klinis yang efektif, hemat biaya, dan memberikan hasil maksimal bagi pasien akan lebih sering digunakan. Dalam jangka panjang, ini akan membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pelayanan kesehatan, meningkatkan efisiensi biaya pelayanan kebidanan, serta mendukung tercapainya tujuan nasional dalam meningkatkan kesehatan maternal dan neonatal secara menyeluruh.

konsep dasar Evidence-Based Midwifery menjadi landasan penting dalam transformasi pelayanan kebidanan menuju arah yang lebih ilmiah, rasional, efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi pasien. Melalui penerapan prinsip-prinsip EBM secara konsisten dan sistematis, pelayanan kebidanan akan mampu memberikan manfaat maksimal bagi pasien, meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi, serta memperkuat profesionalisme tenaga kesehatan dalam menghadapi berbagai tantangan klinis yang kompleks di masa kini dan masa depan.

C. Tantangan Implementasi Evidence-Based Midwifery di Indonesia

Implementasi Evidence-Based Midwifery (EBM) di Indonesia merupakan langkah strategis dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan maternal dan neonatal secara nasional. Namun demikian, upaya implementasi EBM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kompleks yang bersumber dari berbagai aspek penting, mulai dari keterbatasan pengetahuan tenaga kesehatan, fasilitas dan infrastruktur, kondisi sosial budaya, hingga kebijakan dan regulasi nasional. Berikut ini adalah penjelasan secara rinci dan mendalam mengenai berbagai tantangan tersebut:

1. Tantangan dari Aspek Pengetahuan dan Keterampilan Tenaga Kesehatan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi EBM di Indonesia adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan, khususnya para bidan. Banyak bidan di berbagai daerah belum mendapatkan pelatihan formal atau khusus yang secara mendalam membahas prinsip-prinsip EBM, metode pencarian bukti ilmiah, serta bagaimana mengintegrasikan hasil penelitian

terbaru ke dalam praktik klinis sehari-hari. Akibatnya, banyak bidan masih bergantung pada pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan dasar, pengalaman pribadi, atau praktik turun-temurun yang tidak selalu berdasarkan bukti ilmiah terkini.

Selain itu, akses terhadap hasil penelitian terbaru, jurnal ilmiah berkualitas, serta literatur yang relevan dengan praktik kebidanan juga masih sangat terbatas, terutama bagi tenaga kesehatan di wilayah pelosok atau pedesaan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kemampuan bidan untuk melakukan analisis kritis terhadap informasi ilmiah yang mereka terima. Akibatnya, keputusan klinis yang diambil sering kali lebih didasarkan pada rutinitas atau kebiasaan, bukan pada hasil penelitian terbaru yang terbukti secara ilmiah. Hal ini jelas berdampak pada kualitas pelayanan kebidanan secara keseluruhan, yang masih jauh dari harapan.

2. Tantangan dari Aspek Fasilitas dan Infrastruktur Kesehatan

Selain masalah keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan, implementasi EBM di Indonesia juga terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung di fasilitas kesehatan. Banyak fasilitas kesehatan primer, seperti puskesmas atau klinik kebidanan, yang belum memiliki akses memadai terhadap teknologi informasi, internet, atau sarana yang diperlukan untuk mengakses jurnal ilmiah terbaru. Bahkan, di beberapa daerah terpencil, akses terhadap listrik dan jaringan internet yang stabil juga masih menjadi kendala besar.

Di samping itu, sistem informasi kesehatan di banyak fasilitas kesehatan masih belum sepenuhnya mampu mendukung praktik EBM secara optimal. Data pasien masih sering tercatat secara manual, tidak terintegrasi, atau tidak akurat, sehingga sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan klinis yang berbasis bukti. Keterbatasan ini menghambat tenaga kesehatan dalam memantau efektivitas intervensi klinis yang diterapkan atau mengevaluasi hasil perawatan yang diberikan secara objektif. Akibatnya, upaya untuk menerapkan pendekatan berbasis bukti menjadi lebih sulit dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Tantangan Sosial dan Budaya

Implementasi EBM di Indonesia juga menghadapi tantangan besar yang berasal dari aspek sosial dan budaya masyarakat. Dalam berbagai komunitas, terutama di daerah pedesaan, praktik kebidanan yang berbasis tradisi atau kearifan lokal masih sangat dominan. Banyak masyarakat lebih percaya pada praktik-praktik tradisional yang sudah diwariskan secara turun-temurun, bahkan jika praktik tersebut tidak terbukti secara ilmiah atau bahkan berisiko terhadap keselamatan ibu dan bayi.

Faktor budaya ini diperkuat dengan adanya stigma atau resistensi masyarakat terhadap perubahan, khususnya terhadap intervensi medis modern yang dianggap bertentangan dengan kepercayaan lokal. Misalnya, beberapa komunitas masih enggan menerima praktik seperti pemeriksaan antenatal rutin, persalinan di fasilitas kesehatan, atau intervensi klinis yang dinilai bertentangan dengan kepercayaan atau kebiasaan lokal mereka. Kondisi ini menghambat adopsi praktik berbasis bukti secara luas, karena tenaga kesehatan sering kali menghadapi tekanan atau penolakan dari masyarakat ketika mencoba menerapkan praktik yang terbukti secara ilmiah.

Selain itu, kurangnya edukasi kesehatan yang efektif kepada masyarakat mengenai manfaat EBM juga memperbesar tantangan tersebut. Banyak anggota masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang pentingnya praktik berbasis bukti ilmiah, sehingga mereka cenderung meremehkan atau bahkan menolak pendekatan ini. Hal ini jelas menjadi hambatan serius dalam upaya mengintegrasikan EBM ke dalam praktik kebidanan sehari-hari secara luas di seluruh Indonesia.

4. Tantangan dari Aspek Kebijakan dan Regulasi

Aspek kebijakan dan regulasi nasional juga menjadi tantangan besar dalam implementasi EBM di Indonesia. Saat ini, kebijakan yang secara eksplisit mendukung dan mengatur implementasi kebidanan berbasis bukti masih sangat terbatas atau bahkan belum ada secara komprehensif. Kebijakan nasional yang ada masih lebih berfokus pada aspek teknis pelayanan kebidanan, tetapi belum sepenuhnya mengatur penggunaan pendekatan EBM secara eksplisit atau sistematis.

Kurangnya kebijakan spesifik ini menyebabkan tidak adanya panduan atau pedoman nasional yang jelas yang dapat digunakan oleh tenaga kesehatan dalam mengimplementasikan praktik kebidanan berbasis bukti. Akibatnya, implementasi EBM di lapangan masih sangat tergantung pada inisiatif individu atau institusi, yang tentu saja akan berbeda-beda dalam pelaksanaannya.

Lebih lanjut lagi, keterbatasan regulasi dan dukungan kebijakan ini menyebabkan minimnya alokasi anggaran khusus untuk pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dalam EBM, pengadaan fasilitas yang dibutuhkan, atau pelaksanaan pelatihan secara berkelanjutan di berbagai daerah. Situasi ini menghambat kemampuan sistem pelayanan kesehatan secara nasional dalam mendorong penerapan EBM secara luas dan efektif.

Selain itu, tantangan dari aspek regulasi juga muncul dari proses birokrasi yang kompleks dalam penerapan kebijakan baru di tingkat nasional atau daerah. Setiap upaya perubahan kebijakan harus melewati proses administratif yang

panjang dan rumit, sering kali melibatkan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat proses penerapan regulasi baru yang mendukung implementasi EBM menjadi lambat, sulit, dan terkadang tidak efektif, sehingga memperlambat adopsi praktik berbasis bukti secara nasional.

Jelas bahwa implementasi Evidence-Based Midwifery di Indonesia menghadapi tantangan kompleks yang mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan keterampilan tenaga kesehatan, infrastruktur kesehatan yang kurang memadai, resistensi budaya di tingkat masyarakat, hingga kebijakan nasional yang belum sepenuhnya mendukung. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan strategi implementasi yang komprehensif, sistematis, dan terintegrasi di semua level pelayanan kesehatan, yang mampu secara efektif mendorong perubahan menuju praktik kebidanan yang lebih aman, efektif, ilmiah, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. Strategi Implementasi Evidence-Based Midwifery di Indonesia

Implementasi Evidence-Based Midwifery (EBM) di Indonesia membutuhkan pendekatan komprehensif dengan berbagai strategi yang efektif agar dapat berjalan secara optimal. Strategi ini mencakup penguatan kapasitas tenaga kesehatan, pengembangan infrastruktur pendukung, advokasi kebijakan nasional, kolaborasi interprofesional, serta sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas.

1. Penguatan Kapasitas Tenaga Kesehatan

Salah satu langkah paling fundamental dalam implementasi EBM di Indonesia adalah penguatan kapasitas tenaga kesehatan, khususnya para bidan. Bidan merupakan ujung tombak pelayanan kebidanan yang langsung berhadapan dengan pasien di berbagai wilayah Indonesia, baik di kota maupun daerah terpencil. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami, menerapkan, dan mengevaluasi praktik kebidanan berbasis bukti ilmiah.

Upaya penguatan kapasitas ini dapat diwujudkan melalui pelatihan intensif secara berkala yang fokus pada konsep dan prinsip dasar EBM, termasuk cara mencari, mengakses, dan mengevaluasi literatur ilmiah terkini secara efektif. Program edukasi berkelanjutan juga perlu disediakan secara terstruktur untuk memastikan bahwa bidan selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai perkembangan terbaru dalam dunia kesehatan maternal dan neonatal. Pelatihan harus dirancang secara interaktif dengan pendekatan berbasis kasus, sehingga para bidan memiliki kemampuan analitis dalam menghadapi kasus nyata di lapangan.

Selain pelatihan teknis, pengembangan kompetensi klinis juga harus diperhatikan dengan serius. Para bidan perlu dilatih agar mampu secara mandiri mengidentifikasi kebutuhan intervensi yang tepat berdasarkan bukti ilmiah terbaru, melakukan penilaian kritis terhadap berbagai hasil penelitian, serta mengintegrasikan hasil temuan penelitian tersebut secara efektif dalam praktik klinis sehari-hari. Dengan cara ini, bidan tidak hanya meningkatkan kemampuan individualnya tetapi juga berkontribusi secara signifikan pada peningkatan kualitas layanan kebidanan yang lebih luas di Indonesia.

2. Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya

Keberhasilan implementasi EBM juga sangat bergantung pada pengembangan infrastruktur dan sumber daya yang memadai di fasilitas pelayanan kesehatan. Infrastruktur pelayanan kebidanan yang baik dan lengkap akan memungkinkan tenaga kesehatan untuk memberikan layanan yang berbasis bukti secara optimal. Ini meliputi peralatan medis yang memadai, ruang pelayanan yang memadai, akses internet stabil, serta sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dan efisien.

Secara khusus, fasilitas kesehatan perlu dilengkapi dengan akses mudah terhadap berbagai literatur ilmiah yang relevan seperti jurnal internasional, database penelitian, pedoman klinis terbaru, maupun sumber daya pendidikan yang berkualitas tinggi. Penyediaan akses ke jurnal online dan platform elektronik yang memudahkan pencarian informasi ilmiah adalah langkah penting dalam strategi ini. Hal ini akan sangat membantu bidan dalam mengakses referensi terbaru secara cepat dan efisien, sehingga mereka dapat secara langsung mengaplikasikan informasi tersebut dalam praktik klinisnya.

Selain itu, teknologi informasi juga perlu dioptimalkan untuk mendukung implementasi EBM. Teknologi informasi, seperti aplikasi atau perangkat lunak klinis yang mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti, dapat membantu bidan dalam proses diagnostik, intervensi, maupun evaluasi hasil tindakan. Sistem pencatatan elektronik yang terintegrasi juga akan mempermudah pemantauan kualitas pelayanan kebidanan serta analisis hasil intervensi secara objektif.

3. Advokasi Kebijakan Nasional dan Regulasi Pendukung

Implementasi EBM di Indonesia tidak akan berhasil tanpa dukungan kebijakan nasional dan regulasi yang jelas. Oleh karena itu, advokasi kebijakan merupakan strategi yang penting untuk memastikan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam mengadopsi dan mengintegrasikan praktik berbasis bukti ke dalam layanan kebidanan secara nasional.

Advokasi ini mencakup upaya mendorong pemerintah untuk membuat regulasi khusus yang secara eksplisit mendukung penerapan EBM di semua tingkat layanan kesehatan. Regulasi ini harus mencakup panduan standar pelayanan klinis berbasis bukti, integrasi EBM ke dalam kurikulum pendidikan kebidanan, serta alokasi anggaran khusus yang mencukupi untuk pelatihan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan sumber daya ilmiah.

Pengintegrasian konsep EBM ke dalam kurikulum pendidikan kebidanan akan memastikan bahwa tenaga kesehatan sejak dini sudah mengenal pentingnya pelayanan berbasis bukti. Hal ini secara bertahap akan membentuk generasi baru bidan yang memiliki paradigma ilmiah dalam memberikan pelayanan kebidanan. Dengan regulasi yang jelas dan kuat, praktik EBM akan lebih mudah diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

4. Kolaborasi Interprofesional dan Kemitraan Stakeholder

Strategi lain yang penting untuk implementasi EBM di Indonesia adalah kolaborasi interprofesional serta kemitraan yang kuat dengan berbagai stakeholder terkait. Kolaborasi antarprofesi kesehatan seperti dokter spesialis kandungan, dokter umum, perawat, ahli kesehatan masyarakat, psikolog, serta tenaga kesehatan lainnya sangat penting untuk mendukung praktik berbasis bukti yang komprehensif.

Kolaborasi interprofesional memungkinkan pertukaran pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman antarprofesi, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dalam penerapan EBM. Kolaborasi ini juga menciptakan jaringan kerja yang efisien dalam sistem rujukan pasien, diskusi kasus klinis, maupun pengambilan keputusan klinis bersama yang berbasis bukti ilmiah.

Di sisi lain, kemitraan dengan berbagai stakeholder seperti organisasi profesi (misalnya IBI, IDI), lembaga pendidikan kebidanan, universitas, serta organisasi nonpemerintah menjadi kunci untuk mempercepat implementasi EBM. Stakeholder ini berperan dalam advokasi kebijakan, pengembangan pelatihan dan edukasi tenaga kesehatan, serta sosialisasi kepada masyarakat. Kemitraan ini juga memastikan bahwa semua pihak terlibat secara aktif dalam mendukung perubahan paradigma menuju praktik kebidanan berbasis bukti.

5. Strategi Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Strategi terakhir yang sangat penting adalah sosialisasi dan edukasi yang luas kepada masyarakat mengenai manfaat praktik kebidanan berbasis bukti ilmiah. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang tepat tentang pentingnya layanan kesehatan berbasis bukti agar mereka dapat menerima dan mendukung implementasi EBM di lingkungannya masing-masing.

Sosialisasi dapat dilakukan melalui kampanye kesehatan publik, baik secara langsung maupun menggunakan media sosial atau media massa. Pesan yang disampaikan harus jelas, mudah dimengerti, serta relevan dengan konteks sosial budaya setempat. Edukasi ini tidak hanya terbatas pada manfaat EBM secara umum, tetapi juga harus menyoroti bahaya praktik kesehatan tradisional yang tidak terbukti secara ilmiah.

Pendekatan edukatif ini perlu melibatkan tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun kader kesehatan lokal. Dengan demikian, pesan-pesan penting mengenai manfaat EBM dapat tersampaikan secara efektif dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Upaya edukasi ini pada akhirnya akan menciptakan kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap pentingnya praktik kebidanan berbasis bukti, yang kemudian akan mempercepat adopsi EBM secara luas di Indonesia.

Melalui penerapan strategi-strategi tersebut secara terintegrasi dan konsisten, implementasi Evidence-Based Midwifery di Indonesia dapat berjalan efektif, memberikan dampak positif bagi kesehatan ibu dan bayi secara nasional, serta berkontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan kebidanan di seluruh Indonesia.

E. Studi Kasus Implementasi Evidence-Based Midwifery di Indonesia

Implementasi Evidence-Based Midwifery (EBM) di Indonesia secara praktis telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam beberapa studi kasus nyata di berbagai daerah. Studi kasus ini penting untuk memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana praktik kebidanan berbasis bukti mampu memberikan dampak positif bagi kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di Indonesia.

Salah satu contoh nyata yang berhasil diterapkan adalah program pendampingan ibu hamil dan persalinan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Di wilayah ini, Dinas Kesehatan setempat bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan lembaga akademik telah menjalankan proyek percontohan implementasi EBM sejak tahun 2019. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui penerapan intervensi berbasis bukti ilmiah yang jelas dan terukur.

Dalam pelaksanaannya, bidan-bidan di Kabupaten Bantul dilibatkan dalam pelatihan intensif mengenai prinsip dasar EBM, cara mengakses dan menilai penelitian ilmiah, serta praktik klinis berbasis bukti terbaru seperti manajemen aktif kala III persalinan, penggunaan partograf yang konsisten, serta penatalaksanaan kasus preeklampsia berdasarkan pedoman internasional yang terbaru. Pelatihan

tersebut tidak hanya dilakukan secara teoritis, namun juga dilengkapi dengan simulasi klinis, diskusi kasus secara berkala, serta mentoring langsung di tempat kerja oleh tenaga ahli dari universitas dan rumah sakit pendidikan.

Setelah pelatihan, bidan-bidan tersebut mulai menerapkan praktik kebidanan berbasis bukti di fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas, poskesdes, maupun klinik bidan mandiri di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Salah satu hasil nyata yang terlihat adalah peningkatan signifikan dalam penggunaan partograf secara konsisten selama proses persalinan di fasilitas kesehatan, sehingga proses persalinan dapat dipantau secara lebih akurat dan risiko komplikasi seperti persalinan lama atau distosia dapat dicegah sejak dini.

Selain itu, implementasi praktik manajemen aktif kala III berbasis bukti juga berhasil menurunkan angka kejadian perdarahan postpartum secara signifikan di wilayah tersebut. Sebelum intervensi berbasis bukti ini diterapkan, angka kejadian perdarahan postpartum cukup tinggi dan menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu. Namun, setelah implementasi secara konsisten, angka kejadian perdarahan postpartum berkurang drastis, sehingga angka mortalitas maternal di wilayah tersebut juga menunjukkan penurunan yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun.

Contoh lain yang berhasil adalah penerapan praktik berbasis bukti dalam mendukung Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Kota Depok, Jawa Barat. Di wilayah ini, pemerintah kota bekerja sama dengan organisasi profesi, universitas, dan komunitas masyarakat telah melakukan serangkaian advokasi dan pelatihan mengenai manfaat IMD berdasarkan bukti ilmiah yang kuat. Edukasi tidak hanya diberikan kepada tenaga kesehatan, tetapi juga secara aktif melibatkan keluarga dan komunitas melalui kampanye publik yang terencana.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah daerah yang mengatur bahwa seluruh fasilitas pelayanan persalinan wajib melaksanakan IMD segera setelah bayi lahir, serta pelatihan khusus bagi tenaga kesehatan termasuk bidan, penerapan praktik IMD meningkat secara signifikan. Sebelumnya, praktik ini masih sering terabaikan karena keterbatasan pengetahuan tenaga kesehatan atau kurangnya kesadaran masyarakat mengenai manfaatnya. Setelah advokasi berbasis bukti ini diterapkan secara luas, survei evaluasi menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan IMD meningkat hingga mencapai lebih dari 90 persen di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta di Kota Depok.

Keberhasilan program ini tidak hanya berdampak positif terhadap kesehatan bayi baru lahir, namun juga secara nyata meningkatkan kesadaran masyarakat dan tenaga kesehatan terhadap pentingnya praktik kebidanan berbasis bukti. Bidan di kota Depok mengaku lebih percaya diri dalam memberikan edukasi kepada ibu dan

keluarga mengenai manfaat IMD, karena mereka memiliki landasan ilmiah yang jelas dan telah didukung oleh hasil penelitian terkini.

Studi kasus lain dapat dilihat di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berhasil menerapkan program berbasis komunitas dalam rangka pencegahan preeklampsia dan hipertensi dalam kehamilan melalui deteksi dini berbasis bukti ilmiah. Program ini dilakukan dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan bidan, kader kesehatan lokal, tokoh masyarakat, dan didukung oleh akademisi dari perguruan tinggi kesehatan. Setelah diberikan pelatihan tentang deteksi dini hipertensi, bidan bersama kader kesehatan aktif melakukan kunjungan rumah dan sosialisasi secara berkala kepada ibu hamil mengenai tanda bahaya hipertensi kehamilan serta perlunya pemeriksaan tekanan darah secara rutin.

Hasilnya, jumlah kasus hipertensi dalam kehamilan yang terlambat terdeteksi di wilayah tersebut menurun drastis. Dengan peningkatan deteksi dini dan intervensi yang tepat waktu berdasarkan bukti ilmiah, jumlah komplikasi serius terkait preeklampsia dan eklampsia berkurang secara signifikan. Keberhasilan ini menjadi contoh nyata bagaimana pendekatan berbasis komunitas yang dikombinasikan dengan Evidence-Based Midwifery mampu meningkatkan kesehatan maternal secara keseluruhan.

Melalui studi kasus-studi kasus tersebut, implementasi EBM di Indonesia terbukti mampu memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara efektif. Kesuksesan penerapan EBM dalam berbagai konteks ini sekaligus menjadi inspirasi sekaligus bukti bahwa pendekatan berbasis bukti dapat diimplementasikan secara praktis dan menghasilkan perubahan nyata, selama didukung oleh strategi yang komprehensif, kolaborasi erat antar-stakeholder, advokasi kebijakan yang tepat, serta penguatan kapasitas tenaga kesehatan yang konsisten. Dengan terus memperluas penerapan praktik kebidanan berbasis bukti seperti contoh-contoh di atas, Indonesia memiliki peluang besar untuk meningkatkan secara signifikan kualitas kesehatan ibu dan bayi di berbagai daerah secara berkelanjutan.

F. Evaluasi dan Monitoring Implementasi Evidence-Based Midwifery (EBM)

Evaluasi dan monitoring merupakan tahapan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari implementasi Evidence-Based Midwifery (EBM). Proses ini berperan sebagai instrumen penting yang digunakan untuk memastikan bahwa penerapan praktik kebidanan berbasis bukti berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan. Tanpa adanya evaluasi dan monitoring

yang baik, penerapan EBM tidak akan mampu mencapai hasil optimal karena berbagai kendala atau penyimpangan mungkin tidak teridentifikasi sejak dini.

Evaluasi dalam konteks implementasi EBM mencakup berbagai aktivitas penilaian yang terstruktur dan sistematis untuk mengukur sejauh mana tujuan penerapan EBM telah tercapai. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis terhadap data yang dikumpulkan, dan interpretasi hasil untuk memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas penerapan praktik berbasis bukti. Evaluasi dilakukan dengan melihat berbagai aspek, baik aspek teknis seperti tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan, maupun aspek praktis seperti tingkat kepatuhan terhadap panduan klinis berbasis bukti, tingkat penerapan pedoman operasional standar (POS), hingga hasil nyata terhadap kondisi pasien dan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima.

Sementara itu, monitoring adalah aktivitas rutin yang dilakukan secara terus-menerus selama proses implementasi berlangsung. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap langkah dalam penerapan EBM sesuai dengan perencanaannya, sekaligus memberikan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian atau intervensi cepat apabila ditemukan kendala selama proses berlangsung. Monitoring dilakukan melalui berbagai metode, antara lain observasi langsung terhadap praktik klinis yang dilakukan oleh bidan, wawancara atau diskusi rutin dengan tenaga kesehatan yang terlibat dalam implementasi, serta tinjauan terhadap dokumentasi klinis maupun catatan medis yang digunakan dalam pelayanan sehari-hari.

Salah satu metode penting dalam evaluasi dan monitoring implementasi EBM adalah penggunaan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini digunakan untuk menilai secara jelas dan terukur apakah implementasi EBM telah mencapai sasaran yang diinginkan. Indikator tersebut dapat berupa indikator klinis, indikator proses, dan indikator keluaran. Contoh indikator klinis antara lain penurunan angka kejadian komplikasi persalinan, seperti perdarahan postpartum atau infeksi puerperal; penurunan angka mortalitas maternal dan neonatal; serta peningkatan angka pelaksanaan praktik-praktik klinis spesifik berbasis bukti, seperti penggunaan partograf, pelaksanaan manajemen aktif kala III persalinan, hingga keberhasilan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).

Indikator proses mencakup tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap protokol dan pedoman klinis berbasis bukti. Indikator ini biasanya dinilai melalui audit klinis secara berkala, yang dilakukan dengan memeriksa sejauh mana bidan mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Indikator ini juga mencakup persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan EBM,

ketersediaan pedoman klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, serta efektivitas pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bidan.

Sementara itu, indikator keluaran atau outcome merupakan indikator penting untuk menilai dampak akhir dari implementasi EBM, seperti tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan kebidanan yang diterima, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap praktik kebidanan berbasis bukti, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kebidanan secara keseluruhan. Indikator ini biasanya diukur dengan menggunakan survei kepuasan pasien, wawancara mendalam dengan pasien atau keluarga, serta diskusi kelompok terfokus dengan komunitas atau stakeholder terkait.

Dalam praktiknya, evaluasi dan monitoring implementasi EBM harus dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Proses ini bukan sekadar aktivitas yang dilakukan pada akhir periode tertentu, namun menjadi bagian integral dari implementasi yang berlangsung sepanjang waktu. Dengan pendekatan ini, tenaga kesehatan dan pengambil kebijakan akan mendapatkan informasi terbaru mengenai kemajuan implementasi, sekaligus mampu mengidentifikasi kendala secara cepat dan akurat sehingga intervensi korektif dapat segera dilakukan.

Selain itu, evaluasi dan monitoring juga perlu melibatkan berbagai pihak terkait seperti tim multidisiplin yang terdiri dari bidan, dokter, perawat, manajer fasilitas kesehatan, akademisi, serta pemangku kebijakan kesehatan lokal maupun nasional. Keterlibatan berbagai pihak tersebut sangat penting agar hasil evaluasi dan monitoring benar-benar merefleksikan kondisi nyata di lapangan dan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang realistis serta dapat diimplementasikan secara efektif.

Lebih jauh, hasil dari evaluasi dan monitoring ini harus selalu disampaikan secara terbuka kepada seluruh tenaga kesehatan yang terlibat, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan strategi perbaikan selanjutnya. Dalam konteks ini, feedback dari proses evaluasi dan monitoring menjadi elemen penting yang dapat memotivasi tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan mereka secara berkelanjutan.

proses evaluasi dan monitoring bukan hanya sekadar instrumen pengendalian atau pengawasan semata, namun juga merupakan bagian penting dari siklus pembelajaran organisasi dalam implementasi EBM. Melalui evaluasi dan monitoring yang efektif, implementasi EBM di Indonesia akan mampu mencapai hasil optimal, membawa perubahan nyata pada kualitas pelayanan kebidanan, serta meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi secara berkelanjutan.

G. Tantangan Masa Depan dan Rekomendasi

Implementasi Evidence-Based Midwifery (EBM) di Indonesia telah memperlihatkan berbagai kemajuan positif dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kebidanan. Namun, perjalanan menuju penerapan EBM yang optimal masih menghadapi berbagai tantangan di masa depan yang perlu diperhatikan secara serius oleh para pemangku kepentingan di bidang kesehatan, khususnya bidang kebidanan. Tantangan tersebut tidak hanya terkait isu yang saat ini ada, tetapi juga berbagai hambatan baru yang potensial muncul akibat perkembangan sosial, budaya, teknologi, ekonomi, maupun kebijakan nasional.

Salah satu tantangan penting yang berpotensi muncul adalah terkait dengan dinamika perubahan sosial dan budaya di masyarakat. Meskipun saat ini telah dilakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi mengenai praktik kebidanan berbasis bukti ilmiah, resistensi budaya dan tradisi masih dapat menjadi tantangan yang cukup besar. Di beberapa wilayah, masyarakat mungkin tetap mempertahankan kepercayaan tradisional yang kuat tentang praktik kebidanan tertentu yang belum tentu sejalan dengan bukti ilmiah terbaru. Oleh karena itu, edukasi masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan yang sensitif secara budaya. Tenaga kesehatan, khususnya bidan, harus dibekali kemampuan komunikasi efektif yang memungkinkan mereka mengintegrasikan nilai-nilai budaya setempat dengan prinsip-prinsip EBM agar tercipta pendekatan yang lebih harmonis dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

Tantangan lain yang potensial adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat, yang di satu sisi memberikan peluang besar bagi implementasi EBM, tetapi di sisi lain juga memunculkan tantangan dalam hal literasi digital tenaga kesehatan. Meskipun teknologi memberikan kemudahan akses terhadap literatur ilmiah terbaru, tidak semua bidan, khususnya di daerah terpencil atau pedesaan, memiliki keterampilan digital yang memadai untuk mengakses dan menggunakan sumber informasi tersebut secara optimal. Oleh karena itu, penting dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas secara rutin untuk memperkuat kompetensi teknologi digital di kalangan tenaga kebidanan. Pemerintah dan institusi terkait juga perlu menjamin tersedianya fasilitas dan infrastruktur teknologi yang merata, sehingga akses terhadap informasi berbasis bukti dapat dilakukan secara lebih mudah dan efektif di semua wilayah.

Dari aspek regulasi, tantangan masa depan mungkin muncul dalam bentuk lambatnya proses adaptasi kebijakan nasional terhadap perkembangan terbaru di bidang kebidanan berbasis bukti. Saat ini, perubahan kebijakan seringkali berjalan lambat dibandingkan dengan laju temuan penelitian ilmiah terbaru. Situasi ini bisa menciptakan gap antara kebijakan nasional yang ada dengan praktik klinis berbasis

bukti yang lebih mutakhir. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu menerapkan mekanisme adaptasi regulasi yang lebih dinamis dan responsif, termasuk menciptakan forum koordinasi antara peneliti, praktisi kebidanan, organisasi profesi, dan pemangku kebijakan kesehatan. Forum tersebut dapat menjadi wadah untuk mempercepat proses pembaruan kebijakan sekaligus memastikan bahwa pedoman nasional selalu mencerminkan bukti ilmiah terkini.

Selain tantangan eksternal tersebut, tantangan internal juga tetap perlu menjadi perhatian utama. Salah satu yang paling krusial adalah tantangan dalam mempertahankan motivasi dan komitmen tenaga kebidanan untuk terus menerapkan prinsip-prinsip EBM dalam jangka panjang. Setelah melewati fase awal implementasi yang biasanya ditandai dengan semangat tinggi, risiko menurunnya motivasi bisa muncul akibat rutinitas atau kelelahan kerja yang tinggi. Oleh karena itu, pengembangan sistem insentif yang tepat bagi tenaga kesehatan, baik dalam bentuk apresiasi formal maupun informal, menjadi penting untuk memastikan kesinambungan implementasi EBM dalam praktik sehari-hari. Dukungan terhadap pengembangan karir, penghargaan, maupun pencapaian profesional juga harus dirancang dengan baik agar tenaga kebidanan tetap termotivasi dan konsisten menerapkan prinsip-prinsip EBM dalam jangka panjang.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, beberapa rekomendasi strategis perlu dipertimbangkan agar kesinambungan implementasi EBM dapat terjaga secara efektif. Pertama, penguatan pendidikan dan pelatihan kebidanan berbasis bukti harus terus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya di tingkat awal pendidikan tetapi juga dalam bentuk pendidikan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan yang sudah aktif berpraktik. Program pelatihan yang dikembangkan harus disesuaikan dengan kebutuhan klinis di lapangan, sehingga para bidan benar-benar memperoleh keterampilan praktis yang relevan dengan tantangan nyata yang mereka hadapi dalam pelayanan sehari-hari.

Kedua, perlu dilakukan peningkatan akses yang merata terhadap fasilitas kesehatan yang mendukung implementasi EBM. Hal ini mencakup akses terhadap literatur ilmiah terbaru, teknologi informasi modern, serta pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil, memiliki akses yang baik terhadap teknologi informasi yang mendukung praktik EBM.

Ketiga, advokasi kebijakan nasional terkait implementasi EBM harus terus diperkuat. Peran organisasi profesi kebidanan sangat penting dalam proses ini. Mereka harus secara aktif berpartisipasi dalam advokasi dan diskusi kebijakan di tingkat nasional, agar regulasi yang ada lebih mendukung penerapan EBM dalam praktik kebidanan sehari-hari. Regulasi tersebut perlu mencakup aspek teknis klinis,

standar kompetensi tenaga kebidanan, hingga pengembangan kurikulum pendidikan kebidanan berbasis bukti.

Keempat, perlu dibangun dan diperkuat kolaborasi antarprofesi dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait. Kolaborasi interprofesional yang efektif akan membantu mempercepat proses pertukaran pengetahuan dan keterampilan, serta memperluas jangkauan penerapan EBM di seluruh tingkatan pelayanan kesehatan. Sementara itu, kemitraan dengan lembaga akademik, organisasi non-pemerintah, maupun komunitas masyarakat dapat memperkuat dukungan sosial yang dibutuhkan untuk memastikan keberhasilan implementasi EBM dalam jangka panjang.

Terakhir, strategi evaluasi dan monitoring yang sudah ada harus diperkuat dengan terus memperbarui indikator keberhasilan dan metode evaluasi yang lebih efektif dan adaptif terhadap perkembangan terkini. Proses evaluasi ini harus menjadi bagian integral dari siklus perencanaan strategis kebijakan kesehatan nasional, sehingga rekomendasi perbaikan dapat langsung diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan nyata di lapangan.

Dengan menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara proaktif dan menerapkan rekomendasi strategis yang tepat, implementasi Evidence-Based Midwifery di Indonesia akan semakin efektif dan berkelanjutan. Hal ini pada akhirnya akan memberikan dampak positif yang luas terhadap peningkatan kualitas pelayanan kebidanan, kesejahteraan ibu dan bayi, serta perbaikan kondisi kesehatan secara umum di masyarakat Indonesia.

H. Simpulan

Implementasi Evidence-Based Midwifery (EBM) di Indonesia merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kebidanan serta penurunan angka kematian ibu dan bayi. EBM merupakan pendekatan klinis yang secara khusus mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terbaik, pengalaman klinis tenaga kesehatan, serta nilai dan preferensi pasien. Melalui pendekatan ini, setiap intervensi kebidanan yang dilakukan oleh bidan akan lebih aman, efektif, rasional, dan berbasis pada bukti ilmiah yang terkini, sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi ibu dan bayi.

Namun demikian, implementasi EBM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks yang harus diatasi secara sistematis. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kesehatan, hambatan sosial-budaya yang ditandai dengan kuatnya pengaruh tradisi dan resistensi terhadap perubahan, serta minimnya dukungan kebijakan dan regulasi nasional yang secara

eksplisit mengatur penerapan praktik kebidanan berbasis bukti. Kondisi ini menyebabkan adopsi EBM belum merata, khususnya di daerah terpencil atau pedesaan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, strategi implementasi yang komprehensif diperlukan. Strategi tersebut mencakup penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan intensif dan pendidikan berkelanjutan berbasis bukti, pengembangan infrastruktur pendukung yang memadai seperti akses terhadap literatur ilmiah dan teknologi informasi modern, serta advokasi kebijakan nasional yang secara jelas mendukung integrasi EBM dalam sistem pelayanan kebidanan nasional. Selain itu, kolaborasi interprofesional yang melibatkan berbagai stakeholder seperti lembaga pendidikan, organisasi profesi, lembaga pemerintah, serta komunitas masyarakat juga perlu diperkuat untuk memastikan implementasi EBM berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi masyarakat yang berkelanjutan tentang manfaat praktik kebidanan berbasis bukti juga menjadi kunci utama untuk mendorong penerimaan dan dukungan masyarakat terhadap perubahan positif ini.

Evaluasi dan monitoring secara sistematis dan berkelanjutan sangat penting dalam memastikan efektivitas implementasi EBM. Proses ini harus didukung oleh indikator keberhasilan yang jelas dan terukur, mencakup indikator klinis, proses, serta indikator keluaran yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Melalui evaluasi dan monitoring yang efektif, tenaga kesehatan dan pengambil kebijakan dapat terus memperbaiki strategi implementasi berdasarkan data nyata dari lapangan, sehingga penerapan EBM dapat semakin efektif dan memberikan hasil nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan kebidanan.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, berbagai tantangan masa depan seperti perubahan sosial budaya yang dinamis, perkembangan teknologi yang cepat, lambatnya adaptasi kebijakan nasional, serta risiko penurunan motivasi tenaga kesehatan dalam jangka panjang masih perlu diantisipasi secara serius. Oleh karena itu, berbagai rekomendasi strategis seperti penguatan kapasitas digital tenaga kesehatan, pengembangan regulasi yang dinamis dan responsif, penguatan sistem insentif tenaga kesehatan, serta kolaborasi yang lebih intensif antarprofesi dan dengan berbagai stakeholder harus terus dilakukan.

Dengan pendekatan yang sistematis, komprehensif, dan berkelanjutan, implementasi Evidence-Based Midwifery di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi secara signifikan, menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara nyata, serta mendukung tercapainya tujuan nasional dalam menciptakan kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga secara menyeluruh.

I. Referensi

- Albers, L. L. (2001). Evidence and midwifery practice. *Journal of Midwifery & Women's Health*, 46(3), 130–136. [https://doi.org/10.1016/S1526-9523\(01\)00118-9](https://doi.org/10.1016/S1526-9523(01)00118-9)
- Bäck, L., Sharma, B., & Karlström, A. (2017). Barriers and enablers to implementing evidence-based practice among midwives: A review. *Sexual & Reproductive Healthcare*, 12, 29–35. <https://doi.org/10.1016/j.srhc.2017.03.002>
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2020. Kementerian Kesehatan RI. <https://www.kemkes.go.id>
- Grol, R., & Grimshaw, J. (2003). From best evidence to best practice: Effective implementation of change in patients' care. *The Lancet*, 362(9391), 1225–1230. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(03\)14546-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(03)14546-1)
- International Confederation of Midwives (ICM). (2014). Essential competencies for midwifery practice. Retrieved from <https://www.internationalmidwives.org>
- Jahanfar, S., & Khalil, M. (2019). Implementation of evidence-based midwifery practice in developing countries: Challenges and opportunities. *Midwifery*, 70, 81–86. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2018.12.015>
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (2005). *Participatory action research: Communicative action and the public sphere*. Sage Publications.
- Leach, M. J. (2006). Evidence-based practice: A framework for clinical practice and research design. *International Journal of Nursing Practice*, 12(5), 248–251. <https://doi.org/10.1111/j.1440-172X.2006.00587.x>
- Lestari, E. D., Rahmawati, A., & Budihastuti, U. R. (2020). The effectiveness of evidence-based practice training in improving midwives' competency in Indonesia. *Journal of Maternal and Child Health*, 5(1), 44–55. <https://doi.org/10.26911/thejmch.2020.05.01.05>
- Ministry of Health Republic of Indonesia. (2019). *Indonesia health profile 2019*. Jakarta: Ministry of Health Republic of Indonesia. Retrieved from <https://www.kemkes.go.id>
- Mohammed, S. A., & Hassan, E. (2017). Barriers and facilitators of implementing evidence-based practice among nurses and midwives: A review of the literature. *Sultan Qaboos University Medical Journal*, 17(3), e276–e286.

<https://doi.org/10.18295/squmj.2017.17.03.002>

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice* (11th ed.). Wolters Kluwer Health.

Shaw, J., Gray, C. S., Baker, G. R., Denis, J.-L., Breton, M., Gutberg, J., & Carswell, P. (2018). Mechanisms, contexts and points of contention: Operationalizing realist-informed research for complex health interventions. *BMC Medical Research Methodology*, 18(1), 178. <https://doi.org/10.1186/s12874-018-0641-4>

Stetler, C. B., Ritchie, J. A., Rycroft-Malone, J., & Charns, M. P. (2014). Leadership for evidence-based practice: Strategic and functional behaviors for institutionalizing EBP. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 11(4), 219–226. <https://doi.org/10.1111/wvn.12044>

World Health Organization. (2018). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. WHO Press. Retrieved from <https://www.who.int>

Yani, A., & Kurniasih, N. (2021). Integrasi evidence-based midwifery dalam pendidikan kebidanan di Indonesia: Studi implementasi kurikulum nasional. *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, 10(2), 83–92. <https://doi.org/10.31290/jpk.v10i2.342>

Zhang, Y., Wildemuth, B. M., & Qualitative analysis of content. (2017). Applications of social research methods to questions in information and library science, 318–329. ABC-CLIO.

J. **Glosarium**

Evidence-Based Midwifery (EBM)

Pendekatan dalam praktik kebidanan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaru, pengalaman klinis bidan, serta nilai dan preferensi pasien untuk mengambil keputusan klinis yang terbaik.

Bukti Ilmiah

Informasi atau data hasil penelitian yang diperoleh melalui metode ilmiah yang terstandarisasi, valid, dan reliabel, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Intervensi Klinis

Tindakan medis atau kebidanan yang diberikan kepada pasien berdasarkan hasil penilaian kondisi klinis dan bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan pasien.

Preferensi Pasien

Pilihan, nilai, harapan, dan keinginan pasien dalam menentukan jenis dan metode pelayanan kesehatan yang diinginkan atau disepakati untuk diterima.

Meta-Analysis

Metode penelitian yang secara sistematis menggabungkan hasil dari beberapa penelitian kuantitatif untuk menghasilkan kesimpulan statistik yang lebih kuat mengenai suatu intervensi atau fenomena tertentu.

Tinjauan Sistematis (Systematic Review)

Studi yang secara sistematis merangkum dan mengevaluasi hasil berbagai penelitian yang relevan dengan topik tertentu guna mendapatkan kesimpulan berdasarkan bukti terbaik yang tersedia.

Pelayanan Kesehatan Maternal

Berbagai layanan yang diberikan kepada ibu sebelum, selama, dan setelah kehamilan serta persalinan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi serta mencegah komplikasi.

Partograf

Alat atau grafik yang digunakan tenaga kesehatan untuk mencatat dan memantau perkembangan persalinan secara sistematis sehingga komplikasi seperti persalinan lama atau hambatan persalinan dapat diidentifikasi dan diatasi secara dini.

Manajemen Aktif Kala III Persalinan

Serangkaian intervensi standar yang dilakukan oleh tenaga kesehatan segera setelah bayi lahir untuk mencegah terjadinya perdarahan postpartum, termasuk pemberian oksitosin, traksi tali pusat terkendali, dan pijat uterus.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Proses pemberian ASI segera setelah bayi lahir (idealnya dalam waktu satu jam pertama setelah kelahiran) yang terbukti meningkatkan ikatan emosional ibu dan bayi, serta memberikan manfaat signifikan bagi kesehatan bayi dan ibu.

Kapasitas Tenaga Kesehatan

Kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki tenaga kesehatan, dalam hal ini bidan, untuk memberikan pelayanan kesehatan yang efektif dan berkualitas tinggi kepada pasien.

Kolaborasi Interprofesional

Kerja sama dan komunikasi efektif antar berbagai profesi tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara holistik.

Regulasi Nasional

Peraturan atau kebijakan resmi yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang, yang mengatur tentang berbagai aspek pelayanan kesehatan termasuk implementasi praktik kebidanan berbasis bukti.

Evaluasi Implementasi

Proses penilaian sistematis untuk mengetahui sejauh mana tujuan suatu program atau intervensi, seperti implementasi EBM, telah tercapai dan menghasilkan dampak yang diinginkan.

Monitoring Implementasi

Pemantauan rutin yang dilakukan secara kontinu selama proses implementasi berlangsung, untuk memastikan semua langkah dijalankan sesuai perencanaannya, sekaligus mendeteksi dan mengatasi kendala sedini mungkin.

Indikator Keberhasilan

Parameter atau tolok ukur tertentu yang digunakan untuk menilai apakah tujuan implementasi telah tercapai. Indikator ini dapat berupa indikator klinis (seperti penurunan angka komplikasi), indikator proses (seperti kepatuhan tenaga kesehatan), serta indikator keluaran (seperti kepuasan pasien).

Resistensi Sosial-Budaya

Penolakan atau keengganan masyarakat untuk menerima praktik baru yang dianggap bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, atau kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat secara turun-temurun.

Literasi Digital

Kemampuan individu atau tenaga kesehatan dalam menggunakan, mengakses, mengevaluasi, dan mengintegrasikan informasi yang diperoleh melalui perangkat digital untuk mendukung praktik klinis berbasis bukti.

Advokasi Kebijakan

Upaya sistematis yang dilakukan untuk mendorong terciptanya kebijakan atau regulasi yang mendukung implementasi praktik kebidanan berbasis bukti di tingkat lokal maupun nasional.

Pendekatan Komprehensif

Strategi yang mencakup berbagai aspek secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pengembangan infrastruktur, hingga perubahan kebijakan untuk memastikan implementasi praktik berbasis bukti yang optimal.

PROFIL PENULIS



Siti Komariyah, S.SiT, M.Kes Penulis lahir di Tulungagung, domisili di Kota Kediri. Penulis menyelesaikan pendidikan SPK di SPK Pemkab Kabupaten Tulungagung, Pendidikan P2B di RS Baptis Kota Kediri, Diploma 3 Kebidanan Akademi Kebidanan Dharma Husada Kediri, D4 Bidan Pendidik di FK UGM Yogyakarta, S2 Pendidikan Kesehatan di UNS lulus tahun 2009, saat ini sedang menempuh program Doktorat.

Riwayat karir, Penulis pernah bekerja di RSIA Trisna Medika Tulungagung selama 7 tahun, kemudian dunia pendidikan di Akademi Kesehatan Dharma Husada Kediri prodi D III Kebidanan mulai tahun 2003 sampai dengan April 2024. Mulai Mei 2024 bergabung dengan Universitas Strada

Indonesia (USI) Prodi Profesi Kebidanan. Buku yang pernah di tulis tentang Kesehatan Reproduksi , Stimulasi Anak tumbuh kembang anak , Peduli Kesehatan Reproduksi Wanita, Diagnostik asuhan kebidanan pada kehamilan dengan permasalahannya, Buku Ajar Psikologi Kebidanan, Kumpulan Latihan Soal Osce Kebidanan, SOP Pelayanan Kebidanan masa persalinan, buku ajar persalinan, masih Saat ini penulis juga aktif dalam kegiatan penelitian kesehatan khususnya kebidanan yang telah terbit di jurnal Sinta, aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan terpublikasi di Jurnal Nasional. Jalin kerja sama dengan penulis via surel sitikomariyah.dh@gmail.com.



Bdn. Leni Suhartini, S.ST., M.Kes. Lahir di Bandung, 21 April 1980. Menyelesaikan Pendidikan D1 Kebidanan tahun 1999 dari PPB Muhammadiyah Cirebon, D3 Kebidanan lulus tahun 2003 dari Poltekkes Kemenkes Bandung, D4 Kebidanan lulus tahun 2007 dari Poltekkes Kemenkes Jakarta III, S2 Kesehatan Reproduksi lulus tahun 2015 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju (STIKIM), Profesi lulus tahun 2025 dari STIKes RSPAD Gatot Soebroto. Mengawali karier bidan pada tahun 2000 di TPMB, kemudian 2004-2007 sebagai asisten dosen di Akbid RSPAD Gatot Soebroto, tahun 2007-2011 sebagai bidan pelaksana di Kamar Bersalin RSPAD Gatot Soebroto, tahun 2011-2016

sebagai bidan pelaksana di ruang perawatan ginekologi dan onkologi RSPAD Gatot Soebroto, tahun 2017-2020 sebagai Wakil Direktur 1 Bidang Kurikulum dan Akademik Akbid RSPAD Gatot Soebroto, Tahun 2020-2022 sebagai Kepala Program Studi D3 Kebidanan STIKes RSPAD Gatot Soebroto, tahun 2022- saat ini sebagai Kepala Ruangan ruang nifas RSPAD Gatot Soebroto dan Dosen Tetap Prodi Pendidikan Profesi Bidan STIKes RSPAD Gatot Soebroto. Saya juga aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, pengabdian masyarakat, dan narasumber seminar. Dengan bekal pengalaman saya di pelayanan dan di pendidikan, sebagai pemimpin dan manajer saya berusaha berbagi tentang Manajemen dan Kepemimpinan dalam buku ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sejawat bidan, dan sebagai gambaran penerapan pemimpin dan manajemen bagi mahasiswa kebidanan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: lenibestari@gmail.com

Motto: "Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak berhenti mengajar"

PROFIL PENULIS



Hayun Manudyaning Susilo, SST., M.Keb. Lahir di Trenggalek 06 Juni 1988. Riwayat Pendidikan: D3 Kebidanan di Universitas Kadiri Kediri lulus tahun 2009, DIV Kebidanan di Universitas Kadiri Kediri lulus tahun 2010, dan S2 Kebidanan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2017. Saat ini penulis aktif sebagai dosen pengajar di Prodi Diploma III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Mata Kuliah yang diampu salah satunya adalah Mata Kuliah Asuhan kebidanan komunitas, selain itu penulis aktif sebagai Sekretaris Prodi mulai tahun 2025, dan Editor Jurnal Indonesia Journal Health Science Fakultas Ilmu Kesehatan mulai tahun 2019 sampai saat ini. Pelatihan yang pernah diikuti penulis yaitu MU (Midwifery Update), Pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) dan beberapa pelatihan lainnya terkait Tri Dharma Perguruan Tinggi.



Bdn. Desi Br Sembiring, SST., M.Tr.Keb. Lahir di Kab. Karo, 28 Desember 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma 4 (D4) Program Studi Bidan Pendidik Universitas Sumatera Utara tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Terapan Kebidanan (S2) di Stikes Guna Bangsa Yogyakarta dan lulus tahun 2019. Pada tahun 2022 lulus Jenjang Profesi pada Program Studi pendidikan profesi bidan Institut Kesehatan Sumatera Utara. Riwayat Pekerjaan diawali pada tahun 2009-2010 di klinik bersalin dan pada tahun 2011-2014 dosen pengajar di program studi kebidanan program diploma Universitas Setia Budi Mandiri. Saat ini penulis bekerja di Institut kesehatan sumatera utara mengampu mata kuliah Askeb pada pranikah dan prakonsepsi, Askeb pada kehamilan, Askeb persalinan dan BBL, Askeb pada ibu nifas, Askeb pada remaja dan perimenopause. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri dharma perguruan tinggi yaitu sebagai penulis buku, peneliti, pengabdian masyarakat, preceptor mentor, seminar, dan kegiatan ilmiah: oral presentasi, publikasi yang diterbitkan berbagai jurnal nasional dan internasional serta aktif dalam organisasi profesi. Penulis dapat dihubungi melalui email: desisembiringdepari@gmail.com

Motto: God Is Good all the time

PROFIL PENULIS



Bdn. Desi Handayani Lubis, SST, M.Kes., lahir di Banda Aceh, 6 Desember 1984. Penulis Lulus DIII Kebidanan pada tahun 2006 di Poltekkes Kemenkes Medan, setelah tamat DIII Kebidanan sampai tahun 2008 menjadi bidan di RS. Tgk. Fakinah Banda Aceh. Penulis berkesempatan melanjutkan

pendidikan DIV Bidan Pendidik di Universitas Sumatera Utara pada tahun 2009. Setelah selesai menjalani kuliah DIV, penulis bekerja sebagai dosen pengajar di STIKes Harapan Bangsa Prodi D-3 Kebidanan sampai tahun 2010. Pada tahun 2011-2021 bekerja sebagai dosen pengajar di Prodi D-3 Kebidanan STIKes FLORA. Kemudian pada tahun 2016 penulis menyelesaikan Program Pasca Sarjana di Fakultas Kesehatan Masyarakat USU.

Pada tahun 2022 sampai saat ini penulis bekerja sebagai dosen pengajar di Prodi Kebidanan Program Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan STIKes FLORA. Kemudian melanjutkan Pendidikan Profesi Bidan di STIKes SENIOR Medan selesai pada tahun 2023. Saat ini penulis aktif melaksanakan Tridarma perguruan Tinggi dan pengabdian masyarakat serta mengikuti kegiatan-kegiatan seminar dan *workshop* untuk menambah wawasan dan informasi-informasi yang *up to date* sebagai wujud menjalankan tugas Tri Darma Pendidikan Tinggi di STIKes Flora, dan bertujuan membagi ilmu dan lebih terkhusus di dalam bidang kebidanan dan yang lainnya.
Email: desihandayanilubis84@gmail.com



Bd. Atika Pohan, SST, M.KM Lahir di Tanjungbalai, 10 Juni 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi D-IV Bidan Pendidik, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS. Haji Medan tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Sari Mutiara Indonesia dan lulus tahun pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007, dan sampai saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan As Syifa Kisaran.

Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, penulis terlibat sebagai dosen mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Promosi Kesehatan, Asuhan Kebidanan Pra Nikah dan Pra Konsepsi, dan pengembang bahan ajar. Dalam bidang penelitian, penulis telah menulis dan menerbitkan beberapa buku, artikel ilmiah pada jurnal nasional maupun internasional, serta aktif dalam lokakarya ilmiah. Selain itu, penulis juga terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan bidang keahlian yang dimiliki.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: atikapohan7@gmail.com

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Kehamilan Risiko Tinggi dan Manajemen Kebidanan Berbasis Bukti hadir sebagai sebuah karya ilmiah yang menghimpun pemikiran, kajian, dan hasil penelitian dari berbagai akademisi serta praktisi kebidanan. Buku ini berfokus pada isu krusial dalam pelayanan kesehatan maternal, yaitu kehamilan risiko tinggi yang masih menjadi penyumbang terbesar terhadap angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi, baik di tingkat nasional maupun global.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan uraian komprehensif mengenai definisi, klasifikasi, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kehamilan risiko tinggi. Setiap bab mengupas secara mendalam tanda dan gejala klinis, metode identifikasi, serta pendekatan manajemen kebidanan yang sesuai dengan standar praktik berbasis bukti. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membekali tenaga kesehatan dengan strategi praktis dalam menangani berbagai kondisi yang berpotensi membahayakan ibu maupun janin.

Keunggulan buku ini terletak pada integrasi teori dengan praktik terkini, disertai pendekatan interprofesional yang menekankan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Penulisannya mengacu pada penelitian terbaru dalam lima tahun terakhir, sehingga isi buku selalu relevan dengan perkembangan ilmu kebidanan modern. Selain itu, buku ini juga memperhatikan konteks pelayanan di Indonesia, menjadikannya referensi yang kontekstual sekaligus universal.

Buku Bunga Rampai Kehamilan Risiko Tinggi dan Manajemen Kebidanan Berbasis Bukti ditujukan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya yang berfokus pada pelayanan maternal. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi rujukan akademik, sumber inspirasi, sekaligus panduan praktis untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Dengan pendekatan berbasis bukti, buku ini mendukung tercapainya pelayanan kesehatan maternal yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.

Buku Bunga Rampai Kehamilan Risiko Tinggi dan Manajemen Kebidanan Berbasis Bukti hadir sebagai sebuah karya ilmiah yang menghimpun pemikiran, kajian, dan hasil penelitian dari berbagai akademisi serta praktisi kebidanan. Buku ini berfokus pada isu krusial dalam pelayanan kesehatan maternal, yaitu kehamilan risiko tinggi yang masih menjadi penyumbang terbesar terhadap angka kesakitan dan kematian ibu serta bayi, baik di tingkat nasional maupun global.

Dalam buku ini, pembaca akan menemukan uraian komprehensif mengenai definisi, klasifikasi, serta faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kehamilan risiko tinggi. Setiap bab mengupas secara mendalam tanda dan gejala klinis, metode identifikasi, serta pendekatan manajemen kebidanan yang sesuai dengan standar praktik berbasis bukti. Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga membekali tenaga kesehatan dengan strategi praktis dalam menangani berbagai kondisi yang berpotensi membahayakan ibu maupun janin.

Keunggulan buku ini terletak pada integrasi teori dengan praktik terkini, disertai pendekatan interprofesional yang menekankan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Penulisannya mengacu pada penelitian terbaru dalam lima tahun terakhir, sehingga isi buku selalu relevan dengan perkembangan ilmu kebidanan modern. Selain itu, buku ini juga memperhatikan konteks pelayanan di Indonesia, menjadikannya referensi yang kontekstual sekaligus universal.

Buku Bunga Rampai Kehamilan Risiko Tinggi dan Manajemen Kebidanan Berbasis Bukti ditujukan bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya yang berfokus pada pelayanan maternal. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi rujukan akademik, sumber inspirasi, sekaligus panduan praktis untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Dengan pendekatan berbasis bukti, buku ini mendukung tercapainya pelayanan kesehatan maternal yang aman, berkualitas, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7426-13-0



9

786347

426130